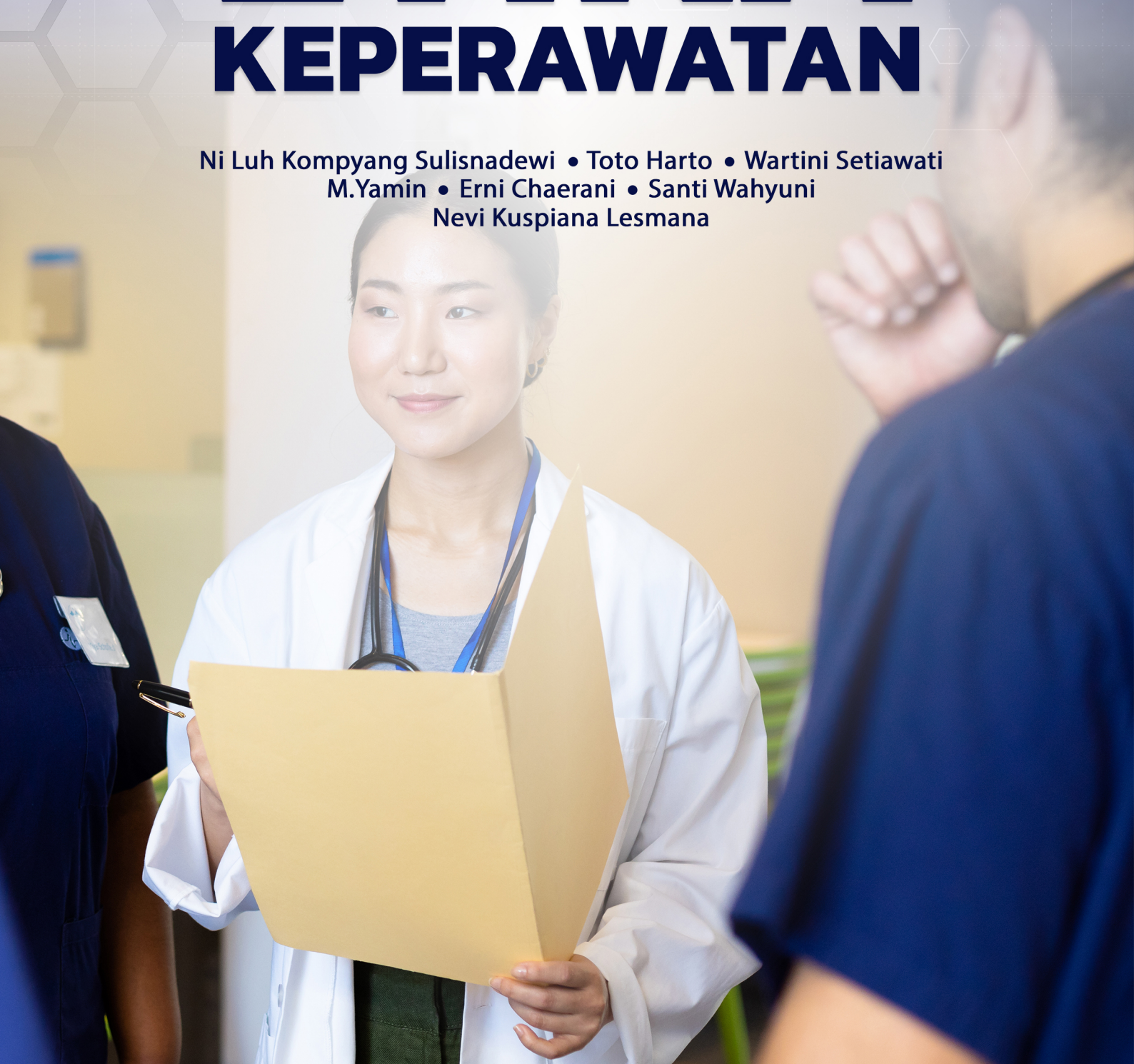


Buku Ajar

ETIKA KEPERAWATAN

Ni Luh Kompyang Sulisnadewi • Toto Harto • Wartini Setiawati
M.Yamin • Erni Chaerani • Santi Wahyuni
Nevi Kuspiana Lesmana



BUKU AJAR: ETIKA KEPERAWATAN

Penulis:

Ns. Ni Luh Kompyang Sulisnadewi, M.Kep., Sp.Kep.An.

Toto Harto, SKM., M.K.M.

Wartini Setiawati S.Kep., Ners., M.Kep.

Ns. M.Yamin, S.Kep., SKM., M.Kes..

Erni Chaerani, S.Pd., S.Kep., MKM

Santi Wahyuni, SKp., M.Kep., Sp.Mat.

Ns. Nevi Kuspiana Lesmana, M.Kep.



Buku Ajar: Etika Keperawatan

Penulis: Ns. Ni Luh Kompyang Sulisnadewi, M.Kep., Sp.Kep.An.

Toto Harto, SKM., M.K.M.

Wartini Setiawati S.Kep., Ners., M.Kep.

Ns. M.Yamin, S.Kep., SKM., M.Kes..

Erni Chaerani, S.Pd., S.Kep., MKM

Santi Wahyuni, SKp., M.Kep., Sp.Mat.

Ns. Nevi Kuspiana Lesmana, M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7294-37-1

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku ajar "Etika Keperawatan" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun untuk memenuhi kebutuhan referensi akademik bagi mahasiswa keperawatan serta praktisi keperawatan di Indonesia dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etik, moral, dan legal dalam praktik sehari-hari.

Buku ajar ini terdiri dari beberapa pokok bahasan penting yang mencakup konsep nilai, norma, etik, dan moral yang menjadi dasar dalam membentuk sikap profesional perawat. Selanjutnya, pembaca akan diajak mendalami aspek legal dalam keperawatan serta sistem kredensial yang berlaku di Indonesia, yang merupakan landasan hukum bagi profesi ini.

Penjelasan mengenai tahapan penyelesaian masalah etik dalam keperawatan disajikan secara sistematis, dilengkapi dengan contoh kasus nyata yang dapat membantu pembaca dalam menghadapi dan mengatasi berbagai dilema etik yang muncul di lapangan. Buku ini juga secara khusus mengupas hak dan tanggung jawab perawat menurut Undang-Undang yang berlaku, serta pentingnya memahami Kode Etik Keperawatan Indonesia sebagai panduan berperilaku bagi setiap perawat.

Tidak kalah penting, buku ini membahas hukum kesehatan dan keperawatan yang relevan serta hak dan kewajiban pasien yang perlu diketahui oleh setiap perawat guna memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan berkeadilan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi, dan semua pihak yang berkecimpung di bidang keperawatan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan edisi berikutnya.

Semoga buku ini memberikan manfaat nyata bagi perkembangan ilmu dan praktik keperawatan di Indonesia.

Juni, 2025

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	iv
------------------------	-----------

BAB 1 KONSEP NILAI, NORMA, ETIK DAN MORAL 1

A. Nilai.....	3
B. Norma.....	7
C. Etik.....	9
D. Moral.....	12
E. Latihan	13
F. Kunci Jawaban.....	15
G. Rangkuman Materi.....	15
H. Glosarium	15
I. Daftar Pustaka	16

BAB 2 ASPEK LEGAL DAN SISTEM KRIDENSIAL PERAWAT INDONESIA 19

A. Konsep Dasar Aspek Legal dalam Praktik Keperawatan	21
B. Proses Sistem Kredensial Perawat di Indonesia.....	22
C. Pentingnya Sistem Kredensial dalam Keperawatan	24
D. Risiko Hukum dan Strategi Pencegahannya dalam Praktik Keperawatan	26
E. Strategi Pencegahan Risiko Hukum dalam Praktik Keperawatan	27
F. Latihan soal.....	28
G. Rangkuman Materi.....	29
H. Glosarium	30
I. Daftar pustaka	32

BAB 3 TAHAPAN PENYELESAIAN MASALAH ETIK DALAM KEPERAWATAN. 33

A. Tahapan Penyelesaian Masalah Etik dalam Keperawatan	34
B. Latihan Soal.....	35
C. Rangkuman materi	37
D. Glosarium	38
E. Daftar pustaka	39

BAB 4 HAK DAN TANGGUNG JAWAB PERAWAT MENURUT UNDANG-UNDANG 41

A. Pengertian Hak.....	43
B. Jenis-Jenis hak.....	43
C. Tanggung Jawab/Kewajiban.....	44
D. Hak dan Tanggung Jawab Perawat Menurut Undang-Undang.....	45
E. Tugas dan Wewenang Perawat secara Perorangan.....	48
F. Wewenang Perawat Sebagai Pemberi Asuhan Keperawatan Di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	49
G. Wewenang Perawat Sebagai Penyuluh dan Konselor.....	49
H. Wewenang Perawat Sebagai Pengelola Pelayanan Keperawatan.....	50
I. Wewenang Perawat Sebagai Peneliti Keperawatan.....	50
J. Wewenang Perawat dalam Keadaan Darurat	50
K. Latihan	51
L. Kunci Jawaban.....	52
M. Rangkuman Materi.....	52
N. Glosarium	52
O. Daftar Pustaka	52

BAB 5 KODE ETIK KEPERAWATAN INDONESIA..... 53

A. Pengertian Kode Etik Keperawatan Indonesia	56
B. Tujuan Kode Etik Keperawatan Indonesia.....	59
C. Fungsi Kode Etik Profesi	60
D. Sejarah Perkembangan Kode Etik Keperawatan Indonesia	61
E. Isi Kode Etik Keperawatan Indonesia	65
F. Perilaku Perawat sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan Indonesia.....	68
G. Kode Etik Keperawatan Menurut International Council Nursing (ICN)	73
H. Kode Etik Keperawatan Menurut American Nurses Association (ANA).....	74
I. Latihan	78
J. Kunci Jawaban.....	79
K. Soal Essay	79
L. Rangkuman Materi.....	80
M. Glosarium	80
N. Daftar Pustaka	83

BAB 6 HUKUM KESEHATAN DAN KEPERAWATAN.....85

A. Definisi Hukum Kesehatan	86
B. Tujuan Hukum Kesehatan.....	87
C. Perlindungan Hukum Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan.....	87
D. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan.....	88
E. Hukum Keperawatan	89
F. Fungsi Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Keperawatan.....	90
G. Dasar Hukum keperawatan di Indonesia.....	91
H. Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia Dan Majelis Disiplin Profesi (MDP)	92
I. Tugas dan Wewenang Konsil Kesehatan Indonesia.....	94
J. Latihan Soal.....	94
K. Kunci Jawaban	95
L. Rangkuman Materi	96
M. Glosarium	96
N. Daftar Pustaka	96

BAB 7 HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN.....99

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Pasien.....	101
B. Peranan Hak.....	101
C. Jenis-Jenis Hak.....	102
D. Syarat Yang Mempengaruhi Hak Seseorang.....	103
E. Hak dan Kewajiban Pasien.....	103
F. Latihan	105
G. Kunci Jawaban	107
H. Rangkuman Materi.....	107
I. Glosarium	108
J. Daftar Pustaka	108

PROFIL PENULIS 109

BAB 1

KONSEP NILAI, NORMA, ETIK DAN MORAL

Pendahuluan

Pelayanan kesehatan sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, dimana tenaga kesehatan setiap melakukan Tindakan akan memiliki dampak besar baik untuk perawat sendiri dan masyarakat. Setiap melaksanakan kegiatan Praktik Keperawatan yaitu Asuhan Keperawatan nantinya akan dihadapkan dengan dilema etik dan hukum, dimana dalam melaksanakan asuhan keperawatan membutuhkan pertimbangan yang matang. Seorang perawat dalam menjalankan profesinya wajib memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dari etik, dimana etika dan hukum kesehatan merupakan aspek fundamental dalam dunia medis dan pelayanan kesehatan. Seorang perawat juga dituntut memiliki keterampilan klinis yang baik sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang telah di atur. Pemahaman tentang konsep nilai, norma, etik dan moral adalah kunci utama dalam mengambil keputusan yang berlandaskan atas dasar kepentingan pasien dan sesuai dengan standar profesi. Untuk mencapai pelayanan yang aman, efektif, tepat, dan bermartabat oleh perawat kepada pasien, seorang perawat harus mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, dan menghormati hak pasien. Selain itu, pemahaman seorang perawat tentang etika diperlukan seiring dengan kemajuan dalam bidang medis agar praktik keperawatan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui buku ajar ini, diharapkan mahasiswa memahami bagaimana norma, nilai, etika dan moral membentuk sikap profesional seorang perawat, dimana seorang perawat akan siap menghadapi berbagai masalah di dunia kesehatan dan membuat keputusan yang sesuai dengan hukum dan prinsip etika.

Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan akan nilai, norma, etik dan moral dalam melaksanakan asuhan keperawatan.

Tujuan Instruksional Khusus:

- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Nilai
- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Norma
- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Etik
- Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Moral

Capaian Pembelajaran:

- Mahasiswa sanggup memperlihatkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung nilai kemanusiaan, etik, hukum, moral, dan budaya dalam memberikan asuhan keperawatan.
- Mahasiswa sanggup menyampaikan asuhan keperawatan baik pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari konsep dari nilai, norma, etik dan moral.

A. Nilai

1. Pengertian

Nilai, juga dikenal sebagai "value", adalah keyakinan yang mendasari sikap dan perilaku seseorang. Dalam praktik keperawatan, nilai menggambarkan prinsip dan harapan ideal. Dalam suatu organisasi, sistem nilai terdiri dari kumpulan prinsip-prinsip yang dianggap penting dan perilaku individu yang ditunjukkan. Nilai sama dengan sesuatu/ objek yang berharga, yang dianut oleh seseorang sesuai kebutuhan hati nurani seseorang. Nilai didefinisikan sebagai keyakinan dari seseorang mengenai sesuatu yang penting, kebenaran, atau keyakinan tentang ide-ide, objek, atau perilaku tertentu (Znowski) (Mangara et al., 2021).

Poerwadarminta mengatakan nilai merupakan hal-hal yang penting ataupun bermanfaat bagi manusia, seperti nilai agama yang harus diindahkan. Menurut Hans Jonas, seorang filsuf Jerman-Amerika, menjelaskan nilai sebagai sesuatu yang diarahkan dengan "ya" dan memiliki konotasi yang positif, dan memiliki konotasi negative yang harus dihindari (Sumijatun, 2011). Nilai merupakan suatu kepercayaan personal mengenai suatu ide dan tingkah laku, serta kebiasaan yang mengatur standar serta dapat berdampak pada tingkah laku. Nilai adalah kepercayaan yang mendorong seorang dalam melakukan sesuatu, yang kemudian menjadi standar untuk tindakan berikutnya. Nilai juga mencakup membangun dan mempertahankan sikap terhadap hal-hal yang terkait, penilaian moral pada diri sendiri dan orang lain, dan perbandingan antara diri sendiri dan orang lain. Orang yang memiliki nilai tertentu akan dipilih, diterima, dibenarkan dan diutamakan. Kognitif, selektif, afektif, dan tindakan adalah bagian dari evaluasi. Kapasitas dan unik manusia untuk mengalami nilai yang memuaskan akan memberi mereka kekuatan untuk mengulangi dan memperluas nilai-nilai yang memuaskan tersebut melalui penemuan, gaya hidup, dan tingkah laku inovatif (Potter & Perry, 1997).

Nilai merupakan keyakinan dan sikap dari pribadi seorang yang berharga, mengenai kebenaran, keindahan dan penghargaan dari suatu perilaku, objek, maupun pemikiran seseorang yang berfokus pada tindakan mengenai ide- ide, ataupun perilaku khusus (Asnuriyati & Mawarni, 2021). Manusia mengembangkan seperangkat nilai- nilai yang bertujuan untuk mengatasi masalah- masalah kehidupan yang umum terjadi. Seorang perawat harus menetapkan nilai untuk meningkatkan kesadaran tentang sistem nilai yang

mereka miliki, yang diharapkan akan mempengaruhi perawatan yang mereka berikan kepada klien (Sumijatun, 2011).

2. Fungsi

Nilai menurut Hamilton, 1992, Nilai bermanfaat sebagai penapis untuk berbagi pengalaman dan hubungan yang dialami manusia setiap hari. Melalui observasi, pertimbangan dan pengalaman, nilai dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang dalam mengambil keputusan (Asman et al., 2022).

Menurut Asnuriyati & Mawarni, 2021, Perawat profesional dalam melaksanakan praktik, diperlukan nilai sesuai kode etik profesional, yaitu:

- a. Menghargai martabat seseorang tanpa prasangka
- b. Menjaga privasi seseorang
- c. Bertanggung jawab atas segala tindakannya

Perawat Profesional dalam Mangara et al., 2021, dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk menghargai hak privasi pasien, diantaranya yaitu:

- a. Menutup area mandi dan pengobatan
- b. Menutup pasien untuk prosedur tertentu, dan
- c. Menyediakan tempat konsultasi untuk pasien dengan pemuka agama atau anggota keluarga yang mengalami kesedihan.

3. Kriteria

Menurut teori klarifikasi nilai- nilai, keyakinan atau sikap dapat dianggap nilai. Menurut Mangara et al., 2021, Jika memenuhi tujuh persyaratan berikut:

- a. Menjunjung dan menghargai keyakinan dan perilaku seseorang
- b. Menegaskannya di depan umum, apabila cocok
- c. Memilih dari berbagai pilihan
- d. Memilih setelah memikirkan akibatnya
- e. Memilih secara bebas
- f. Bertindak
- g. Bertindak dengan pola konsistensi

4. Nilai- Nilai yang diperlukan oleh Seorang Perawat

Potter & Perry, 2009, dalam Asnuriyati & Mawarni, 2021, menguraikan Nilai/ Prinsip yang dianut oleh seorang perawat, diantaranya adalah:

- a. Kejujuran

Kejujuran adalah keyakinan bahwa orang yang memberikan layanan kesehatan harus memberi tahu akan kebenaran kepada pasien dan membantu mereka memahaminya. Prinsip kebenaran berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Ini adalah prinsip yang diperlukan oleh pemberi layanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran kepada setiap pasien dan memastikan bahwa pasien benar- benar mengerti. Untuk memudahkan

pemahaman dan penerimaan materi saat ini, informasi harus akurat, komprehensif, dan tujuan. Selain itu, informasi harus memberi tahu klien yang sebenarnya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisinya selama perawatan. Meskipun demikian, beberapa orang berpendapat bahwa kejujuran terbatas, seperti jika prognosis pemulihan klien benar atau jika ada hubungan paternalistik yang mengatakan bahwa "dokter tahu paling baik" karena pasien memiliki otonomi dan berhak untuk mendapatkan informasi tentang kondisi mereka secara menyeluruh. Kebenaran adalah kunci untuk membangun hubungan yang saling percaya.

b. *Care*

Caring secara universal merupakan cara setiap orang berfikir, merasakan, dan memiliki hubungan dengan sesama. Dalam keperawatan *caring* membantu perawat dalam melaksanakan intervensi yang baik. Menurut Florence Nightingale dimana *caring* merupakan kemampuan untuk berkomitmen, mengawasi dengan cermat, merasa empati dengan orang lain dan memiliki rasa cinta ataupun penyayang.

Watson, mengasumsikan *caring* kedalam 7 konsep yaitu:

- 1) *Caring* lebih efektif jika diimplementasikan secara interpersonal
- 2) *Caring* memiliki komponen karatif yang diperoleh dari kepuasan dalam membantu memenuhi kebutuhan klien
- 3) *Caring* dapat meningkatkan Kesehatan baik individu maupun keluarga
- 4) *Caring* merupakan respon yang diterima bukan saat itu saja namun memengaruhi bagaimana kedepannya
- 5) *Caring* dapat mempengaruhi bagaimana lingkungan dapat mendukung dan mempengaruhi pilihan tindakan untuk dirinya sendiri
- 6) Praktik *caring*, yang menggabungkan pengetahuan biofisik dan perilaku manusia, digunakan untuk meningkatkan Kesehatan dan membantu klien yang sakit. *Caring* sangatlah berperan dalam keperawatan.

c. *Empati*

Suatu usaha bagaimana seseorang dapat menempatkan diri sehingga dapat memahami perasaan orang atau klien. Empati tidak sama seperti simpati, simpati lebih mendorong sikap perasaan terhadap suatu hal, dimana tidak lagi berfikir secara objektif, sehingga seorang perawat tidak seharusnya memiliki sikap simpati. Rasa empati dan memberikan senyuman merupakan multivitamin yang ditimbulkan dari seorang perawat untuk klien sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada klien. Perawat harus peka terhadap keadaan klien, bukan hanya kondisi fisik namun kondisi psikisnya juga.

d. Ketepatan setiap Tindakan

Beneficence merupakan melakukan hal-hal yang positif, kebaikan, memerlukan penegakan dari pelanggaran atau kejahatan orang lain, dengan kata lain mengajarkan hal yang baik. Terkadang situasi ini menjadi konflik dengan otonomi dalam menjalankan pelayanan Kesehatan.

e. Altruisme

Perilaku peduli dan kesejahteraan orang lain dalam menjalankan Tindakan keperawatan, diantaranya memberikan perhatian, komitmen, prinsip mempertahankan janji, rasa iba, kemurahan hati, dan adanya ketekunan. Seorang perawat yang memiliki nilai baik dalam menjalankan implementasi keperawatan akan menggunakan metode keperawatan dan keterampilan yang baik dalam melaksanakan asuhan keperawatan secara efektif.

f. Otonomi

Suatu kemampuan untuk berfikir logis dan dapat membuat keputusan yang didasarkan pada prinsip individu. Prinsip otonomi merupakan bentuk menerima seseorang, yang digambarkan sebagai persetujuan yang tidak memaksa dan bertindak secara rasional. Hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan dirinya yang dihargai oleh perawat dalam pekerjaan mereka sebagai perawat profesional.

g. Keadalian

Merupakan keadilan terhadap orang yang mempertahankan nilai moral, hukum, dan kemanusiaan. Ketika perawat memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan ketentuan hukum, standar praktik dan keyakinan yang benar untuk mencapai kualitas pelayanan Kesehatan, nilai ini diterapkan.

Nilai-nilai profesional menurut *American Association of Colleges of Nursing*, Tahun 2008, dimana Nilai-nilai professional ini melambangkan perawat yang peduli dan profesional. Perawat, yang dituntun oleh nilai-nilai ini, menunjukkan perilaku etis dalam perawatan pasien, diantaranya:

- a. Altruisme (*Altruism*) adalah kepedulian terhadap kesejahteraan dan kesejahteraan orang lain. Dalam praktik profesional, altruisme tercermin dari kepedulian dan advokasi perawat terhadap kesejahteraan pasien, perawat lain, dan penyedia layanan kesehatan lainnya.
- b. Otonomi (*Autonomy*) adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Praktik profesional mencerminkan otonomi ketika perawat menghormati hak-hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan kesehatan mereka.
- c. Martabat Manusia (*Human Dignity*) adalah rasa hormat terhadap nilai dan keunikan yang melekat pada individu dan populasi. Dalam praktik profesional,

kepedulian terhadap martabat manusia tercermin ketika perawat menghargai dan menghormati semua pasien dan kolega.

- d. Integritas (*Integrity*) adalah bertindak sesuai dengan kode etik yang sesuai dan standar praktik yang diterima. Integritas tercermin dalam praktik profesional ketika perawat bersikap jujur dan memberikan perawatan berdasarkan kerangka kerja etis yang diterima dalam profesi.
- e. Keadilan Sosial (*Social Justice*) adalah bertindak sesuai dengan perlakuan yang adil tanpa memandang status ekonomi, ras, etnis, usia, kewarganegaraan, kecacatan, atau orientasi seksual.

B. Norma

1. Pengertian

Norma dalam kamus besar Bahasa Indonesia merupakan “aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima” (*Norma*, n.d.). Sarwono (2002), mendefinisikan Norma sebagai orang mau menolong orang lain karena diharuskan oleh norma- norma masyarakat. Terdapat tiga macam norma sosial yang biasanya dijadikan pedoman dalam berperilaku menolong diantaranya norma timbal balik (*reciprocity norm*), norma tanggung jawab sosial (*social responsibility norm*), dan norma keseimbangan (*harmonic norm*) (Sumijatun, 2011). Sedangkan, Norma menurut Subroto, Tahun 2021, merupakan aturan yang digunakan untuk mengukur tindakan manusia, termasuk hal- hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, hal- hal yang benar dan salah, dan hal- hal yang baik dan buruk.

Deviasi adalah penyimpangan dari norma atau prinsip masyarakat, sedangkan pelaku penyimpangan disebut devian (*deviant*). Konformitas merupakan kebalikan dari perilaku menyimpang. Konformitas terjadi ketika seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok (Mangara et al., 2021).

2. Fungsi Norma dalam Masyarakat

- a. Norma dapat berfungsi sebagai pedoman dan aturan dalam berkehidupan masyarakat
- b. Norma dapat menciptakan keteraturan dan stabilitas dalam berkehidupan masyarakat
- c. Norma berfungsi sebagai dasar untuk memberikan hukuman kepada orang yang melanggar
- d. Norma dapat menciptakan keterlibatan dan keadilan dalam masyarakat
- e. Norma akan membantu semua lapisan masyarakat mencapai tujuan bersama (Nurohmat & Ruswadi, 2021).

3. Ciri- Ciri Norma

- a. Norma biasanya tidak tertulis, kecuali norma hukum
- b. Norma bersifat mengikat dan memiliki sanksi
- c. Norma adalah kesepakatan anggota masyarakat
- d. Anggota masyarakat harus mematuhi norma yang berlaku
- e. Anggota masyarakat dapat dikenakan sanksi jika melanggar norma
- f. Norma dapat berubah seiring perkembangan masyarakat (Nurohmat & Ruswadi, 2021).

4. Macam- Macam Norma dalam Masyarakat

Pendapat yang dijelaskan oleh C.J.T. Kansil dalam Nurohmat & Ruswadi, Tahun 2021, Norma dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Norma Agama
- b. Norma Kesusilaan
- c. Norma Kesopanan
- d. Norma Hukum
- e. Norma Kebiasaan
- f. Norma Sosial.

5. Hubungan Nilai dan Norma

Nilai adalah sesuatu yang benar atau bermakna yang berhubungan dengan cita-cita, harapan dan keyakinan. Nilai- nilai ini dapat diwujudkan dengan norma, yaitu aturan berupa perintah dan larangan yang didasarkan pada nilai yang dianggap baik, bermanfaat, serta dijunjung tinggi. Misalnya, kebenaran adalah nilai, sedangkan kebohongan adalah larangan, kejujuran adalah nilai sedangkan kebohongan adalah larangan.

Merumuskan Nilai Sebagai Sumber Norma

- a. Nilai adalah sesuatu yang membuat dirinya sendiri.
- b. Norma Agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan menyebabkan penyiksaan di neraka
- c. Norma Kesusilaan bersumber dari Hati Nurani dan menyebabkan merasa bersalah/ berdosa
- d. Norma Kesopanan bersumber dari Masyarakat dan menyebabkan dikucilkan, bahkan diasingkan
- e. Norma Hukum bersumber dari Negara dan menyebabkan Kurungan Penjara

Jika dia mematuhi hukum yang berlaku, tidak berbuat semena-mena, dan berperilaku baik kepada orang lain, maka dia bernilai. Agama, kesopanan, dan hukum memiliki aturan atau standar, sehingga seseorang dikatakan bernilai jika ia mematuhi. Nilai terdiri dari tiga kategori: 1. Nilai material mengacu pada

segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia; 2. Nilai vital mengacu pada segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia untuk melakukan sesuatu; dan 3. Nilai kerohanian mengacu pada segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan rohani manusia.

Nilai adalah sesuatu yang baik, diinginkan, dicita-citakan, dan dipentingkan oleh , sedangkan norma masyarakat adalah kaidah atau pedoman, aturan berperilaku untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita tersebut. Pola yang diinginkan disebut nilai, sedangkan norma adalah cara untuk mencapai nilai tersebut (Nurohmat & Ruswadi, 2021).

C. Etik

1. Pengertian

Etik menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat (*Etik*, n.d.). Etika adalah norma atau segala aturan yang berlaku di masyarakat dimana objeknya adalah manusia dan kelakuannya (Nurohmat & Ruswadi, 2021). Menurut Mangara et al., Tahun 2021, etika merupakan bidang studi tentang moralitas yang mengatur bagaimana manusia harus hidup bersama. Etika mencakup prinsip atau aturan yang menentukan apa yang baik dan buruk, serta siapa yang memiliki atau tidak memiliki tanggungjawab apapun. Etika dalam asuhan keperawatan secara tradisional dibahas dalam kaitannya dengan norma atau prinsip moral. Ketika mengambil pendekatan ontologis terhadap etika, etika adalah tentang etos. Etos melibatkan sisi internal dan eksternal etika. Mempertimbangkan etika dan kesehatan dari perspektif ontologis dapat memberikan pemahaman yang berbeda tentang etika dan kesehatan dalam perawatan dan keperawatan (Östman et al., 2019).

2. Tipe Etik

Etik dibagi kedalam 2 jenis tipe menurut Nasrullah, 2019 dan Suhaemi, 2003 dalam Riskika et al., Tahun 2022, yaitu Bioetik, Etik klinik, dan Etik Keperawatan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bioetik, merupakan suatu filosofi yang mempelajari tentang kontroversi dalam etik yang menyangkut masalah biologi dan pengobatan serta difokuskan lebih secara spesifik pada evaluasi etik pada moralitas *treatment* tertentu dan inovasi teknologi yang dikembangkan dan pelaksanaan *treatment* ini dilakukan pada manusia, artinya hal ini berfokus pada perawatan modern dan aplikasi pada aplikasi teori dan prinsip etik terhadap masalah pelayanan kesehatan.

- b. Etik Klinik (*Clinical ethics*), merupakan bagian dari bioetik yang lebih berfokus pada masalah etik selama pemberian pelayanan pada klien, misalnya pemberian persetujuan dan penolakan terhadap Tindakan.
- c. Etik Keperawatan (*Nursing ethics*), merupakan bagian dari bioetik yang merupakan studi formal tentang isu etik pada keperawatan dan dikembangkan dalam Tindakan keperawatan serta dievaluasi dan dianalisis untuk pengambilan keputusan etik.

3. Karakteristik Etika

Etika dibedakan dari berbagai jenis norma, antara lain:

- a. Etika akan terus berjalan meskipun tidak ada yang melihatnya.
- b. Norma ini bersifat mutlak.
- c. Etika melihat ke dalam batin manusia.
- d. Etika sangat berkaitan dengan tindakan atau perilaku manusia (Nurohmat & Ruswadi, 2021).

4. Jenis-Jenis Etika

Ada dua jenis etika: etika Filosofis dan Teologis. Jenis Etika Filosofis yang berkaitan dengan Tindakan dan cara berpikir manusia. Etika Filosofis terbagi menjadi Empiris dan Non-Empiris. Empiris membahas tentang sesuatu yang ada yang merupakan cabang dari ilmu filsafat, sedangkan Non-Empiris, merupakan sesuatu yang berusaha untuk melalui sesuatu yang sudah ada contohnya menanyakan hal yang ada dibalik semua gejala permasalahan yang sudah ada. Etika Teologis merupakan jenis etika yang berasal dari asumsi, yaitu asumsi mengenai Allah. Setiap agama mempunyai Etika teologis masing-masing (Nurohmat & Ruswadi, 2021).

5. Tujuan Etika Keperawatan

Tujuan tertentu Etika keperawatan untuk perawat itu sendiri, dan bagi pasien yang merasakan dari pelayanan yang diberikan. Pada dasarnya tujuan dari etika yaitu memberikan perlindungan agar para perawat dapat menghargai atau menghormati martabat manusia saat menjalankan tugas dan fungsi mereka. Tujuan umum dari etika keperawatan adalah untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan antara perawat dan klien mereka, perawat dengan klien mereka, perawat dengan profesi lain, dan perawat dengan masyarakat (Utami et al., 2016).

6. Fungsi Etika Keperawatan

Etika diperlukan tidak hanya untuk perawat, tetapi juga semua orang yang menikmati layanan keperawatan, diantaranya:

- a. Seorang yang mengelola asuhan keperawatan bersikap memperlihatkan sikap kepemimpinan dan bertanggung jawab.

- b. Mendorong para perawat di Indonesia untuk berpartisipasi dalam penelitian dan menggunakan hasil temuan penelitian tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- c. Mengajukan para perawat untuk berpartisipasi serta secara aktif dalam memberikan edukasi serta Tindakan keperawatan kepada pasien agar pasien hidup sehat secara mandiri, baik di rumah sakit maupun di luar rumah sakit.
- d. Mengajukan para perawat untuk terus berkembang sehingga mereka dapat meningkatkan kompetensi profesional, integritas serta loyalitas kepada masyarakat.
- e. Mengajukan para perawat untuk mempertahankan dan menanamkan sikap dan karakter yang setara dengan etika keperawatan saat mereka bekerja.
- f. Mengajukan para perawat sebagai anggota masyarakat yang tanggap, kreatif, toleran, terhadap perubahan dan menitikberatkan pandangan mereka sesuai dengan pekerjaan (Utami et al., 2016).

7. Prinsip Etik Keperawatan

Prinsip etika keperawatan dapat dikategorikan secara luas menjadi empat prinsip etika keperawatan utama:

- a. **Autonomy:** Hak untuk menentukan nasib sendiri. Otonomi dalam keperawatan berarti menyediakan informasi yang memadai untuk memungkinkan pasien membuat keputusan sendiri berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai mereka, meskipun bukan keputusan yang dipilih oleh perawat. Otonomi juga berkaitan dengan pemberian perawatan keperawatan hanya dalam lingkup praktik yang ditetapkan oleh peraturan negara bagian dan organisasi. Contoh otonomi dalam keperawatan meliputi pemberian obat-obatan PRN atau penugasan tugas keperawatan berdasarkan tingkat kompetensi.
- b. **Beneficence:** Promosi kebaikan. Beneficence/ kederawatan dalam keperawatan berkaitan dengan memastikan bahwa kepentingan terbaik pasien dipertimbangkan, terlepas dari pendapat pribadi perawat. Contoh kederawatan dalam keperawatan termasuk memberikan kenyamanan kepada pasien yang sekarat atau membantu tugas yang tidak dapat dilakukan pasien secara mandiri.
- c. **Justice:** Keadilan atau pemerataan manfaat. Keadilan dalam keperawatan berkaitan dengan kenetralan terkait usia, suku bangsa, status ekonomi, agama, atau orientasi seksual pasien. Contoh keadilan dalam keperawatan meliputi kenetralan saat menetapkan perawatan klinis atau memprioritaskan perawatan pasien.
- d. **Nonmaleficence:** Penghindaran atau minimalisasi bahaya. Nonmaleficence dalam keperawatan mengharuskan penyediaan perawatan yang aman, efektif,

dan berkualitas tinggi. Contoh nonmaleficence dalam keperawatan termasuk menahan obat karena reaksi yang merugikan atau mengambil langkah-langkah untuk memastikan lingkungan kerja yang aman (American Nurses Association, 2023)

D. Moral

1. Pengertian

Istilah kata moral berasal dari baha latin yaitu “mos – bentuk tunggal, mores – bentuk jamak” yang berarti kebiasaan atau adat (Hasyim & Prasetyo, 2019). Moral mengarah pada perbuatan manusia yang di nilai baik dan buruk. Kata moral lebih dilekat dengan moralitas. Menurut Bertens Tahun 2002 dalam Handayani, Tahun 2019, Moralitas merupakan sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Moral merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya (*Mora*l, n.d.). Moral adalah sebuah kesesuaian antara perbuatan dengan peraturan yang berlaku di ranah sosial, ataupun menyangkut hukum atau adat istiadat yang mengatur tingkah laku manusia (Riskika et al., 2022). Jika hati Nurani ingin membisikkan sesuatu yang benar, maka norma akan membantu mencari kebaikan moral. Ada dua cara untuk mengukur moral: secara subyektif, yang diberikan oleh hati Nurani, secara obyektif, yang diberikan oleh norma yang berlaku (Hasyim & Prasetyo, 2019).

2. Ciri- Ciri Nilai Moral

Nilai moral tampak seperti nilai baru, bahkan sebagai nilai yang paling tinggi, namun nilai moral tidak berdiri sendiri dan berada diatas nilai lainnya. Nilai moral memiliki ciri- ciri sebagai berikut:

- a. Berhubungan dengan tanggung jawab
- b. Berhubungan dengan hati Nurani
- c. Mewajibkan
- d. Formal
- e. Berdasarkan Norma moral (Mangara et al., 2021).

3. Pendekatan dalam Filosofi Moral

Menurut Routledge Tahun 2020, Filosofi moral atau klasifikasi etika dibagi menjadi empat pendekatan atau subtopik meliputi:

- a. Meta-etika bertujuan memahami sifat evaluasi etis, asal usul prinsip- prinsip etika dan arti istilah yang digunakan tetapi bebas nilai.
- b. Etika deskriptif melibatkan. Misalnya dalam menentukan proporsi populasi atau kelompok tertentu yang menganggap sesuatu itu benar atau salah.

- c. Etika normatif atau sering disebut sebagai teori moral, berfokus pada bagaimana nilai- nilai moral ditentukan, apa yang membuat sesuatu menjadi benar atau salah, dan apa yang harus dilakukan.
- d. Etika terapan memeriksa isu- isu kontroversial seperti euthanasia, aborsi dan hukuman mati dan menerapkan teori etika pada situasi kehidupan nyata. Isu- isu etika terapan adalah isu- isu yang jelas merupakan isu- isu moral dan di mana terdapat kelompok- kelompok orang yang signifikan yang mendukung atau menentang (Hijriana, 2023).

4. Kaitan tentang Moral

Moralitas adalah sifat moral, atau keseluruhan asas dan nilai yang berkaitan dengan apa yang baik dan apa yang buruk. Penjelasan dan hubungan antara moral dengan agama serta hukum menurut Utami et al., Tahun 2016 yaitu:

a. Moral dan Agama

Moral memiliki hubungan yang kuat dengan agama. Etik selalu merujuk pada standar moral, terutama dalam hal kelompok profesi, seperti perawat. Perawat sering dihadapkan pada masalah etik saat menjalankan pekerjaan mereka, sehingga mereka harus tahu bagaimana membuat keputusan yang baik. Sebagai perawat, anda harus terus mempelajari keterampilan yang diperlukan untuk berfungsi sebagai perantara moral dan peserta dalam pengambilan keputusan etik. Setiap agama memiliki ajaran moral yang menjadi pegangan bagi mereka yang menganutnya, sehingga agama menjadi motivasi terpenting dan terkuat untuk perilaku moral. Karena orang yang menjalankan ajaran agamanya dengan baik, maka moralnya juga akan baik, moral dan agama adalah dua faktor yang terakumulasi secara positif. Namun, dalam dunia kontemporer, sering kali terlihat bahwa kedua hal tersebut berdampak negatif.

b. Moral dan Hukum

Hukum tidak berarti, bahwa hukum tidak dijiwai oleh moralitas, tanpa moralitas, hukum akan menjadi kosong. Dimana tingkat moral hukum sebegini besar menentukan kualitasnya (Riskika et al., 2022)

E. Latihan

Pilihan Ganda

1. Nilai dalam keperawatan yang merupakan keyakinan mendasari sikap dan perilaku perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Berikut ini yang bukan merupakan nilai dalam keperawatan adalah ...
 - A. Kejujuran
 - B. Otonomi
 - C. Keangkuhan

- D. Keadilan
 - E. Altruisme
2. Norma yang berasal dari hati nurani manusia dan berkaitan dengan perasaan bersalah atau berdosa disebut ...
- A. Norma hukum
 - B. Norma kesusilaan
 - C. Norma agama
 - D. Norma kebiasaan
 - E. Norma sosial
3. Dalam keperawatan, tindakan seorang perawat yang bersikap netral dan tidak membedakan pasien berdasarkan ras, status ekonomi, atau agama, mencerminkan prinsip etik ...
- A. Autonomy
 - B. Nonmaleficence
 - C. Justice
 - D. Beneficence
 - E. Veracity
4. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari etika keperawatan adalah ...
- A. Meningkatkan keterampilan profesional perawat
 - B. Menyampingkan kebutuhan pasien demi kepentingan institusi
 - C. Mendorong perawat untuk terus berkembang dalam praktik keperawatan
 - D. Memberikan perlindungan hukum bagi perawat dalam bertindak
 - E. Membantu perawat dalam mengambil keputusan yang benar
5. Norma yang bersumber dari kebiasaan masyarakat dan menentukan perilaku yang dianggap pantas dalam kehidupan sosial disebut ...
- A. Norma kesopanan
 - B. Norma hukum
 - C. Norma agama
 - D. Norma moral
 - E. Norma professional

Essay

1. Jelaskan bagaimana perbedaan antara nilai dan norma dalam tindakan praktik keperawatan!
2. Jelaskan mengapa prinsip dari beneficence dalam praktik keperawatan sangatlah dibutuhkan!
3. Jelaskan perbedaan dari etika keperawatan dan bioetik?

4. Bagaimana perawat bisa menyeimbangkan prinsip otonomi dan beneficence dalam pengambilan keputusan keperawatan?
5. Bagaimana seorang perawat menerapkan dari prinsip justice didalam melaksanakan proses keperawatan?

F. Kunci Jawaban

1. C
2. B
3. C
4. B
5. A

G. Rangkuman Materi

Mempelajari tentang Etika Keperawatan, dalam berperilaku terdapat suatu prinsip dan norma yang mengatur bagaimana seorang perawat berperilaku dalam memberikan suatu asuhan keperawatan kepada klien. Seorang perawat memiliki sifat jujur, empati, peduli, otonomi, dan adil dalam menjalankan profesinya. Norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum merupakan bagian dari norma keperawatan. Norma keperawatan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan, profesionalisme, dan memastikan pelayanan yang diberikan kepada klien bersikap adil selama menjalani perawatan. Otonomi, Kebaikan, Tidak merugikan, dan keadilan merupakan suatu prinsip dari etika keperawatan. Seorang perawat sangat penting untuk belajar dan memahami tentang etika, agar dalam menjalankan tugas profesinya jika terdapat keharusan untuk tanggung jawab, mereka dapat menangani masalah etik dengan baik, serta memastikan keputusan yang dibuat sudah sesuai dengan norma ataupun standar prosedur operasional keperawatan.

H. Glosarium

Autonomy. Prinsip etika yang menghormati hak pasien untuk menentukan nasib sendiri.

Beneficence. Prinsip etika yang mengharuskan perawat untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi pasien.

Caring. Sikap peduli, perhatian, dan empati yang ditunjukkan oleh perawat kepada pasien.

Empati. Kemampuan perawat untuk memahami dan berbagi perasaan pasien tanpa menghakimi.

Etika. Pedoman yang mengatur nilai- nilai moral yang mengatur perilaku profesional dalam memberikan asuhan keperawatan.

Justice: Prinsip etika yang mengharuskan perawat untuk bersikap adil dalam pelayanan keperawatan.

Moral: Suatu prinsip dan nilai yang memengaruhi tindakan perawatan dalam memberikan asuhan keperawatan.

Norma: kode etik keperawatan yang berisi prinsip dan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh perawat atau mengatur perilaku individu dalam masyarakat.

Nonmaleficence: Prinsip etika yang mengharuskan perawat untuk tidak menyebabkan bahaya atau kerugian pada pasien.

Otonomi: kemampuan pasien untuk menentukan haknya sendiri dalam mengambil keputusan terkait kesehatannya tanpa paksaan.

I. Daftar Pustaka

- American Association of Colleges of Nursing. (2008). *The Essentials of Baccalaureate Education for Professional Nursing Practice*. AACN.
- American Nurses Association. (2023). *Why Ethics in Nursing Matters*. <https://www.nursingworld.org/content-hub/resources/workplace/why-ethics-in-nursing-matters/>
- Asman, A., Mufidah, A., & Saharudin. (2022). *Etika Keperawatan*. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Asnuriyati, W., & Mawarni, T. (2021). *Buku Ajar Etika Keperawatan*. Literasi Nusantara. *Etik*. (n.d.). <https://kbbi.web.id/etik>
- Handayani, W. S. (2019). *Norma, Etika, dan Moralitas Bangsa*. Cempaka Putih.
- Hasyim, M., & Prasetyo, J. (2019). *Buku Panduan Etika Keperawatan*. Desa Pustaka Indonesia.
- Hijriana, I. (2023). *Buku ajar Etika Keperawatan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mangara, A., Julianto, & Lismawati. (2021). *Etika Keperawatan: Buku Praktis menjadi Perawat Profesional*. Penerbit Adab.
- Moral*. (n.d.). <https://kbbi.web.id/moral>
- Norma*. (n.d.). <https://kbbi.web.id/norma>
- Nurohmat, & Ruswadi, I. (2021). *Etika Keperawatan: Panduan Praktis bagi perawat dan Mahasiswa Keperawatan dalam bertindak dan Berperilaku*. Penerbit Adab.
- Östman, L., Näsman, Y., Eriksson, K., & Nyström, L. (2019). Ethos: The heart of ethics and health. *Nursing Ethics*, 26(1), 26–36. <https://doi.org/10.1177/0969733017695655>
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (1997). *Fundamental of Nursing: Concepts, Process, and Practice*. Mosby-Year Book Inc.

- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2009). *Fundamental of Nursing. Seven Edition. (Terj. Andrina Ferderika)*. Salemba Medika.
- Riskika, S., Harun, B., Purnamawati, T., Nasir, A., Hakim, B. N., PK, L. F., Anggraini, Y., Panma, Y., Nyumirah, S., & Suhartini, T. (2022). *Nursing Ethics (Etika Keperawatan)*. Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Subroto, J. (2021). *Seri Kepribadian: Norma dalam Masyarakat*. PT Bumi Aksara.
- Sumijatun. (2011). *Membudayakan Etika dalam Praktik Keperawatan*. Salemba Medika.
- Utami, N. W., Agustine, U., & P, R. E. H. (2016). *Etika Keperawatan dan Keperawatan Profesional*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

BAB 2

ASPEK LEGAL DAN SISTEM KRIDENSIAL PERAWAT INDONESIA

Pendahuluan

Praktik keperawatan di Indonesia tidak hanya didasarkan pada kompetensi profesional dan kode etik, tetapi juga dipandu oleh berbagai regulasi hukum yang mengikat. Aspek legal dan sistem kredensial merupakan bagian integral dari praktik keperawatan yang bertujuan melindungi pasien, perawat, dan institusi pelayanan kesehatan. Sistem kredensial membantu memastikan bahwa perawat yang menjalankan praktik telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan serta memiliki lisensi yang valid. Dalam konteks Indonesia, aspek legal mencakup undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan daerah yang mengatur praktik keperawatan, sedangkan kredensial mencakup proses sertifikasi, registrasi, dan lisensi yang wajib dipenuhi oleh perawat sebelum melaksanakan praktiknya.

Capaian Pembelajaran (CPL)

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami aspek legal dan sistem kredensial dalam keperawatan serta mengimplementasikan pemahaman tersebut dalam praktik profesional secara bertanggung jawab dan etis.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar aspek legal dalam praktik keperawatan.
- Menguraikan proses sistem kredensial perawat di Indonesia.
- Menganalisis pentingnya aspek legal dan kredensial dalam praktik keperawatan untuk perlindungan hukum perawat dan pasien.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik keperawatan di Indonesia.

- Menyebutkan dan menjelaskan proses kredensial, meliputi sertifikasi kompetensi, registrasi, dan lisensi perawat.
- Mengidentifikasi risiko hukum dalam praktik keperawatan dan strategi pencegahannya.
- Mengaplikasikan pemahaman tentang aspek legal dan kredensial dalam studi kasus keperawatan secara praktis.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Aspek Legal dalam Praktik Keperawatan

Aspek legal dalam praktik keperawatan mencakup berbagai peraturan hukum yang wajib dipatuhi oleh perawat dalam menjalankan tugas profesionalnya. Pemahaman dan penerapan aspek legal ini sangat penting untuk memastikan pemberian pelayanan yang aman, berkualitas tinggi, serta sesuai dengan standar profesi dan etika keperawatan. Aspek ini juga berperan sebagai pelindung, baik bagi pasien maupun perawat, dengan memberikan panduan jelas mengenai hak dan kewajiban serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan keperawatan yang dilakukan.

1. Regulasi Utama dalam Praktik Keperawatan Indonesia

Di Indonesia, regulasi yang paling fundamental adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. UU ini secara komprehensif mengatur segala aspek terkait praktik keperawatan, termasuk pendidikan formal keperawatan, uji kompetensi, registrasi, lisensi, hingga praktik langsung di lapangan. Setiap perawat diwajibkan memiliki bukti kompetensi melalui proses kredensial yang mencakup sertifikasi kompetensi, registrasi ke Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), dan memperoleh lisensi praktik dari instansi berwenang.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2019 hadir sebagai pedoman teknis pelaksanaan UU Keperawatan. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai proses administratif seperti registrasi perawat, pemberian lisensi praktik, serta kewenangan perawat dalam melaksanakan tindakan medis tertentu, termasuk prosedur-prosedur penting yang harus diikuti guna mencegah kesalahan praktik atau malpraktik.

2. Peraturan Daerah (Perda)

Selain peraturan pusat, terdapat pula peraturan daerah (Perda) yang disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi lokal masing-masing wilayah. Perda ini biasanya berisi ketentuan tambahan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, meliputi perizinan praktik, standar pelayanan kesehatan lokal, fasilitas kesehatan yang harus tersedia, serta norma-norma etika dan profesionalisme khusus yang wajib dipatuhi perawat. Misalnya, daerah tertentu mungkin menerapkan standar layanan tambahan untuk menangani penyakit endemik atau kondisi lingkungan khusus yang berdampak pada pelayanan keperawatan.

3. Hak dan Kewajiban Perawat

Pemahaman mendalam terhadap aspek legal tidak terlepas dari pengetahuan mengenai hak dan kewajiban perawat. Hak perawat meliputi hak

mendapatkan lingkungan kerja yang aman, hak perlindungan hukum selama menjalankan tugas profesionalnya, dan hak untuk memperoleh pelatihan serta pendidikan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi profesionalnya.

Sebaliknya, kewajiban perawat mencakup kewajiban untuk memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas tinggi, kompeten, dan etis. Perawat juga wajib menjaga kerahasiaan informasi pasien, menghormati hak pasien, serta mematuhi semua peraturan dan standar profesional yang berlaku. Setiap pelanggaran kewajiban ini dapat berujung pada sanksi hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

4. Dokumentasi Praktik Keperawatan

Implementasi aspek legal dalam praktik keperawatan diwujudkan secara nyata melalui dokumentasi praktik keperawatan yang sistematis, akurat, dan lengkap. Dokumentasi tersebut mencakup catatan kesehatan pasien, hasil tindakan medis atau perawatan yang diberikan, dan berbagai informasi penting terkait proses pelayanan yang berlangsung.

Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti hukum apabila terjadi sengketa atau tuntutan hukum terhadap perawat atau institusi pelayanan kesehatan. Selain itu, dokumentasi yang baik juga merupakan sarana evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan melindungi pasien dari potensi risiko kesalahan praktik.

5. Pentingnya Edukasi tentang Aspek Legal dalam Keperawatan

Penting bagi setiap perawat untuk terus mengembangkan pemahaman mengenai aspek legal melalui pendidikan formal maupun informal. Dengan penguasaan aspek ini, perawat dapat meningkatkan kesadaran hukum, bertindak secara bertanggung jawab, serta meminimalkan risiko hukum dalam praktik keperawatan. Pendidikan ini dapat diwujudkan melalui pelatihan berkala, seminar, workshop, dan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi maupun institusi pendidikan keperawatan.

Melalui pemahaman yang menyeluruh dan penerapan yang tepat terhadap aspek legal, perawat tidak hanya terlindungi secara hukum tetapi juga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan prinsip keadilan, keselamatan, dan kesejahteraan pasien sebagai prioritas utama.

B. Proses Sistem Kredensial Perawat di Indonesia

Sistem kredensial dalam keperawatan Indonesia merupakan suatu rangkaian proses formal yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perawat memiliki kompetensi, kredibilitas, dan legalitas yang diperlukan sebelum mereka dapat menjalankan praktik keperawatan secara resmi. Proses ini dirancang untuk

menjamin bahwa pelayanan keperawatan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar profesional yang berlaku, sehingga mampu memberikan perlindungan optimal baik untuk pasien maupun perawat itu sendiri.

1. Sertifikasi Kompetensi

Sertifikasi kompetensi adalah tahap awal dari sistem kredensial perawat di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perawat memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan yang sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan. Proses sertifikasi ini umumnya dilakukan melalui uji kompetensi nasional yang diselenggarakan secara rutin oleh organisasi profesi, yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Uji kompetensi ini mencakup berbagai aspek penting dalam praktik keperawatan, termasuk teori dasar keperawatan, keterampilan klinis praktis, pemahaman mendalam tentang etika profesional, serta kemampuan mengambil keputusan klinis secara tepat dan efektif dalam situasi nyata. Hasil dari uji kompetensi ini menentukan apakah seorang perawat dinyatakan kompeten dan siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya dalam proses kredensial. Sertifikasi kompetensi ini bersifat periodik, yang berarti setiap perawat harus memperbarui sertifikatnya secara berkala guna memastikan kompetensinya tetap relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan terkini.

2. Registrasi

Registrasi merupakan tahap kedua dalam proses sistem kredensial perawat, yaitu proses pencatatan resmi oleh lembaga yang berwenang seperti Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP). Proses ini memberikan pengakuan formal bahwa perawat telah memenuhi seluruh persyaratan administratif maupun kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi profesi terkait.

Dokumen yang diperlukan dalam proses registrasi mencakup bukti sertifikasi kompetensi, ijazah pendidikan keperawatan yang sah, serta dokumen administratif tambahan yang relevan. Setelah menyelesaikan proses ini, perawat akan memperoleh nomor registrasi nasional yang sah dan diakui di seluruh wilayah Indonesia. Registrasi ini harus diperbaharui secara periodik untuk memastikan data dan kompetensi perawat selalu up-to-date. Registrasi memberikan legalitas bagi perawat untuk bekerja di berbagai fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

3. Lisensi

Lisensi adalah tahap akhir dalam proses kredensial perawat yang berupa izin praktik yang diberikan secara resmi oleh pemerintah melalui dinas kesehatan setempat atau lembaga berwenang lainnya. Lisensi menegaskan bahwa seorang

perawat telah memenuhi seluruh persyaratan hukum dan berhak untuk menjalankan praktik keperawatan secara mandiri atau bekerja dalam institusi pelayanan kesehatan.

Untuk mendapatkan lisensi praktik, perawat diwajibkan menunjukkan bukti registrasi yang valid, surat rekomendasi dari organisasi profesi atau instansi tempat perawat bekerja, serta memenuhi persyaratan administratif tambahan yang ditetapkan oleh daerah tempat perawat tersebut akan berpraktik. Lisensi praktik juga memiliki masa berlaku tertentu dan harus diperbarui secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan perawat selalu menjaga kompetensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

C. Pentingnya Sistem Kredensial dalam Keperawatan

Sistem kredensial memiliki peran krusial dalam dunia keperawatan karena:

1. Menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang optimal dari perawat kepada masyarakat.
2. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa layanan keperawatan diberikan oleh tenaga yang kompeten dan terpercaya.
3. Melindungi perawat dari risiko hukum yang muncul akibat kelalaian atau kesalahan dalam praktik keperawatan.
4. Mengontrol standar pendidikan dan pelatihan perawat agar tetap sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Dengan pemahaman dan penerapan sistem kredensial secara tepat, perawat mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, dan menjaga integritas profesi keperawatan di Indonesia.

1. Pentingnya Aspek Legal dan Kredensial dalam Praktik Keperawatan

Aspek legal dan sistem kredensial memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia keperawatan. Kedua aspek ini memastikan bahwa praktik keperawatan berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang telah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan detail mengenai pentingnya aspek legal dan sistem kredensial dalam praktik keperawatan di Indonesia:

2. Menjamin Pelayanan Keperawatan yang Aman dan Berkualitas

Aspek legal memastikan bahwa perawat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjamin keselamatan dan kualitas layanan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Regulasi dan standar praktik yang jelas memungkinkan perawat memberikan perawatan berdasarkan bukti ilmiah (evidence-based practice),

sehingga kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien dapat ditingkatkan dan dipertahankan secara konsisten.

Selain itu, proses kredensial seperti sertifikasi kompetensi, registrasi, dan lisensi memastikan bahwa perawat yang menjalankan praktik telah memiliki kemampuan yang teruji. Hal ini sangat vital dalam menghindari kesalahan medis yang dapat berdampak buruk terhadap pasien maupun perawat.

3. Melindungi Pasien dari Praktik Tidak Kompeten atau Malpraktik

Aspek legal dan sistem kredensial berfungsi melindungi pasien dari risiko praktik keperawatan yang tidak kompeten atau malpraktik. Dengan adanya regulasi yang jelas dan proses kredensial yang ketat, pasien dapat terhindar dari tindakan medis yang tidak tepat atau kelalaian yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka.

Melalui proses kredensial, hanya perawat yang terbukti kompeten dan profesional yang diizinkan untuk memberikan layanan kepada pasien. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko terjadinya malpraktik dan meningkatkan kepercayaan pasien terhadap profesi keperawatan.

4. Memberikan Perlindungan Hukum bagi Perawat dalam Melaksanakan Tugas

Aspek legal memberikan dasar perlindungan hukum bagi perawat ketika melaksanakan tugas profesional mereka. Regulasi yang jelas mengenai batas-batas kewenangan, prosedur yang harus diikuti, serta dokumentasi praktik yang harus dilakukan memberikan panduan yang konkret bagi perawat dalam menjalankan tugasnya.

Dengan adanya sistem kredensial yang terstruktur, perawat dapat membuktikan bahwa mereka telah memenuhi semua persyaratan kompetensi dan administratif yang dibutuhkan dalam praktik profesional. Hal ini membantu melindungi perawat dari konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat tuntutan atau gugatan hukum dari pasien atau keluarga pasien, selama perawat telah mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku.

5. Memastikan Kompetensi Perawat Sesuai Standar Nasional dan Internasional

Sistem kredensial seperti sertifikasi kompetensi, registrasi, dan lisensi memastikan bahwa perawat yang berpraktik di Indonesia telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional maupun internasional. Dengan demikian, kompetensi perawat tidak hanya diakui di tingkat lokal tetapi juga sesuai dengan standar global.

Proses kredensial yang ketat membantu menjaga kualitas pendidikan dan pelatihan keperawatan, sehingga lulusan perawat di Indonesia dapat bersaing di

pasar global. Ini juga membuka peluang bagi perawat Indonesia untuk bekerja di luar negeri dengan kompetensi yang diakui secara internasional.

D. Risiko Hukum dan Strategi Pencegahannya dalam Praktik Keperawatan

Dalam praktik keperawatan, berbagai risiko hukum dapat muncul yang berpotensi merugikan pasien, perawat, maupun institusi kesehatan. Risiko ini mencakup malpraktik, pelanggaran hak pasien, kelalaian dalam tugas, serta kesalahan administrasi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai risiko ini serta implementasi strategi pencegahan yang efektif menjadi keharusan bagi setiap perawat dalam menjalankan praktik profesionalnya.

Risiko Hukum dalam Praktik Keperawatan

1. Malpraktik

Malpraktik merupakan tindakan kelalaian profesional yang dilakukan oleh perawat dalam menjalankan tugasnya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang mengakibatkan cedera atau kerugian pada pasien. Contoh kasus malpraktik antara lain kesalahan pemberian obat, kesalahan dalam prosedur medis, atau tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar profesional. Malpraktik tidak hanya berakibat fatal bagi pasien tetapi juga berisiko terhadap reputasi perawat dan institusi kesehatan.

2. Pelanggaran Hak Pasien

Hak pasien mencakup hak mendapatkan informasi, hak atas privasi, serta hak untuk mendapatkan layanan medis yang bermutu. Pelanggaran hak pasien terjadi ketika perawat tidak menghormati atau tidak melaksanakan hak-hak tersebut, seperti memberikan informasi yang tidak lengkap, melanggar privasi pasien, atau mengabaikan persetujuan pasien dalam pengambilan tindakan medis. Pelanggaran ini dapat menurunkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan kesehatan dan berujung pada konsekuensi hukum yang serius.

3. Kelalaian dalam Tugas

Kelalaian dalam tugas merujuk pada kegagalan perawat dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawab sesuai standar yang telah ditentukan. Kelalaian ini bisa berupa kesalahan dalam pengawasan pasien, kegagalan dalam mengidentifikasi kondisi darurat, atau tidak menjalankan prosedur keselamatan pasien secara tepat. Dampak kelalaian dapat menyebabkan komplikasi serius bahkan hingga kematian pasien, serta implikasi hukum yang merugikan perawat dan institusi kesehatan.

E. Strategi Pencegahan Risiko Hukum dalam Praktik Keperawatan

1. Pemahaman dan Penerapan Peraturan Hukum Terkait

Pemahaman mendalam terhadap peraturan hukum yang mengatur praktik keperawatan sangat penting bagi setiap perawat. Perawat harus selalu memperbarui pengetahuan tentang regulasi, seperti Undang-Undang Keperawatan, Peraturan Menteri Kesehatan, dan kebijakan internal institusi kesehatan. Dengan memahami regulasi tersebut, perawat mampu menjalankan tugas sesuai hukum, sehingga risiko hukum dapat diminimalisir secara signifikan.

2. Pelaksanaan Praktik Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan panduan yang disusun berdasarkan bukti ilmiah dan standar profesi yang bertujuan untuk mengarahkan praktik keperawatan secara konsisten dan aman. SOP membantu memastikan bahwa tindakan keperawatan dilakukan secara tepat dan efektif, sekaligus mencegah terjadinya kesalahan medis atau tindakan yang tidak sesuai standar. Dengan disiplin menjalankan SOP, perawat dapat mengurangi risiko hukum secara efektif.

3. Dokumentasi Praktik Keperawatan yang Akurat dan Lengkap

Dokumentasi yang akurat dan lengkap dalam praktik keperawatan merupakan bukti hukum yang vital. Dokumentasi ini mencakup pencatatan tindakan yang dilakukan, respons pasien, serta setiap perubahan kondisi pasien. Dokumentasi yang baik mampu melindungi perawat dalam kasus tuntutan hukum, karena menyediakan bukti bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar praktik dan persetujuan pasien. Perawat harus dibekali keterampilan dokumentasi yang baik, jelas, dan rinci agar mampu mengelola risiko hukum secara optimal.

4. Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan merupakan investasi penting dalam mencegah risiko hukum di bidang keperawatan. Melalui pelatihan rutin, seminar, workshop, dan pendidikan lanjutan, perawat dapat memperbarui dan meningkatkan kompetensinya secara berkala. Kompetensi yang terus dikembangkan membantu perawat dalam menghadapi tantangan praktik yang kompleks serta meminimalisir kesalahan yang berpotensi mengarah pada risiko hukum.

F. Latihan soal

1. Seorang perawat memberikan suntikan kepada pasien tanpa terlebih dahulu menjelaskan prosedur dan tanpa meminta persetujuan pasien. Tindakan ini termasuk pelanggaran terhadap aspek apa dalam aspek legal keperawatan?
 - A. Hak pasien atas informasi dan persetujuan
 - B. Standar operasional prosedur (SOP)
 - C. Dokumentasi praktik keperawatan
 - D. Sertifikasi kompetensi perawat
 - E. Registrasi perawat

Kunci Jawaban: a. Hak pasien atas informasi dan persetujuan

Pembahasan: Setiap tindakan medis, termasuk keperawatan, wajib dijelaskan terlebih dahulu kepada pasien dan harus mendapat persetujuan (informed consent) dari pasien. Mengabaikan hal ini merupakan pelanggaran hak pasien.

2. Seorang perawat tidak mendokumentasikan perubahan kondisi pasien secara detail dan akurat selama perawatan. Dampak langsung dari kelalaian ini jika terjadi sengketa hukum adalah:
 - A. Pasien menerima pelayanan yang buruk
 - B. Perawat tidak memiliki bukti hukum yang kuat
 - C. Institusi kesehatan mendapat teguran administratif
 - D. Terjadinya malpraktik medis
 - E. Pasien mengalami komplikasi berat

Kunci Jawaban: b. Perawat tidak memiliki bukti hukum yang kuat

Pembahasan: Dokumentasi praktik keperawatan yang akurat dan lengkap penting sebagai bukti hukum jika terjadi sengketa atau tuntutan hukum. Kelalaian dalam dokumentasi dapat mengurangi perlindungan hukum bagi perawat.

3. Seorang perawat di suatu daerah menerapkan standar layanan tambahan khusus untuk penyakit endemik setempat sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda). Hal ini menunjukkan pemahaman perawat terhadap:
 - A. Regulasi utama di tingkat nasional
 - B. Standar internasional keperawatan
 - C. Peraturan daerah (Perda) terkait praktik keperawatan
 - D. Sertifikasi kompetensi nasional
 - E. Hak perawat dalam melaksanakan tugas

Kunci Jawaban: c. Peraturan daerah (Perda) terkait praktik keperawatan

Pembahasan: Perda memberikan regulasi tambahan sesuai kebutuhan lokal, seperti penanganan penyakit endemik. Pemahaman terhadap Perda ini sangat penting dalam praktik keperawatan di wilayah tertentu.

4. Seorang perawat dinyatakan lalai dalam tugas karena gagal mengidentifikasi gejala darurat yang dialami pasien, yang menyebabkan pasien mengalami komplikasi serius. Perawat tersebut dapat menghadapi risiko hukum dalam bentuk:
- A. Pelanggaran administratif saja
 - B. Gugatan perdata saja
 - C. Tindakan pidana saja
 - D. Sanksi administratif, gugatan perdata, dan pidana
 - E. Teguran lisan dari institusi

Kunci Jawaban: d. Sanksi administratif, gugatan perdata, dan pidana

Pembahasan: Kelalaian serius yang mengakibatkan komplikasi atau kerugian signifikan pada pasien dapat berujung pada berbagai bentuk sanksi hukum, termasuk administratif, perdata, dan pidana.

5. Seorang perawat baru telah lulus uji kompetensi nasional tetapi belum melakukan registrasi ke Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI). Secara legal, dampak langsung yang dihadapinya adalah:
- A. Tidak boleh melanjutkan pendidikan lanjutan
 - B. Tidak diizinkan praktik secara resmi
 - C. Kehilangan hak perlindungan hukum
 - D. Tidak mendapat gaji penuh dari institusi
 - E. Tidak mendapatkan lisensi dari PPNI

Kunci Jawaban: b. Tidak diizinkan praktik secara resmi

Pembahasan: Registrasi merupakan tahap wajib setelah lulus uji kompetensi. Tanpa registrasi, seorang perawat tidak memiliki legalitas untuk praktik secara resmi di fasilitas pelayanan kesehatan manapun.

G. Rangkuman Materi

Aspek legal dalam praktik keperawatan merupakan suatu rangkaian peraturan hukum yang wajib diikuti oleh perawat dalam menjalankan tugasnya guna menjamin keselamatan dan kualitas layanan keperawatan. Di Indonesia, regulasi utama yang mengatur praktik ini adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yang mencakup pendidikan keperawatan, uji kompetensi, registrasi, lisensi, hingga standar praktik di lapangan. Peraturan ini diperjelas dengan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2019 yang mengatur secara teknis mengenai proses administratif dan batas-batas kewenangan perawat. Selain regulasi nasional, terdapat juga peraturan daerah (Perda) yang disusun sesuai kebutuhan lokal untuk menyesuaikan layanan dengan kondisi wilayah tertentu.

Dalam praktiknya, aspek legal juga menegaskan pentingnya pemahaman perawat tentang hak dan kewajiban profesional mereka. Hak perawat antara lain mencakup lingkungan kerja yang aman, perlindungan hukum dalam tugasnya, serta hak mendapatkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Di sisi lain, perawat memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang kompeten dan etis, menjaga kerahasiaan pasien, serta menghormati hak pasien sesuai regulasi yang berlaku. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana.

Implementasi aspek legal diwujudkan melalui dokumentasi praktik keperawatan yang lengkap dan akurat, yang berfungsi sebagai bukti hukum serta alat evaluasi kualitas pelayanan. Selain itu, sistem kredensial keperawatan di Indonesia yang meliputi sertifikasi kompetensi, registrasi oleh lembaga berwenang, dan lisensi praktik, memastikan bahwa perawat memiliki kredibilitas dan legalitas dalam menjalankan praktiknya. Melalui proses ini, kompetensi perawat diakui secara nasional maupun internasional, yang sekaligus menjamin kualitas pelayanan dan perlindungan hukum bagi pasien serta perawat.

Kesadaran hukum perawat yang tinggi juga menjadi dasar utama dalam pencegahan risiko hukum seperti malpraktik, pelanggaran hak pasien, dan kelalaian dalam tugas. Strategi pencegahan tersebut meliputi pemahaman regulasi secara mendalam, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara disiplin, dokumentasi yang teliti, serta pengembangan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan. Dengan menerapkan seluruh aspek ini secara konsisten, perawat tidak hanya terlindungi secara hukum tetapi juga mampu memberikan pelayanan terbaik dengan memprioritaskan keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan pasien.

H. Glosarium

Aspek Legal

Rangkaian peraturan hukum yang wajib diikuti oleh perawat dalam menjalankan tugas profesionalnya untuk menjamin keselamatan pasien, kualitas pelayanan, serta perlindungan hukum bagi perawat.

Malpraktik

Tindakan kelalaian atau kesalahan profesional oleh perawat dalam memberikan layanan yang tidak sesuai standar profesi, yang berakibat pada cedera atau kerugian pada pasien.

Pelanggaran Hak Pasien

Ketidakpatuhan perawat terhadap hak-hak pasien seperti hak atas informasi yang jelas, privasi, dan persetujuan (informed consent) sebelum dilakukan tindakan medis atau keperawatan.

Kelalaian dalam Tugas

Kegagalan perawat dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab sesuai standar praktik yang telah ditentukan, seperti kesalahan dalam pemantauan pasien atau kegagalan merespon kondisi darurat.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014

Regulasi utama di Indonesia yang mengatur secara komprehensif berbagai aspek praktik keperawatan termasuk pendidikan formal, kompetensi, registrasi, lisensi, serta kewenangan perawat.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2019

Pedoman teknis pelaksanaan UU Keperawatan, yang mengatur proses administratif seperti registrasi perawat, lisensi praktik, serta kewenangan dalam tindakan medis tertentu.

Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan yang disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan lokal, berisi tambahan ketentuan khusus mengenai izin praktik, standar pelayanan lokal, serta norma-norma etika profesional yang relevan di wilayah tertentu.

Hak Perawat

Hak yang dimiliki perawat, seperti lingkungan kerja yang aman, perlindungan hukum, serta hak atas pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi profesional.

Kewajiban Perawat

Tanggung jawab profesional yang harus dilaksanakan perawat dalam memberikan pelayanan yang kompeten, menjaga kerahasiaan pasien, dan mematuhi standar praktik serta regulasi yang berlaku.

Dokumentasi Praktik Keperawatan

Catatan kesehatan pasien yang sistematis, akurat, dan lengkap yang berfungsi sebagai bukti hukum dalam kasus sengketa atau tuntutan hukum serta sebagai sarana evaluasi pelayanan.

Sistem Kredensial

Proses formal yang meliputi sertifikasi kompetensi, registrasi, dan lisensi, yang memastikan perawat memiliki kompetensi, kredibilitas, dan legalitas untuk menjalankan praktik keperawatan secara resmi.

Sertifikasi Kompetensi

Proses validasi melalui uji kompetensi nasional untuk memastikan perawat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar profesi.

Registrasi Perawat

Proses pencatatan resmi oleh lembaga berwenang, memberikan pengakuan bahwa perawat telah memenuhi persyaratan administratif dan kompetensi yang ditetapkan.

Lisensi Praktik

Izin resmi yang diberikan pemerintah melalui dinas kesehatan setempat, menyatakan perawat memenuhi persyaratan hukum dan berhak menjalankan praktik secara legal.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Panduan kerja yang disusun berdasarkan bukti ilmiah dan standar profesi untuk menjamin praktik keperawatan yang konsisten, efektif, dan aman.

Edukasi Aspek Legal

Proses pendidikan formal maupun informal yang bertujuan meningkatkan pemahaman perawat terhadap regulasi hukum terkait praktik keperawatan, guna meminimalisir risiko hukum dalam pelayanan.

I. Daftar pustaka

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan*. Jakarta: Kemenkes RI.

Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan*. Jakarta: Sekretariat MTKI.

Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (n.d.). *Uji kompetensi nasional perawat*. Diakses dari <https://www.ppni.or.id>

BAB 3

TAHAPAN PENYELESAIAN MASALAH ETIK DALAM KEPERAWATAN

Pendahuluan

Etika dalam praktik keperawatan merupakan landasan moral yang menjadi panduan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil perawat. Dalam praktik sehari-hari, perawat seringkali menghadapi berbagai dilema etik yang kompleks. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu proses atau tahapan sistematis yang membantu perawat dalam mengambil keputusan etis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan penyelesaian masalah etik ini penting untuk diketahui oleh perawat guna memastikan bahwa pelayanan keperawatan diberikan secara profesional, adil, dan manusiawi.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah etik yang muncul dalam praktik keperawatan dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan berdasarkan prinsip-prinsip etik keperawatan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menerapkan tahapan penyelesaian masalah etik dalam praktik keperawatan melalui pendekatan kritis, sistematis, dan sesuai dengan standar etika profesi.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Menjelaskan konsep dasar masalah etik dalam keperawatan.
- Mengidentifikasi langkah-langkah dalam tahapan penyelesaian masalah etik.
- Menganalisis kasus etik secara kritis dan komprehensif.
- Menentukan solusi penyelesaian masalah etik secara tepat berdasarkan prinsip etika keperawatan.

Uraian Materi

A. Tahapan Penyelesaian Masalah Etik dalam Keperawatan

1. Identifikasi Masalah Etik

Tahapan pertama dalam penyelesaian masalah etik adalah identifikasi masalah. Perawat harus secara jelas mengenali situasi yang menimbulkan konflik nilai atau dilema etik. Konflik ini biasanya melibatkan nilai-nilai dasar keperawatan seperti otonomi pasien (menghormati hak pasien untuk membuat keputusan sendiri), beneficence (memberikan manfaat kepada pasien), non-maleficence (tidak merugikan pasien), dan justice (keadilan dalam pemberian layanan kesehatan). Pemahaman awal yang jelas tentang masalah ini menjadi fondasi penting dalam tahap-tahap selanjutnya.

2. Pengumpulan Data dan Informasi Relevan

Setelah dilema etik teridentifikasi, langkah berikutnya adalah mengumpulkan data dan informasi relevan secara lengkap dan akurat. Proses ini mencakup data kondisi klinis pasien, riwayat medis, informasi mengenai latar belakang sosial, budaya, spiritual pasien, pandangan pasien dan keluarga, serta masukan dari tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam perawatan. Pengumpulan data ini bertujuan agar keputusan yang diambil nantinya tidak bersifat subyektif, melainkan objektif dan didasarkan pada bukti nyata yang komprehensif.

3. Analisis Masalah Etik

Analisis dilakukan dengan mengevaluasi data dan informasi yang sudah terkumpul secara kritis. Pada tahap ini, perawat menentukan secara spesifik nilai-nilai atau prinsip etik yang bertentangan dan dampaknya terhadap pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Perawat juga perlu mengevaluasi kemungkinan konsekuensi dari setiap pilihan tindakan yang akan diambil, dengan merujuk pada prinsip-prinsip etik dasar yang relevan, seperti prinsip keadilan, menghormati otonomi pasien, memberikan manfaat, dan menghindari bahaya.

4. Eksplorasi Alternatif Solusi

Tahap eksplorasi melibatkan pencarian berbagai alternatif solusi yang realistis dan praktis. Perawat harus mempertimbangkan berbagai solusi dari sudut pandang etik maupun operasional. Diskusi dan kolaborasi dengan tim interprofesional sangat dianjurkan untuk memperkaya wawasan, mendapatkan berbagai sudut pandang, serta memperkuat kualitas keputusan yang akan diambil. Pertimbangan terhadap dampak etis, emosional, sosial, dan praktis dari setiap alternatif menjadi fokus penting pada tahap ini.

5. Pengambilan Keputusan Etik

Setelah mengevaluasi alternatif solusi secara mendalam, perawat perlu mengambil keputusan etik yang paling tepat. Keputusan ini harus berfokus pada kesejahteraan pasien sebagai prioritas utama, sejalan dengan prinsip-prinsip etik profesi dan kode etik keperawatan. Keputusan ini harus mampu dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, dan hukum jika diperlukan.

6. Implementasi Keputusan

Implementasi merupakan tindakan konkret dari keputusan etik yang telah diambil. Tahap ini harus dilakukan dengan sensitivitas tinggi terhadap kebutuhan pasien dan keluarganya. Komunikasi efektif, empati, dan perhatian terhadap kondisi emosional pasien serta keluarga menjadi kunci utama dalam implementasi keputusan agar dapat diterima dengan baik tanpa menimbulkan masalah tambahan.

7. Evaluasi dan Refleksi

Tahap terakhir adalah evaluasi terhadap dampak dan efektivitas keputusan etik yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai apakah tindakan tersebut sesuai dengan tujuan awal, harapan etik, serta nilai-nilai profesionalisme keperawatan. Refleksi kritis juga menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan, sehingga dapat menjadi pelajaran yang berharga dalam menghadapi situasi serupa di masa mendatang.

B. Latihan Soal

1. Seorang pasien laki-laki usia 70 tahun dengan gagal ginjal kronis menolak melakukan hemodialisis yang direkomendasikan dokter, karena merasa terapi tersebut memperburuk kualitas hidupnya. Keluarga memaksa pasien untuk menjalani terapi tersebut. Dalam menyelesaikan masalah ini, tahap pertama yang harus dilakukan perawat adalah:
 - A. Melaksanakan hemodialisis sesuai permintaan keluarga
 - B. Menjelaskan kepada keluarga mengenai prosedur hemodialisis
 - C. Menentukan masalah etik terkait otonomi pasien dan beneficence
 - D. Melakukan kolaborasi dengan tim medis
 - E. Memulai proses konseling keluarga

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Tahap pertama penyelesaian masalah etik adalah identifikasi masalah etik. Dalam kasus ini, perawat harus jelas mengidentifikasi konflik antara hak otonomi pasien yang menolak terapi dan prinsip beneficence yang diyakini keluarga.

2. Perawat menghadapi dilema terkait pemberian transfusi darah kepada seorang anak yang keluarganya menolak dengan alasan agama. Langkah yang perlu dilakukan perawat setelah mengidentifikasi dilema etik adalah:
- A. Melakukan transfusi darah segera demi keselamatan pasien
 - B. Melibatkan tokoh agama agar menyetujui tindakan
 - C. Mengumpulkan informasi tambahan dari pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan
 - D. Melaporkan keluarga kepada pihak berwajib
 - E. Memberikan transfusi tanpa memberitahu keluarga

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Tahap kedua adalah pengumpulan data dan informasi relevan secara lengkap, termasuk aspek medis, agama, sosial, serta pandangan pasien dan keluarga sebelum mengambil keputusan etik.

3. Seorang pasien stroke mengalami komplikasi pneumonia berat. Tim medis mempertimbangkan untuk menghentikan ventilasi mekanis karena prognosis buruk, namun keluarga menolak penghentian tersebut. Pada tahap analisis masalah etik, langkah yang paling tepat dilakukan perawat adalah:
- A. Menyerahkan keputusan pada dokter spesialis
 - B. Menyusun alternatif solusi bersama keluarga
 - C. Mengkaji secara kritis dampak etik setiap keputusan
 - D. Melanjutkan ventilasi mekanis tanpa diskusi lanjutan
 - E. Segera mengimplementasikan penghentian ventilasi mekanis

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Tahap analisis masalah etik melibatkan evaluasi kritis mengenai dampak etik dan konsekuensi dari setiap pilihan yang tersedia, berdasarkan prinsip etik yang relevan (beneficence, non-maleficence, autonomy, dan justice).

4. Dalam menangani konflik etik tentang pasien terminal yang mengalami nyeri hebat, perawat menyarankan penggunaan analgesik opioid dosis tinggi yang berisiko memperpendek hidup pasien. Tahap eksplorasi alternatif solusi mencakup:
- A. Melakukan tindakan pemberian analgesik opioid segera
 - B. Mengabaikan risiko efek samping demi kenyamanan pasien
 - C. Berdiskusi dengan tim kesehatan tentang opsi terapi nyeri lainnya
 - D. Membiarkan keluarga memutuskan sendiri

E. Menyerahkan keputusan sepenuhnya pada dokter

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Tahap eksplorasi alternatif solusi melibatkan diskusi interprofesional untuk mempertimbangkan berbagai opsi solusi realistis, dengan memperhatikan aspek etis, medis, dan praktis dalam penanganan nyeri terminal.

5. Seorang perawat mengambil keputusan etik terkait pemberian informasi prognosis kepada pasien kanker stadium akhir. Setelah implementasi keputusan tersebut, perawat perlu melakukan evaluasi dengan tujuan utama:
- A. Menghindari kesalahan yang sama di masa depan
 - B. Menentukan tingkat kepuasan keluarga pasien
 - C. Menilai efektivitas dan dampak keputusan etik yang telah diambil
 - D. Memastikan pasien tidak mengalami depresi
 - E. Memberikan laporan kepada pihak manajemen rumah sakit

Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Evaluasi merupakan tahap penting untuk menilai efektivitas tindakan etik yang telah dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk memastikan keputusan sesuai dengan tujuan awal, harapan etik, dan nilai-nilai profesional keperawatan.

C. Rangkuman materi

Tahapan penyelesaian masalah etik dalam keperawatan merupakan proses sistematis yang penting untuk membantu perawat mengambil keputusan etis yang tepat ketika menghadapi dilema di lapangan. Proses ini diawali dengan identifikasi jelas terhadap situasi yang menimbulkan konflik etis, melibatkan prinsip dasar keperawatan seperti otonomi pasien, beneficence, non-maleficence, dan keadilan. Setelah dilema etik teridentifikasi, perawat mengumpulkan data lengkap yang mencakup kondisi klinis, riwayat medis, latar belakang sosial, budaya, spiritual pasien, serta pandangan keluarga dan tim kesehatan lainnya agar keputusan yang diambil berbasis bukti yang objektif. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kritis untuk memahami nilai-nilai atau prinsip yang bertentangan, sekaligus mengevaluasi konsekuensi dari setiap pilihan tindakan. Pada tahap berikutnya, perawat mengeksplorasi berbagai alternatif solusi secara komprehensif dengan melibatkan diskusi interprofesional untuk memperkaya wawasan dan mempertajam keputusan yang akan diambil. Keputusan etik yang dipilih harus berfokus pada kesejahteraan pasien, memenuhi prinsip profesionalisme, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum. Dalam implementasi

keputusan tersebut, perawat harus mengedepankan komunikasi yang efektif, empati, serta sensitivitas terhadap kondisi emosional pasien dan keluarganya agar tindakan dapat diterima tanpa menimbulkan konflik tambahan. Tahap akhir berupa evaluasi dan refleksi dilakukan untuk menilai efektivitas keputusan serta mengevaluasi proses penyelesaian masalah etik yang telah dilakukan, sehingga menjadi pengalaman berharga untuk menghadapi dilema serupa di masa depan.

D. Glosarium

Analisis Etik

Proses mengevaluasi secara kritis situasi etik berdasarkan informasi yang dikumpulkan, guna mengidentifikasi prinsip atau nilai yang saling bertentangan dan mempertimbangkan dampaknya.

Beneficence

Prinsip etik dalam keperawatan yang menekankan pentingnya memberikan manfaat kepada pasien dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Data Relevan

Informasi yang tepat, lengkap, dan akurat terkait kondisi klinis pasien, riwayat medis, aspek sosial, budaya, spiritual, serta pandangan pasien dan pihak terkait lainnya yang penting untuk pengambilan keputusan etik.

Dilema Etik

Situasi yang melibatkan konflik antara dua atau lebih nilai atau prinsip moral, di mana pengambilan keputusan menjadi sulit karena semua pilihan memiliki dampak moral yang signifikan.

Evaluasi dan Refleksi

Proses penilaian terhadap efektivitas dan dampak keputusan etik setelah implementasi, serta refleksi mendalam untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan pembelajaran yang dapat digunakan dalam situasi masa depan.

Eksplorasi Alternatif Solusi

Tahapan di mana perawat mencari dan mempertimbangkan berbagai pilihan solusi yang memungkinkan, dengan memperhatikan aspek etik, praktis, emosional, sosial, dan operasional.

Implementasi Keputusan

Tahap di mana keputusan etik diwujudkan dalam tindakan nyata dengan sensitivitas terhadap pasien, menggunakan komunikasi yang efektif serta empati guna memastikan keputusan tersebut diterima dengan baik tanpa menimbulkan konflik tambahan.

Justice (Keadilan)

Prinsip etik yang menekankan perlunya pemberian pelayanan kesehatan secara adil, merata, dan tidak diskriminatif kepada semua pasien.

Konflik Etik

Pertentangan antara nilai-nilai atau prinsip moral yang menimbulkan kesulitan dalam menentukan tindakan atau keputusan yang tepat secara etis.

Non-maleficence

Prinsip etik yang menekankan kewajiban perawat untuk tidak menyebabkan bahaya atau merugikan pasien dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Otonomi Pasien

Hak pasien untuk membuat keputusan sendiri mengenai perawatan kesehatannya, yang harus dihormati oleh perawat dan tenaga kesehatan lainnya.

Pengambilan Keputusan Etik

Proses memilih tindakan yang paling tepat berdasarkan pertimbangan matang terhadap prinsip-prinsip etik, kesejahteraan pasien, serta kode etik profesi yang berlaku.

Pengumpulan Data

Proses memperoleh informasi komprehensif terkait situasi etik untuk memastikan keputusan yang diambil didasarkan pada fakta dan bukti yang objektif serta akurat.

Prinsip Etik Dasar

Kumpulan nilai moral utama yang menjadi panduan dalam praktik keperawatan, mencakup otonomi pasien, beneficence, non-maleficence, dan justice.

E. Daftar pustaka

- Astuti, Y. R., & Sudiana, I. K. (2020). Ethical dilemmas in nursing practice: A literature review. *International Journal of Nursing and Health Services*, 3(2), 1–9. <https://doi.org/10.35654/ijnhs.v3i2.208>
- Burkhardt, M. A., & Nathaniel, A. K. (2019). *Ethics and Issues in Contemporary Nursing* (5th ed.). Elsevier.
- Fry, S. T., Veatch, R. M., & Taylor, C. R. (2020). *Case Studies in Nursing Ethics* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- Guido, G. W. (2020). *Legal and Ethical Issues in Nursing* (7th ed.). Pearson Education.
- Haddad, L. M., & Geiger, R. A. (2021). Nursing ethical considerations. In *StatPearls [Internet]*. StatPearls Publishing. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526054/>
- Huston, C. J. (2020). *Professional Issues in Nursing: Challenges and Opportunities* (5th ed.). Wolters Kluwer.

- Kangasniemi, M., Pakkanen, P., & Korhonen, A. (2019). Professional ethics in nursing: An integrative review. *Journal of Advanced Nursing*, 75(8), 1744–1758. <https://doi.org/10.1111/jan.13901>
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Kode Etik Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2020). *Fundamentals of Nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Pozgar, G. D. (2020). *Legal and Ethical Issues for Health Professionals* (5th ed.). Jones & Bartlett Learning.

BAB 4

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PERAWAT MENURUT UNDANG-UNDANG

Pendahuluan:

Perawat harus menghormati hak dan kewajiban pasien, sebaliknya pasien juga harus menghormati hak dan kewajiban atau tanggung jawab perawat karena keduanya dilindungi oleh hukum. Keberhasilan pelayanan keperawatan bergantung pada sejauhmana hak dan tanggung jawab atau kewajiban perawat ditegakkan. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan, hak dan tanggung jawab/kewajiban harus dipenuhi karena akan mendorong keseimbangan antara tuntutan profesi dengan apa yang semestinya didapatkan perawat dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab perawat sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan keselamatan pasien, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, perawat dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya peningkatan kesehatan dan pemulihan pasien.

Bab ini akan membahas tentang hak dan tanggung jawab/kewajiban perawat menurut Undang Undang. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu memahami hak dan tanggung jawab/kewajiban perawat menurut Undang Undang yang berlaku di Indonesia. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa program studi diploma tiga keperawatan. Gambaran pembahasan pada Bab ini meliputi definisi hak, definisi kewajiban, jenis-jenis hak, hak dan tanggung jawab/kewajiban perawat. Bahan ajar hak dan tanggung jawab/kewajiban merupakan bagian dari etika keperawatan sebagai pengetahuan dasar pada kode etik keperawatan Indonesia dalam memberikan asuhan keperawatan secara holistik dan komprehensif.

Struktur Bab ini terdiri dari tujuan instruksional, capaian pembelajaran, pendahuluan, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan soal, dan dilengkapi dengan rangkuman. Pendekatan pembelajaran menggunakan pembelajaran aktif, mahasiswa dituntut untuk mempelajari topik lain yang berkaitan seperti kode etik keperawatan, hak dan kewajiban pasien, peraturan/kebijakan/perundang-undangan dalam praktek keperawatan.

Tujuan Instruksional:

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu :

- Menjelaskan definisi hak
- Menjelaskan jenis-jenis hak
- Menjelaskan definisi tanggung jawab/kewajiban
- Menjelaskan hak dan tanggung jawab perawat

Capaian Pembelajaran:

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) :

- Lulusan mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah kesehatan umum dilandasi kode etik keperawatan dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- Lulusan mampu melakukan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, dalam kondisi biasa dan dalam kondisi kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien, sesuai Standar Profesi Keperawatan
- Lulusan mampu berperan aktif dalam manajemen keperawatan serta menunjukkan kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur terhadap hasil kerja sendiri atau tim dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan sesuai kode etik dan standar profesi keperawatan yang berlaku.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan Hak kewajiban dan tanggung jawab perawat menurut undang-undang

Uraian Materi

Uraian materi pada Bab ini meliputi definisi hak, jenis-jenis hak, definisi tanggung jawab/kewajiban, hak dan tanggung jawab perawat menurut Undang-Undang.

A. Pengertian Hak

Hak adalah tuntutan terhadap sesuatu yang seseorang berhak, seperti kekuasaan atau hak istimewa. Hak mungkin merupakan tuntutan sebagaimana semestinya dengan dasar keadilan, moralitas, atau legalitas. Hak dapat dipandang dari sudut pandang hukum. Hak yang dipandang dari sudut hukum adalah hak-hak memberi kekuasaan tertentu untuk mengontrol situasi. Contoh seseorang mempunyai hak untuk masuk restoran dan membeli makan (dari sudut hukum, hak mempunyai kewajiban tertentu yang menyertai, individu dengan hak makan di restoran diwajibkan untuk bertingkah laku yang sesuai dan membayar makanannya). Hak dipandang dari sudut pandang pribadi mengacu pada konsep pribadi dari hak mempunyai banyak hal yang harus dikerjakan sesuai dengan perkembangan etis. Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan konsep pribadi tentang hak, antara lain hubungan sosial, orang tua, kebudayaan, dan informasi.

Beberapa peranan hak adalah sebagai berikut :

1. Hak dapat digunakan untuk mengekspresikan kekuasaan dalam konflik antara seseorang dengan kelompok. Contoh: Dokter mungkin berkata pada perawat, "Saya punya hak untuk menginstruksikan pengobatan yang saya inginkan untuk klien saya".
2. Hak dapat digunakan untuk menjustifikasi tindakan. Contoh: perawat yang dikritik karena terlalu banyak menghabiskan waktu dengan klien mungkin berkata, "Saya mempunyai hak untuk memberikan keperawatan terbaik yang saya bisa".
3. Hak dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Contoh: perawat menyarankan pada klien bahwa seharusnya ia tidak berjalan ke lantai bawah, tetapi klien marah, tidak setuju dengan perawat dan berkata, "Saya punya hak untuk pergi ke lantai bawah bila saya mau".

B. Jenis-Jenis hak

Ada tiga jenis hak, yaitu hak untuk memilih atau kebebasan, hak kesejahteraan, dan hak legislatif.

1. Hak Kebebasan

Hak kebebasan adalah hak mengenai kebebasan dan dipilih. Perawat memiliki kebebasan yang melekat dalam dirinya masing-masing. Misalnya, seorang perawat wanita bekerja di rumah sakit dapat mengenakan seragam apa

pun yang ia inginkan (haknya), asalkan putih, bersih, dan yang sesuai menutup tubuhnya.

2. Hak Kesejahteraan

Hak kesejahteraan adalah hak yang diberikan secara hukum kepada hal-hal, seperti standar keselamatan spesifik dalam suatu bangunan. Perawat dan pasien berhak mendapatkan kehidupan sejahtera. Misalnya, pasien kelompok penerima jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit, baik dalam keadaan sehat maupun sakit berhak hidup sejahtera menerima kesembuhan jika berobat. Artinya, bukan harus sembuh, tetapi para pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik agar kesembuhannya bisa tercapai.

3. Hak Legislatif

Hak legislatif ditetapkan oleh hukum, didasarkan pada konsep keadilan. Contoh: seorang wanita mempunyai hak legal untuk tidak diperkosa suaminya. Hak legislatif mempunyai empat peranan di masyarakat, yaitu membuat peraturan, mengubah peraturan, pembatas moral terhadap peraturan yang tidak adil, dan keputusan keadilan atau menyelesaikan perselisihan

C. Tanggung Jawab/Kewajiban

Tanggung jawab dan kewajiban perawat adalah dua konsep penting dalam praktik keperawatan yang saling berkaitan. Kewajiban adalah tanggung jawab seorang perawat maupun pasien untuk melakukan sesuatu yang memang harus dilaksanakan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hak-haknya. Kewajiban adalah pintu masuknya hak, artinya seorang perawat tidak akan mendapatkan haknya jika ia belum melakukan kewajibannya sebagai seorang perawat. Jika kewajibannya tidak dilaksanakan, perawat bukan hanya tidak bisa menerima hak-haknya tetapi bisa saja terkena sanksi hukum bahkan bisa dikeluarkan dari institusi keperawatan.

Tanggung jawab perawat merujuk pada kewajiban moral, etis, dan profesional yang harus dilakukan oleh perawat dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan keperawatan yang aman, efektif, dan bermutu kepada pasien. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, baik terhadap pasien, profesi, rekan kerja, maupun masyarakat secara umum. Tanggung jawab perawat adalah memastikan bahwa layanan keperawatan diberikan secara etis, profesional, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan pasien. Tanggung jawab perawat sangat luas dan mencakup berbagai aspek, mulai dari perawatan pasien, pemeliharaan kesehatan, hingga etika profesi. Perawat bertanggung jawab untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas, sesuai dengan standar profesi dan hukum yang berlaku, serta menjaga keselamatan dan hak-hak pasien.

D. Hak dan Tanggung Jawab Perawat Menurut Undang-Undang

Bertambahnya kebutuhan pelayanan kesehatan seiring dengan perkembangan zaman menuntut perawat untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang. Saat ini dunia keperawatan semakin berkembang, perawat dianggap sebagai salah satu profesi kesehatan yang harus dilibatkan dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Perawat memiliki peran yang lebih luas dan lebih global dengan penekanan pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, dan juga memandang pasien secara komprehensif.

Perawat menjalankan fungsi dalam kaitannya dengan berbagai peran memberi perawatan, pembuat keputusan klinik dan etika, pelindung, advokat bagi klien, dan lain-lain. Dalam memberikan pelayanan/asuhan keperawatan, perawat memperhatikan individu sebagai makhluk yang holistik dan unik. Peran utama perawat adalah memberikan asuhan keperawatan kepada pasien meliputi asuhan keperawatan, observasi, pendidikan kesehatan dan menjalankan treatment medical sesuai dengan pendelegasian yang diberikan.

Menurut Florence Nightingale, peran perawat adalah menjaga pasien mempertahankan kondisi terbaiknya terhadap masalah kesehatan yang menimpa dirinya. Asuhan keperawatan terdiri dari 5 tahap yang dilakukan perawat mulai dari pengkajian (mengumpulkan data, mengelompokkan data, melakukan analisis data), merumuskan diagnosis keperawatan, merencanakan tindakan keperawatan (Observation, Therapeutic, Education, Collaboration/OTEC), melaksanakan tindakan keperawatan, dan melakukan evaluasi keperawatan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, perawat harus berpedoman pada undangundang yang mengatur pekerjaannya sehingga bisa terhindar dari hal yang merugikan diri sendiri maupun pasien. Adapun ketentuan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, UndangUndang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 647/Menkes/SK/IV/2000 yang kemudian diperbaharui dalam kepmenkes RI Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

Terkait hak dan tanggung jawab/kewajiban perawat, tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 36 dan 37 sebagai berikut:

1. Hak Perawat

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- b. Memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien dan/atau keluarganya
- c. Menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan
- d. Menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- e. Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar

2. Kewajiban Perawat

Kewajiban Perawat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 37 menyatakan bahwa perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan, berkewajiban:

- a. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- b. Memberikan Pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- c. Merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya
- d. Mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar
- e. Memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya
- f. Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat
- g. Melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan.

3. Hubungan Perawat terkait dengan kewajibannya

Dalam pelaksanaan tugasnya, perawat melaksanakan standar pelayanan keperawatan, sehingga bila terjadi suatu kesalahan/kelalaian, maka perawat dapat bertanggung jawab. Oleh karena itu lahirnya hak dan kewajiban perawat, maka hubungan anggota masyarakat dilindungi oleh hukum, dan harus mentaati hubungan hukum ini. Kehendak untuk mentaati hubungan hukum ini disebut tanggung jawab hukum (legal liability). Tanggung jawab hukum dimaksudkan

sebagai perlindungan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Seorang perawat dalam memberikan jasa pelayanan bisa saja melakukan kesalahan/kelalaian. Hal ini akan menimbulkan tuntutan terhadap perawat oleh pasien maupun keluarganya. Demikian juga sebaliknya. Apabila perawat melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka perawat berhak memperoleh haknya sebagaimana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Keperawatan.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, perawat juga mempunyai kewajiban antar perawat dengan klien, dengan praktik keperawatan, dengan masyarakat, teman sejawat, dan profesi keperawatan, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Perawat dan Klien

- 1) Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik, dan agama yang dianut serta kedudukan sosial
- 2) Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari klien
- 3) Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan
- 4) Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

b. Perawat dan Praktik

- 1) Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi dibidang keperawatan melalui belajar terus menerus
- 2) Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien.
- 3) Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain
- 4) Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional.

c. Perawat dan Masyarakat

Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat

d. Perawat dan teman Sejawat

- 1) Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh
- 2) Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan ilegal.

e. Perawat dan Profesi

- 1) Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan
- 2) Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan
- 3) Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi.

E. Tugas dan Wewenang Perawat secara Perorangan

Tugas dan wewenang perawat berdasarkan Pasal 29 (1) Undang-Undang no. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, bahwa dalam menyelenggarakan praktik keperawatan, perawat berwenang, perawat bertugas sebagai:

1. Pemberi Asuhan Keperawatan;
2. Penyuluh dan konselor bagi Klien;
3. Pengelola Pelayanan Keperawatan;
4. Peneliti Keperawatan;
5. Pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
6. Pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.

Sedangkan tugas dan wewenang perawat berdasarkan Pasal 30 (1) bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang:

1. Melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik;
2. Menetapkan diagnosis Keperawatan;
3. Merencanakan tindakan Keperawatan;

4. Melaksanakan tindakan Keperawatan;
5. Mengevaluasi hasil tindakan Keperawatan;
6. Melakukan rujukan;
7. Memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi;
8. Memberikan konsultasi Keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter;
9. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling;
10. Melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada Klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas

F. Wewenang Perawat Sebagai Pemberi Asuhan Keperawatan Di Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat

Menurut Undang-Undang no. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 30 (2), bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat berwenang:

1. Melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat;
2. Menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat;
3. Membantu penemuan kasus penyakit;
4. Merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;
5. Melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;
5. Melakukan rujukan kasus;
6. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat;
8. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
7. Melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;
10. Menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat;
8. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling;
9. Mengelola kasus;
10. Melakukan penatalaksanaan Keperawatan komplementer dan alternatif.

G. Wewenang Perawat Sebagai Penyuluh dan Konselor

Menurut Undang-Undang no. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 31 (1), bahwa dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien, upaya kesehatan masyarakat, perawat berwenang:

1. Melakukan pengkajian Keperawatan secara holistik di tingkat individu dan keluarga serta di tingkat kelompok masyarakat;
2. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat;
4. Menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat;

5. Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling.

H. Wewenang Perawat Sebagai Pengelola Pelayanan Keperawatan

Menurut Undang-Undang no. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 31 (2), bahwa dalam menjalankan tugas sebagai penyuluh dan konselor bagi klien, upaya kesehatan masyarakat, perawat berwenang:

1. Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan;
2. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Pelayanan Keperawatan;
3. Mengelola kasus

I. Wewenang Perawat Sebagai Peneliti Keperawatan

Menurut Undang-Undang no. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 31 (3), bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai peneliti keperawatan, perawat berwenang:

1. Melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika;
2. Menggunakan sumber daya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atas izin pimpinan;
3. Menggunakan pasien sebagai subjek penelitian sesuai dengan etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Wewenang Perawat dalam Keadaan Darurat

Menurut Undang-Undang no. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 35 bahwa dalam keadaan darurat untuk memberikan pertolongan pertama, perawat berwenang:

1. (Ayat 1) Perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya
2. (Ayat 2) Pertolongan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut
3. (Ayat 3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mengancam nyawa atau kecacatan Klien
4. (Ayat 4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya
5. (Ayat 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

K. Latihan

Pilihan Ganda

1. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya sebagai seorang perawat sehingga merasa aman dan nyaman merupakan
 - A. Hak perawat
 - B. Hak pasien
 - C. Kewajiban perawat
 - D. Kewajiban pasien
 - E. Tanggung jawab perawat
2. Tindakan menaati segala peraturan dan tata tertib yang ada di institusi kesehatan dan keperawatan yang memberikan pelayanan kepadanya merupakan
 - A. Hak perawat
 - B. Hak pasien
 - C. Kewajiban perawat
 - D. Kewajiban pasien
 - E. Tanggung jawab perawat
3. Menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan, merupakan:
 - A. Hak perawat
 - B. Hak pasien
 - C. Kewajiban perawat
 - D. Kewajiban pasien
 - E. Tanggung jawab perawat
4. Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi Perawat
 - A. Hak perawat
 - B. Hak pasien
 - C. Kewajiban perawat
 - D. Kewajiban pasien
 - E. Tanggung jawab perawat
5. Hak yang diberikan secara hukum adalah jenis hak:
 - A. Hak kebebasan
 - B. Hak kesejahteraan
 - C. Hak legislatif

- D. Hak azazi
- E. Hak perawat

L. Kunci Jawaban

- 1. A
- 2. C
- 3. A
- 4. C
- 5. C

M. Rangkuman Materi

Hak adalah tuntutan terhadap sesuatu yang seseorang berhak, seperti kekuasaan atau hak istimewa. Kewajiban adalah tanggung jawab seorang perawat maupun pasien untuk melakukan sesuatu yang memang harus dilaksanakan agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hak-haknya. Jenis-jenis hak adalah hak kebebasan, hak kesejahteraan dan hak legislatif. Hak dan kewajiban perawat dan klien harus dipenuhi dalam melaksanakan asuhan keperawatan karena akan mendorong keseimbangan antara tuntutan profesi dengan apa yang semestinya didapatkan dari pengembangan tugas secara maksimal.

N. Glosarium

Kode Etik : salah satu ciri/persyaratan profesi yang memberikan arti penting dalam penentuan, mempertahankan, dan meningkatkan profesi

Legislatif : secara legal/hukum

Malpraktik : praktek yang tidak benar atau mencelakakan, tindakan medis atau pembedahan yang tidak trampil atau keliru

Prognosis : kesembuhan

O. Daftar Pustaka

Amelia, Nindy.2013.Prinsip Etika Keperawatan. Yogyakarta : D-Medika

Aprianti dkk.2024. Buku Ajar Etika Keperawatan. Jakarta: PT Nuansa Fajar Cemerlang

Notoatmodjo, Soekidjo.2010.Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta

Suhaemi, Mimin Emi.2003.Etika Keperawatan : Aplikasi pada Praktik. Jakarta: EGC

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Keperawatan

BAB 5

KODE ETIK KEPERAWATAN INDONESIA

Pendahuluan

Sepanjang perjalanan karier saya sebagai pengajar di institusi Keperawatan, saya termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Salah satu mata kuliah yang saya minati dan ampu adalah Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan. Saya aktif dalam organisasi profesi perawat, yaitu sebagai pengurus DPD PPNI Kota Cirebon dan pengurus IPEMI Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya ingin berkontribusi dalam pengembangan profesi keperawatan. Salah satu fokus utama saya adalah meningkatkan pemahaman anggota tentang pentingnya menjunjung tinggi kode etik. Melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, saya berupaya untuk membekali para perawat dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan etika dalam praktik keperawatan. Buku ini merupakan salah satu upaya untuk memperkaya literatur tentang Kode Etik Keperawatan Indonesia dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan profesi keperawatan di Indonesia.

Profesi keperawatan adalah profesi yang mulia, yang menuntut komitmen tinggi terhadap kesejahteraan pasien. Dalam menjalankan tugasnya, seorang perawat tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, namun juga harus memiliki integritas moral yang tinggi. Pemberian asuhan keperawatan berdasarkan ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh perawat yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Tenaga kesehatan, termasuk perawat harus menaati / memenuhi kode etik, standar profesi, hak pengguna asuhan keperawatan, standar asuhan keperawatan, dan standar prosedur operasional. Kode Etik Perawat Indonesia disusun oleh Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) hadir sebagai landasan etis yang memberikan arah dan pedoman bagi perawat dalam mengambil keputusan dan tindakan dalam setiap situasi yang dihadapi.

Bab ini akan membahas mengenai konsep dan penjabaran kode etik keperawatan Indonesia. Dengan mempelajari bab ini, mahasiswa keperawatan diharapkan dapat menguasai Kode Etik Keperawatan Indonesia secara mendalam. Pemahaman yang baik terhadap kode etik ini akan membekali mahasiswa dengan landasan moral yang kuat dalam menjalankan tugas sebagai perawat profesional, serta membantu mahasiswa mengembangkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas.

Gambaran pembahasan pada Bab ini adalah pengertian, tujuan dan sejarah kode etik keperawatan Indonesia. Pada bab ini juga akan diuraikan perilaku perawat sebagai penjabaran Kode Etik Keperawatan Indonesia serta gambaran kode etik keperawatan menurut ICN dan ANA. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa sub bab, latihan soal, dan dilengkapi dengan rangkuman.

Metode pembelajaran menggunakan teks tulisan yang jelas dan terstruktur, gambar dan ilustrasi, dilengkapi dengan latihan soal beserta kunci jawabannya, serta sumber daya tambahan berupa glosarium. Peserta didik diberikan tugas untuk melakukan role play (bermain peran) sebagai sebagai perawat, pasien, atau pihak terkait lainnya dalam situasi yang berkaitan dengan kode etik. Peserta didik diharapkan mempelajari materi terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas dan latihan soal. Jika menemukan istilah baru, peserta didik dapat melihat glosarium untuk penjelasannya.

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mengikuti pembelajaran mahasiswa mampu menguasai kode etik keperawatan Indonesia yang penting dipahami oleh setiap perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan yang berkualitas di berbagai tatanan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban klien sebagai individu yang harus dilindungi.

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar, diharapkan mahasiswa mampu:

- Menjelaskan pengertian kode etik keperawatan Indonesia
- Mengidentifikasi tujuan kode etik keperawatan Indonesia
- Menjelaskan sejarah perkembangan kode etik keperawatan Indonesia
- Menjelaskan isi kode etik keperawatan Indonesia
- Menjelaskan perilaku perawat sebagai penjabaran kode etik keperawatan Indonesia:
 - Perawat dan klien
 - Perawat dan praktik
 - Perawat dan masyarakat
 - Perawat dan teman sejawat
 - Perawat dan profesi
- Menjelaskan gambaran kode etik keperawatan menurut ICN
- Menjelaskan gambaran kode etik keperawatan menurut ANA

Capaian Pembelajaran Lulusan:

Mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi keperawatan.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

Kognitif:

- Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, sejarah, dan prinsip-prinsip kode etik keperawatan Indonesia
- Mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip kode etik dalam berbagai situasi, seperti dalam hubungan dengan pasien, rekan sejawat, dan masyarakat
- Mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus etika dalam keperawatan dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip kode etik

Psikomotor:

- Mahasiswa mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan kode etik keperawatan dalam interaksi dengan pasien, rekan sejawat, dan masyarakat.
- Mahasiswa mampu melakukan simulasi tindakan keperawatan yang etis dalam berbagai situasi.

Afektif:

- Mahasiswa menerima dan menghargai pentingnya kode etik dalam praktik keperawatan
- Mahasiswa merasa bertanggung jawab untuk menerapkan kode etik dalam setiap tindakan keperawatan
- Mahasiswa mengembangkan karakter sebagai seorang perawat yang profesional dan etis

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari pengertian kode etik keperawatan Indonesia, tujuan kode etik keperawatan Indonesia, sejarah perkembangan kode etik keperawatan Indonesia, isi kode etik keperawatan Indonesia, perilaku perawat sebagai penjabaran kode etik keperawatan Indonesia, dan gambaran kode etik keperawatan menurut ICN dan ANA.

A. Pengertian Kode Etik Keperawatan Indonesia

Sebelum membahas pengertian kode etik keperawatan Indonesia, kita tinjau terlebih dahulu pengertian kode etik dan kode etik perawat. Kode etik diartikan sebagai bagian dari profesionalisasi suatu pekerjaan, digunakan untuk mengatur profesi dan dimaksudkan untuk memandu perilaku etis dalam perawatan kesehatan (Collings-Hughes et al., 2022). Pengertian lainnya, kode etik merupakan pedoman yang mengarahkan perawat dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh perawat telah sesuai dengan nilai-nilai sistem profesional. Kode etik ini menunjukkan adanya hubungan antara nilai-nilai, hak-hak pasien, dan tugas-tugas perawat (Momennasab et al., 2016). Pemikiran Bertens (2002) tidak jauh berbeda, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan atau diterima oleh kelompok profesi, melakukan pembinaan, mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya agar kualitas mutu moral profesi itu di mata masyarakat selalu terjamin (Sadi Is, 2019); (Rosyida, 2021).

Pengembangan kode oleh suatu profesi merupakan bentuk pengaturan diri sehingga suatu profesi menentukan standar perilaku yang diharapkan dari anggota profesi yang sama (Collings-Hughes et al., 2022). Profesi perawat memiliki kode etik keperawatan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan akan prinsip dan standar etika serta pedoman yang tepat guna membantu dalam pengambilan keputusan dan menghadapi tantangan moral. Kode etik tersebut dimaksudkan sebagai standar dalam profesi keperawatan (Momennasab et al., 2016). Kode etik perawat merupakan suatu pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku dan menjadi kerangka kerja dalam membuat suatu keputusan dalam keperawatan (Setiani, 2018).

Kode etik keperawatan merupakan seperangkat pedoman etika dan moral yang disusun oleh organisasi keperawatan untuk memberikan pedoman bagi perawat dalam melakukan praktik keperawatan. Kode etik keperawatan dikembangkan oleh organisasi keperawatan di tingkat internasional, yaitu *International Council of Nurses* (ICN). Selain kode etik keperawatan yang ditetapkan oleh ICN, setiap negara memiliki kode etik keperawatannya sendiri yang disesuaikan dengan konteks budaya, sosial, dan sistem kesehatan masing-masing. Kode etik ini

sering kali mengadopsi prinsip-prinsip umum dari ICN, namun juga mengandung nilai-nilai spesifik yang mencerminkan karakteristik unik dari setiap negara (Febrian, 2023). Beberapa contoh kode etik keperawatan di negara lain seperti kode etik keperawatan yang ditetapkan oleh *American Nurses Association* (ANA) untuk perawat di Amerika, *Nursing and Midwifery Council* (NMC) untuk perawat di Inggris, *Japan Nursing Association* (JNA) untuk perawat di Jepang, dan *Nursing and Midwifery Board of Australia* (NMBA) untuk perawat di Australia.

Kode etik perawat internasional ini merupakan pernyataan nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan akuntabilitas profesional perawat dan mahasiswa keperawatan yang mendefinisikan dan memandu praktik keperawatan etis dalam berbagai peran yang diemban oleh perawat (International Council of Nurses, 2021). Kode etik perawat internasional merupakan manifestasi dari nilai-nilai etika yang menjadi landasan praktik keperawatan di seluruh dunia. Lebih spesifik, pada kode etik perawat internasional memberikan panduan etika terkait peran, tugas, tanggung jawab, perilaku, penilaian profesional, dan hubungan perawat dengan pasien, orang lain yang memerlukan perawatan atau layanan keperawatan, rekan kerja, dan profesional terkait.

Kode etik keperawatan tingkat nasional, dalam hal ini yang berlaku di negara Indonesia, disebut kode etik keperawatan Indonesia, disusun oleh organisasi profesi perawat Indonesia, yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Menurut PPNI (2003), kode etik perawat adalah suatu pernyataan atau keyakinan yang mengungkapkan kepedulian moral, nilai dan tujuan keperawatan. Kode etik keperawatan adalah pernyataan standar profesional yang digunakan sebagai pedoman perilaku perawat dan menjadi kerangka kerja untuk membuat keputusan. Kode etik keperawatan Indonesia adalah aturan yang berlaku untuk seluruh perawat Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perawat (Ardiani, 2018).

Kode etik keperawatan bersifat mendasar dan dibangun berdasarkan hukum, peraturan, dan standar profesional negara yang mengatur praktik keperawatan. Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada bab ketentuan umum, pasal 1, butir ke-12 dinyatakan bahwa "Standar profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan" (Presiden RI, 2014a). Demikian pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan pada pasal 37 ayat 2 dinyatakan bahwa "Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, standar

prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” (Presiden RI, 2014b). Lebih lanjut mengenai standar profesi perawat dipaparkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01/07/Menkes/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat bahwa “Standar profesi perawat terdiri atas standar kompetensi dan kode etik profesi” (Kemenkes RI, 2020). Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan mengacu kepada standar profesi perawat yang meliputi standar kompetensi, standar praktik profesional, standar kinerja profesional dan kode etik keperawatan (Yetti et al., 2017). Standar dan kode etik keperawatan ini yang menjadikan landasan perawat bekerja sesuai dengan kompetensi dan beretika.

Kode etik keperawatan Indonesia diatur dalam Keputusan Musyawarah Nasional IX Nomor: 06/MUNAS IX/PPNI/2015 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Dalam keputusan musyawarah nasional tersebut, diatur bahwa salah satu syarat seseorang yang ingin menjadi anggota PPNI adalah wajib mengisi dan menandatangani formulir kesediaan mentaati Kode Etik Perawat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada bab ketentuan umum, pasal 1, butir ke-10 menyatakan “Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi” (Presiden RI, 2014a). Lebih spesifik tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan pada bagian kedua tentang registrasi pasal 18: (1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR, (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Konsil Keperawatan setelah memenuhi persyaratan, (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. memiliki ijazah pendidikan tinggi Keperawatan; b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi; c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi (Presiden RI, 2014b). Setelah menjadi anggota PPNI, setiap anggota wajib menjunjung tinggi, menaati dan mengamalkan kode etik keperawatan Indonesia. Perawat yang menjunjung tinggi, menaati dan mengamalkan kode etik akan mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas organisasi dan profesi oleh PPNI.

Prinsip-prinsip yang tercantum dalam kode etik berlaku secara universal bagi seluruh profesi keperawatan, tanpa terkecuali. Baik perawat klinis, akademisi (perawat di institusi pendidikan dan mahasiswa keperawatan), peneliti, maupun pembuat kebijakan, semuanya terikat oleh kewajiban etis yang sama (ANA, 2015b). Demikian pula, lingkup penerapan kode etik mencakup seluruh spektrum praktik

keperawatan, dari tingkat individu hingga kebijakan kesehatan masyarakat, baik di rumah sakit, klinik, komunitas, maupun institusi kesehatan lainnya (Epstein & Turner, 2015).

Kode etik keperawatan ini baru bermakna dan efektif ketika prinsip-prinsip di dalamnya diterapkan. Penerapan kode etik secara konsisten dalam berbagai konteks praktik keperawatan merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan tujuan luhur profesi keperawatan, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang bermartabat dan berkualitas. Suksesnya pencapaian tujuan kode etik sangat bergantung pada keberhasilan seluruh tenaga keperawatan dalam memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai etika secara utuh dalam setiap aspek pekerjaan. Pemahaman dan penerapan kode etik juga merupakan bagian integral dari pendidikan dan praktik keperawatan.

B. Tujuan Kode Etik Keperawatan Indonesia

Perumusan kode etik profesi ditujukan untuk kepentingan organisasi profesi dan anggotanya. Secara umum tujuan dari kode etik profesi dalam uraian (Sadi Is, 2019) dan (Rosyida, 2021) adalah:

1. Menjunjung tinggi martabat profesi

Kode etik profesi melarang anggotanya untuk tidak mencemarkan nama baik profesi dan disebut juga kode kehormatan

2. Menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota

Kesejahteraan anggota profesi mencakup kesejahteraan secara fisik, mental maupun spiritual. Anggota profesi dilarang melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan.

3. Meningkatkan pengabdian pada anggota profesi

Anggota profesi diharapkan dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesinya

4. Meningkatkan mutu profesi

5. Meningkatkan mutu organisasi profesi

6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi

7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat

8. Menentukan baku standarnya sendiri

Kode etik keperawatan yang ditetapkan oleh PPNI menjadi pedoman bagi seluruh perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perawat yang terhimpun dalam wadah organisasi PPNI telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien, dengan selalu mengacu pada prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan (Yetti et al., 2017). Kode etik keperawatan disusun dengan tujuan agar perawat dalam menjalankan tugas

dan fungsinya selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat pasien sebagai manusia dan sebagai pedoman dalam berperilaku perawat dalam menjalankan profesi pekerjaannya agar terhindar dari hal-hal yang melanggar kode etik (Momennasab et al., 2016).

Menurut Hasyim, dkk, tujuan kode etik keperawatan adalah:

1. Merupakan dasar dalam mengatur hubungan antar perawat, klien atau pasien, teman sebaya, masyarakat, dan unsur profesi, baik dalam profesi keperawatan maupun dengan profesi lain di luar profesi keperawatan.
2. Merupakan standar untuk mengatasi masalah yang dilakukan oleh praktisi keperawatan yang tidak mengindahkan dedikasi moral dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Mendukung profesi perawat yang dalam menjalankan tugasnya diperlakukan secara tidak adil oleh institusi maupun masyarakat.
4. Merupakan dasar dalam menyusun kurikulum pendidikan keperawatan agar dapat menghasilkan lulusan yang berorientasi pada sikap profesional keperawatan.
5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan keperawatan akan pentingnya sikap profesional dalam melaksanakan tugas praktik keperawatan.

(Pusdiklatnakes Kemenkes RI, 2013) (Ardiani, 2018)

C. Fungsi Kode Etik Profesi

Menurut Abdulkadir Muhammad (1997), kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan (Sadi Is, 2019). Adapun fungsi dari Kode etik profesi diantaranya meliputi:

1. Kode etik ditujukan sebagai acuan kontrol moral atau semacam pengawasan terhadap perilaku anggota profesi, yang memiliki sanksi lebih difokuskan secara psikologis dan kelembagaan. Bagi pelaku profesi yang melanggar, selain menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga dapat bertanggung jawab secara moral berdasarkan kode etik yang berlaku di profesinya
2. Kode etik profesi menuntut terbentuknya integritas moral yang kuat di kalangan pengemban profesi. Dengan integritas moral yang kuat, diharapkan kompleksitas akan akumulasi tantangan dapat dijawab tanpa perlu merusak citra kelembagaan
3. Martabat atau jati diri suatu organisasi profesi akan ditentukan oleh kualitas pemberdayaan kode etik profesional organisasi tersebut. Dengan kode etik

profesi, bukan hanya klien yang bisa diartikulasikan hak-haknya, melainkan kepentingan negara secara umumpun terjaga

4. Kode etik profesi menjadi acuan agar anggota profesi tetap bermartabat dalam profesinya. Dengan adanya kode etik profesi, suatu profesi yang dijalankan akan menghindari komunitas dan interaksi yang tidak baik dan cenderung menoleransi beragam cara melanggar norma-norma.

Sedangkan menurut (Rosyida, 2021), terdapat tiga hal pokok yang menggambarkan fungsi kode etik profesi, yakni:

1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota mengenai prinsip profesionalisme yang telah ditentukan. Keberadaan kode etik profesi memberikan arahan dalam pelaksanaan profesi, perilaku atau hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan
2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Etika profesi memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai makna pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana lapangan kerjanya (kalangan sosial)
3. Kode etik profesi mencegah terjadinya campur tangan pihak diluar organisasi profesi mengenai hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

D. Sejarah Perkembangan Kode Etik Keperawatan Indonesia

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis dari suatu profesi. Kode etik profesi dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota profesi akan selalu mengikuti perkembangan zaman (Sadi Is, 2019). Pengembangan kode etik oleh suatu profesi merupakan bentuk pengaturan diri sehingga suatu profesi menentukan standar perilaku yang diharapkan dari anggota profesi yang sama (Collings-Hughes et al., 2022). Kode etik keperawatan disusun untuk memenuhi kebutuhan akan prinsip dan standar etika serta pedoman yang tepat untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan menghadapi tantangan moral. Kode etik tersebut dimaksudkan sebagai standar dalam profesi keperawatan (Momennasab et al., 2016).

Perjalanan sejarah keperawatan di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga tahap (era) utama yang memiliki pengaruh mendalam terhadap perkembangan pendidikan, praktik, dan penelitian dalam bidang ini. Ketiga era tersebut adalah:

1. Era kolonialisme

Pada masa ini, praktik keperawatan di Indonesia sangat terpengaruh oleh sistem kesehatan kolonial. Pendidikan keperawatan masih sangat terbatas dan

lebih berfokus pada pelayanan dasar. Praktik keperawatan juga lebih bersifat melayani kepentingan penjajah.

2. Era pasca kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, terjadi upaya besar-besaran untuk membangun sistem kesehatan nasional. Pendidikan keperawatan mulai dikembangkan dan diperluas, serta muncul organisasi profesi keperawatan “Persatuan Perawat Nasional Indonesia” (PPNI) pada tanggal 17 Maret 1974 yang menandai tonggak sejarah bagi profesi keperawatan di Indonesia. Pada tanggal tersebut, berbagai organisasi perawat yang ada saat itu, seperti Ikatan Perawat Indonesia (IPI) dan Persatuan Perawat Indonesia (PPI), sepakat untuk bersatu dalam satu wadah yang lebih besar, yaitu PPNI. Praktik keperawatanpun mulai bergeser dari fokus pada penyakit ke arah promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.

3. Era Undang-Undang Keperawatan

Dengan adanya undang-undang keperawatan, praktik keperawatan di Indonesia menjadi lebih terarah dan terukur. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari pendidikan, registrasi, hingga lingkup praktik keperawatan.

(Gede Juanamasta et al., 2021).

Perkembangan kode etik keperawatan di Indonesia juga dapat ditinjau dari tiga tahap berikut:

1. Tahap awal (sebelum kemerdekaan hingga tahun 1950-an)

a. Pengaruh kolonial

Kode etik keperawatan di Indonesia pada masa ini sangat dipengaruhi oleh negara penjajah, terutama Belanda. Prinsip-prinsip etika yang diterapkan lebih bersifat umum dan universal, seperti prinsip-prinsip dalam Kode Etik Internasional (Gede Juanamasta et al., 2021)

b. Fokus pada pelayanan

Kode etik pada tahap ini lebih berfokus pada pelayanan dasar yang diberikan kepada pasien, seperti memberikan perawatan fisik dan memenuhi kebutuhan dasar pasien.

c. Kurangnya spesifik

Kode etik belum terlalu spesifik dan belum banyak mengatur hubungan antara perawat dengan pasien, perawat dengan sesama profesi, maupun perawat dengan masyarakat.

2. Tahap pengembangan (tahun 1960-an hingga 1990-an)

a. Berdirinya PPNI

Peristiwa lahirnya PPNI sebagai wadah pemersatu perawat seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam pengembangan kode etik keperawatan di Indonesia. PPNI berperan aktif dalam merumuskan dan mengembangkan kode etik yang sesuai dengan konteks Indonesia.

b. Fokus pada pengembangan profesi

Kode etik mulai lebih spesifik mengatur tentang tanggung jawab profesi, hubungan antar sesama perawat, dan pengembangan profesi keperawatan.

c. Pengaruh global:

Kode etik keperawatan di Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan kode etik keperawatan di tingkat internasional, seperti *International Council of Nurses* (ICN).

3. Tahap penyempurnaan (tahun 1990-an hingga sekarang)

a. Dinamika kesehatan

Seiring dengan dinamika dunia kesehatan yang semakin kompleks, kode etik keperawatan terus mengalami penyempurnaan. Isu-isu seperti hak pasien, etika penelitian, dan keperawatan komunitas menjadi sorotan utama.

b. Teknologi kesehatan

Perkembangan teknologi kesehatan juga mendorong perubahan dalam kode etik keperawatan. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan menuntut adanya etika yang mengatur penggunaan teknologi tersebut.

c. Globalisasi

Globalisasi membawa dampak pada praktik keperawatan di Indonesia. Kode etik perlu mengakomodasi isu-isu global seperti migrasi tenaga kesehatan dan etika dalam pelayanan kesehatan lintas budaya.

Sepanjang sejarah keperawatan, kode etik telah direvisi secara berkala karena perubahan dalam praktik, teknologi, masalah yang muncul, dan perkembangan masyarakat (Numminen et al., 2024). Demikian pula di Indonesia, perkembangan kode etik tidak lepas dari dinamika yang terjadi dalam masyarakat, dunia kesehatan, dan kebijakan pemerintah.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi perkembangan kode etik keperawatan di Indonesia:

1. Perubahan Paradigma Kesehatan

Paradigma kesehatan adalah kerangka berpikir atau pandangan umum yang mendasari pemahaman kita tentang kesehatan, penyakit, dan cara mengelola

keduanya. Adanya pergeseran paradigma kesehatan dari model kuratif (berfokus pada pengobatan penyakit) ke model promotif dan preventif (berfokus pada pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan) berdampak terhadap perkembangan keperawatan (Suprayitno et al., 2021). Dalam hal ini, termasuk dampaknya terhadap perkembangan kode etik keperawatan.

a. Fokus pada kesehatan masyarakat

Perawat tidak hanya berperan sebagai penyembuh, tetapi juga sebagai promotor kesehatan. Hal ini menuntut perawat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kesehatan masyarakat, seperti edukasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Autonomi pasien

Konsep otonomi pasien semakin ditekankan, sehingga perawat harus menghormati hak pasien untuk menentukan pilihan dalam perawatannya.

c. Kualitas hidup

Kode etik semakin menekankan pentingnya menjaga kualitas hidup pasien, baik fisik maupun psikologis.

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Perkembangan ilmu keperawatan dan ilmu kesehatan lainnya secara terus-menerus mendorong pembaruan kode etik.

a. Teknologi kesehatan

Penggunaan teknologi kesehatan yang semakin canggih, seperti telemedicine dan big data, memerlukan etika yang mengatur pemanfaatan teknologi tersebut.

b. Penelitian keperawatan

Hasil penelitian keperawatan yang terbaru memberikan bukti ilmiah tentang praktik keperawatan yang efektif dan aman, sehingga kode etik perlu disesuaikan dengan temuan-temuan penelitian tersebut.

c. Etika biomedik

Isu-isu etika biomedik seperti euthanasia, transplantasi organ, dan genetika juga memengaruhi perkembangan kode etik keperawatan.

(Numminen et al., 2024)

3. Perubahan Sosial Budaya

Perubahan nilai, norma, dan pandangan masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit turut membentuk perkembangan kode etik keperawatan.

a. Pluralisme

Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya menuntut perawat untuk memahami dan menghormati nilai-nilai budaya yang berbeda.

b. Hak asasi manusia

Peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia mendorong perawat untuk lebih memperhatikan hak-hak pasien, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

c. Peran perempuan

Perubahan peran perempuan dalam masyarakat juga memengaruhi peran perawat. Perempuan semakin aktif dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, sehingga kode etik perlu mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi perempuan.

(Suharnanik, 2023)

4. Regulasi Pemerintah

Peraturan pemerintah yang berkaitan dengan praktik keperawatan, seperti Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Keperawatan, memberikan kerangka hukum bagi pengembangan kode etik.

a. Standar pelayanan

Peraturan pemerintah menetapkan standar pelayanan minimal yang harus dicapai oleh setiap fasilitas kesehatan, termasuk standar pelayanan keperawatan.

b. Lingkup praktik

Undang-undang keperawatan secara jelas mengatur lingkup praktik keperawatan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi perawat dalam menjalankan tugasnya.

c. Tanggung jawab hukum

Peraturan pemerintah juga mengatur tanggung jawab hukum perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan.

(Presiden RI, 2014a) (Presiden RI, 2014b)

E. Isi Kode Etik Keperawatan Indonesia

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat, dinyatakan bahwa standar profesi perawat terdiri dari standar kompetensi dan kode etik profesi. Kode etik profesi sebagai standar profesi ditetapkan oleh organisasi profesi (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Kode etik keperawatan Indonesia ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI). Berikut dikutip dari (PPNI, 2020), uraian Kode Etik Keperawatan Indonesia berdasarkan hasil keputusan musyawarah Nasional VI Peraturan Perawat Nasional Indonesia Nomor 09/MUNAS VI/PPNI/2000:

MUKADIMAH

Sebagai profesi yang turut serta mengusahakan tercapainya kesejahteraan fisik, material dan spiritual untuk makhluk insani dalam wilayah Republik Indonesia, maka kehidupan profesi keperawatan di Indonesia selalu berpedoman kepada sumber asalnya yaitu kebutuhan masyarakat Indonesia akan pelayanan keperawatan.

Warga keperawatan Indonesia menyadari bahwa kebutuhan akan keperawatan bersifat universal bagi klien (individu, keluarga, kelompok dan masyarakat), oleh karenanya pelayanan yang diberikan oleh perawat selalu berdasarkan pada cita-cita yang luhur, niat yang murni untuk keselamatan dan kesejahteraan umat tanpa membedakan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan keperawatan kepada klien, cakupan tanggung jawab Perawat Indonesia adalah meningkatkan derajat kesehatan, mencegah terjadinya penyakit, mengurangi dan menghilangkan penderitaan serta memulihkan kesehatan dilaksanakan atas dasar pelayanan paripurna.

Dalam melaksanakan tugas profesional yang berdaya guna dan berhasil guna, para perawat mampu dan ikhlas memberikan pelayanan yang bermutu dengan memelihara dan meningkatkan integritas pribadi yang luhur dengan ilmu dan keterampilan yang diberikan merupakan bagian dari upaya kesehatan secara menyeluruh.

Dengan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas pengabdian untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan Tanah Air. Persatuan Perawat Indonesia menyadari bahwa Perawat Indonesia menyadari bahwa perawat Indonesia yang berjiwa Pancasila dan menunaikan kewajiban dalam bidang keperawatan dengan penuh tanggung jawab, berpedoman kepada dasar-dasar seperti tertera dibawah ini:

1. Perawat dan klien

- a. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.
- b. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari klien.
- c. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan.

- d. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Perawat dan Praktek
- a. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus menerus.
 - b. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan klien.
 - c. Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain.
 - d. Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional.
3. Perawat dan masyarakat
- Perawat mengemban tanggung jawab bersamaan masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
4. Perawat dan teman sejawat
- a. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
 - b. Perawat bertindak melindungi klien dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etik dan ilegal.
5. Perawat dan profesi
- a. Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkan dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan.
 - b. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan.
 - c. Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi.

F. Perilaku Perawat sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan Indonesia

Sebagai penjabaran dari Kode Etik Keperawatan Indonesia, DPP PPNI telah merumuskan pedoman perilaku perawat yang lebih spesifik. Pedoman ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur sejauhmana perilaku seorang perawat telah merefleksikan nilai-nilai etika profesi dalam tatanan pekerjaan dan kehidupan profesinya yang mengacu kepada kode etik keperawatan yaitu: 1) perawat dan klien; 2) perawat dan praktik; 3) perawat dan masyarakat; 4) perawat dan teman sejawat; 5) perawat dan profesi. Adapun tujuan penilaian pedoman perilaku sebagai penjabaran kode etik keperawatan adalah sebagai bahan evaluasi kinerja perawat dalam tatanan pekerjaan dan kehidupan profesi, dan bahan penilaian perilaku yang berkaitan dengan masalah etik keperawatan.

Berikut ini adalah uraian dari pedoman perilaku perawat sebagai penjabaran kode etik keperawatan Indonesia DPP PPNI yang telah disusun oleh tim penyusun DPP PPNI pada tahun 2017 :

1. Perawat dan klien

- a. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.

Perilaku yang dapat diukur meliputi:

- 1) Perawat wajib memperkenalkan diri kepada klien dan keluarganya
- 2) Perawat wajib menjelaskan setiap intervensi keperawatan yang dilakukan pada klien dan keluarga
- 3) Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan dilarang / tidak mencela adat kebiasaan dan keadaan khusus klien
- 4) Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan dilarang / tidak membedakan pelayanan atas dasar kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial pada klien

- b. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama

Perilaku yang dapat diukur meliputi:

- 1) Perawat pada awal bertemu klien, wajib menjelaskan bahwa mereka boleh menjalankan / diizinkan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan budaya, adat dan agama

- 2) Perawat dalam memberikan pelayanan wajib memfasilitasi pelaksanaan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dan wajib mencari solusi yang akan berpihak pada klien bila terjadi konflik terkait nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama
 - 3) Perawat wajib membantu klien memenuhi kebutuhannya sesuai dengan budaya, adat istiadat dan agama
 - 4) Perawat wajib mengikut sertakan klien secara terus menerus pada saat memberikanasuhan keperawatan
- c. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan.
- Perilaku yang dapat diukur meliputi:
- 1) Perawat wajib melaksanakan asuhan keperawatan sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO)
 - 2) Perawat wajib melaksanakan intervensi keperawatan sesuai dengan kompetensinya
 - 3) Perawat wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan sesuai SPO
- d. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Perilaku yang dapat diukur meliputi:
- 1) Perawat tidak memberikan informasi tentang klien kepada orang yang tidak berkepentingan
 - 2) Perawat tidak mendiskusikan klien di tempat umum
 - 3) Perawat menjaga kerahasiaan dokumen klien

2. Perawat dan praktik

- a. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus menerus.
- Perilaku yang dapat diukur meliputi:
- 1) Perawat selalu mengikuti kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan sesuai dengan kemampuan
 - 2) Perawat menerapkan dalam praktik sehari-hari ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam memberikan pelayanan
 - 3) Perawat harus mempublikasikan ilmu dan keterampilan yang dimiliki baik dalam bentuk hasil penelitian maupun presentasi kasus diantaranya *journal reading*, laporan kasus (*case report*), dan *summary report*
 - 4) Perawat melakukan evaluasi diri terhadap pencapaian hasil asuhan keperawatan.

- b. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien.

Perilaku yang dapat diukur meliputi:

- 1) Perawat mengikuti dan melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan dan penjaminan mutu antara lain: GKM (Gugus Kendali Mutu), diskusi kasus, dan seterusnya
 - 2) Perawat selalu melakukan evaluasi terhadap perawat lain yang menjadi tanggungjawabnya dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru
 - 3) Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan wajib mengidentifikasi asuhan keperawatan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien
 - 4) Perawat wajib menyampaikan kepada atasan langsung, apabila menemukan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien untuk selanjutnya ditindak-lanjuti
 - 5) Perawat dalam memberikan intervensi keperawatan wajib merujuk pada standar yang dikeluarkan institusi pelayanan kesehatan
 - 6) Perawat menggunakan teknologi keperawatan yang telah diuji validitas (kehandalan) dan reliabilitas (keabsahan) oleh lembaga yang berwenang
- c. Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain.

Perilaku yang dapat diukur meliputi:

- 1) Perawat selalu menggunakan data akurat dalam mengambil keputusan
 - 2) Perawat mendelegasikan pekerjaan harus menggunakan komunikasi yang jelas dan lengkap
 - 3) Perawat bertanggung jawab dalam pembinaan moral staf
 - 4) Perawat harus membuat laporan terkait tugas yang dilimpahkan
 - 5) Perawat harus menjalankan tugas sesuai yang didelegasikan
 - 6) Perawat memberikan masukan berkaitan dengan kasus yang dikonsulkan sesuai dengan tingkatan penerima konsultasi
- d. Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional.

Perilaku yang dapat diukur meliputi:

- 1) Perawat selalu berpenampilan rapih dan wangi

- 2) Perawat selalu dapat menjawab pertanyaan klien sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki
- 3) Perawat selalu menepati janji
- 4) Perawat selalu ramah
- 5) Perawat menggunakan seragam yang bersih dan sesuai dengan norma kesopanan
- 6) Perawat berbicara dengan lemah lembut

3. Perawat dan masyarakat

Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

Perilaku yang dapat diukur meliputi:

- a. Perawat memperlihatkan perilaku hidup sehat di lingkungannya
- b. Perawat melakukan pembimbingan kepada masyarakat untuk hidup sehat dengan berpartisipasi aktif dalam tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif
- c. Perawat melaksanakan gerakan masyarakat sehat, seperti perilaku hidup sehat, hand hygiene, dan lain-lain
- d. Perawat mengajarkan masyarakat tentang bencana
- e. Perawat mengajarkan masyarakat menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman
- f. Perawat melakukan penelitian dan menerapkan praktik berbasis bukti dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

4. Perawat dan teman sejawat

- a. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Perilaku yang dapat diukur meliputi:

- 1) Perawat mendiskusikan hal-hal terkait profesi secara berkala dengan sejawat
- 2) Perawat dalam menyampaikan pendapat terhadap sejawat, menggunakan rujukan yang diakui kebenarannya
- 3) Perawat menghargai dan bersikap terbuka terhadap pendapat teman sejawat
- 4) Perawat menciptakan lingkungan yang kondusif (keserasian suasana dan memperhatikan privacy)
- 5) Perawat menghargai sesama perawat seperti keluarga sendiri.

- b. Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan ilegal

Perilaku yang dapat diukur meliputi:

- 1) Perawat mempraktikkan penyelesaian yang terjadi antar sejawat sesuai alur penyelesaian masalah
- 2) Perawat melaporkan sejawat yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar, etik, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Perawat menegur sejawat atas perilaku yang tidak kompeten, tidak etik dan tidak legal
- 4) Perawat membina sejawat agar memelihara tindakan yang kompeten, etis, dan legal

5. Perawat dan profesi

- a. Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan.

Perilaku yang dapat diukur meliputi:

- 1) Perawat menyusun standar yang dibutuhkan profesi di institusi pelayanan dan pendidikan
- 2) Perawat wajib memfasilitasi kebutuhan belajar mahasiswa sebagai calon anggota profesi
- 3) Perawat melakukan sosialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam lingkup profesi di institusi pelayanan dan pendidikan
- 4) Perawat wajib menjaga nama baik profesi dan simbol-simbol organisasi profesi termasuk di media sosial dan lainnya.

- b. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan.

Perilaku yang dapat diukur meliputi:

- 1) Perawat melaksanakan kajian asuhan keperawatan yang diberikan secara terus menerus dengan bimbingan perawat yang ditunjuk
- 2) Perawat menyampaikan hasil kajian asuhan keperawatan dalam forum temu ilmiah perawat pada institusi terkait

- c. Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi.

Perilaku yang dapat diukur meliputi:

- 1) Perawat harus aktif memberikan usulan terhadap pihak terkait agar tersedia sarana prasarana untuk kelancaran asuhan keperawatan

- 2) Perawat wajib menyampaikan asuhan keperawatan yang telah dilakukannya pada setiap serah terima
- 3) Perawat penanggung jawab wajib memastikan terlaksananya asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat pelaksana yang ada dibawah tanggung jawabnya
- 4) Perawat penanggung jawab wajib menyampaikan perkembangan asuhan keperawatan kepada penanggung jawab perawatan yang lebih tinggi secara berkala.

(Yetti et al., 2017)

G. Kode Etik Keperawatan Menurut International Council Nursing (ICN)

ICN didirikan oleh Mrs. Bedford Fenwick pada tahun 1899, merupakan organisasi profesi keperawatan internasional pertama di dunia. Sebagai federasi perhimpunan perawat global, ICN bertujuan untuk menyatukan para perawat di seluruh dunia, memfasilitasi diskusi mengenai isu-isu keperawatan, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan keperawatan berdasarkan kode etik profesi. Kode etik keperawatan menurut ICN (1973) menegaskan bahwa keperawatan bersifat universal. Keperawatan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Rumusan kode etik keperawatan yang dirumuskan oleh ICN adalah:

1. Perawat melaksanakan pelayanan dengan menghargai hakikat manusia dan keunikan klien, tidak membedakan sosial ekonomi, keadaan pribadi, atau hakikat masalah kesehatan
2. Perawat menyelamatkan hak klien dengan memelihara hak klien
3. Perawat menyelamatkan klien atau masyarakat bila asuhan dan keamanan kesehatan klien dijamah oleh orang yang tidak berwenang, tidak sesuai etik, atau tidak resmi
4. Perawat bertanggung jawab atas kegiatan dan pertimbangan keperawatan kepada seseorang
5. Perawat membina kompetensi keperawatan
6. Perawat menggunakan pertimbangan akan kualifikasi kompetensi orang yang akan diminta konsultasi atau diberi tanggung jawab dan menerima delegasi tugas
7. Perawat turut serta dalam usaha profesi untuk mengadakan dan membina keadaan tugas tenaga kerja yang memungkinkan untuk mencapai kualitas keperawatan yang tinggi
8. Perawat turut serta dalam kegiatan pengembangan profesi ilmu pengetahuan
9. Perawat turut serta dalam usaha profesi untuk melindungi umum dari informasi yang salah dan penyajian yang salah untuk memelihara integrasi keperawatan

10. Perawat berkolaborasi dengan anggota profesi kesehatan dan warga lain dalam meningkatkan usaha nasional dan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan kesehatan masyarakat.

(Pusdiklatnakes Kemenkes RI, 2013) (Ardiani, 2018)

H. Kode Etik Keperawatan Menurut American Nurses Association (ANA)

Kode Etik Keperawatan dari American Nurses Association (ANA) menjadi acuan utama bagi perawat di Amerika dalam menjalankan praktik keperawatan yang etis. Kode etik ini menyoroti pentingnya menempatkan martabat manusia sebagai pusat dari segala tindakan keperawatan. ANA menekankan bahwa perawat memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada pasien.

Kode etik keperawatan ANA mencakup seperangkat prinsip etika yang dirancang untuk memandu perawat dalam pengambilan keputusan dan membantu untuk membedakan yang benar dari yang salah. Dokumen formal yang disediakan ANA sebagai kerangka kerja untuk pelayanan keperawatan yang etis dan memandu perawat selama pengambilan keputusan berjudul Kode Etik untuk Perawat dengan Pernyataan Interpretatif atau disebut juga Kode Etik Keperawatan. Kode Etik Keperawatan ini berisikan pernyataan ringkas tentang nilai-nilai etika, kewajiban, tugas, dan cita-cita profesional perawat secara individu dan kolektif. Kode etik ini menjadi standar yang harus dipenuhi oleh setiap anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

Kode Etik Keperawatan ANA menyatakan bahwa, "Individu yang menjadi perawat diharapkan untuk mematuhi cita-cita dan norma moral profesi dan juga menerimanya sebagai bagian dari apa artinya menjadi seorang perawat". Etika dalam profesi keperawatan memiliki karakteristik unik, yaitu bersifat:

1. Refleksif, bermakna:

- a. Bersifat dinamis: Etika keperawatan selalu berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, teknologi, dan nilai-nilai masyarakat.
- b. Berakar pada pengalaman: Etika keperawatan terus diperkaya oleh pengalaman perawat-perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Setiap interaksi dengan pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki praktik keperawatan.
- c. Berbasis bukti: Keputusan etis dalam keperawatan tidak hanya didasarkan pada intuisi, namun juga didasarkan pada bukti-bukti ilmiah dan hasil penelitian.

2. Abadi, bermakna:

- a. Nilai-nilai universal: Meskipun telah terjadi perubahan dan zaman terus berkembang, namun nilai-nilai dasar dalam etika keperawatan seperti kemanusiaan, kasih sayang, dan tanggung jawab tetap relevan.
- b. Warisan sejarah: Etika keperawatan memiliki akar sejarah yang panjang, dan nilai-nilai etika telah diwariskan dari generasi ke generasi.
- c. Prinsip-prinsip fundamental: Prinsip-prinsip etika seperti otonomi, beneficence, nonmaleficence, dan justice menjadi landasan yang kokoh bagi praktik keperawatan.

3. Khas, bermakna:

- a. Identitas profesi: Etika keperawatan dapat membedakan profesi keperawatan dengan profesi kesehatan lainnya.
- b. Fokus pada pasien: Etika keperawatan menempatkan pasien sebagai pusat perhatian, dengan fokus pada kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual pasien.
- c. Hubungan interpersonal: Etika keperawatan menekankan pentingnya membangun hubungan yang terapeutik dengan pasien dan keluarga.

Kode etik keperawatan menjelaskan tujuan utama, nilai, dan kewajiban profesi secara eksplisit. Kode etik keperawatan berdasarkan American Nurses Association (ANA) tahun 2015 memuat sembilan ketentuan. Setiap ketentuan memuat beberapa pernyataan klarifikasi atau "interpretatif". Berikut adalah ringkasan dari sembilan ketentuan tersebut:

Ketentuan 1: Perawat berpraktik dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat terhadap martabat, harga diri, dan atribut unik yang melekat pada setiap orang. Penjabarannya:

1. Respect for human dignity (menghormati martabat manusia)
2. Relationships with patients (hubungan dengan pasien)
3. The Nature of health (hakikat kesehatan)
4. The right to self-determination (hak untuk menentukan nasib sendiri)
5. Relationships with colleagues and other (hubungan dengan rekan kerja dan orang lain)

Ketentuan 2: Komitmen utama perawat adalah kepada klien, baik individu, keluarga, kelompok, komunitas, atau populasi.

Penjabarannya:

1. Primary of the patient's interest (kepentingan utama pasien)
2. Conflict of interest for nurses (konflik kepentingan bagi perawat)

3. Collaboration (kolaborasi)
4. Professional boundaries (batasan profesional)

Ketentuan 3: Perawat mempromosikan, mengadvokasi, dan melindungi hak, kesehatan, dan keselamatan klien.

1. Protection of the right of privacy and confidentiality (perlindungan hak privasi dan kerahasiaan)
2. Protection of human participants in research (perlindungan terhadap partisipan manusia dalam penelitian)
3. Performance standards and review mechanisms (standar kinerja dan mekanisme peninjauan)
4. Professional responsibility in promoting a culture of safety (tanggung jawab profesional dalam mempromosikan budaya keselamatan)
5. Protection of patient health and safety by acting on questionable practice (perlindungan kesehatan dan keselamatan pasien dengan bertindak berdasarkan praktik yang dipertanyakan)
6. Patient protection and impaired practice (perlindungan pasien dari hambatan atau gangguan dalam praktik)

Ketentuan 4: Perawat memiliki wewenang, akuntabilitas, dan tanggung jawab atas praktik keperawatan; membuat keputusan; dan mengambil tindakan yang konsisten dengan kewajiban untuk mempromosikan kesehatan dan memberikan perawatan yang optimal.

1. Authority, accountability, and responsibility (wewenang, akuntabilitas, dan tanggung jawab)
2. Accountability for nursing judgements, decisions, and actions (akuntabilitas atas penilaian, keputusan, dan tindakan keperawatan)
3. Responsibility for nursing judgment, decisions, and actions (tanggung jawab atas penilaian, keputusan, dan tindakan keperawatan)
4. Assignment and delegation of nursing activities or tasks (penugasan dan pendelegasian kegiatan atau tugas keperawatan)

Ketentuan 5: Perawat memiliki tugas yang sama terhadap dirinya sendiri seperti terhadap orang lain, termasuk tanggung jawab untuk mempromosikan kesehatan dan keselamatan, menjaga keutuhan karakter dan integritas, menjaga kompetensi, dan melanjutkan pengembangan pribadi dan profesional.

1. Duties to self and others (tugas terhadap diri sendiri dan orang lain)

2. Promotion of personal health, safety, and well-being (meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pribadi)
3. Preservation of wholeness of character (menjaga keutuhan karakter)
4. Preservation of integrity (menjaga integritas)
5. Maintenance of competence and continuation of professional growth (menjaga kompetensi dan melanjutkan pertumbuhan profesional)
6. Continuation of personal growth (melanjutkan pengembangan pribadi)

Ketentuan 6: Perawat, melalui upaya individu dan kolektif, membangun, memelihara, dan meningkatkan lingkungan etika lingkungan kerja dan kondisi kerja yang kondusif untuk perawatan kesehatan yang aman dan berkualitas.

1. The environment and moral virtue (lingkungan dan kebajikan moral)
2. The environment and ethical obligation (lingkungan dan kewajiban etis)
3. Responsibility for the healthcare environment (tanggung jawab terhadap lingkungan layanan kesehatan)

Ketentuan 7: Perawat, dalam semua peran dan lingkungan, memajukan profesi melalui penelitian dan penyelidikan ilmiah, pengembangan standar profesional, dan pembuatan kebijakan keperawatan dan kesehatan.

1. Contributions through research and scholarly inquiry (Kontribusi melalui penelitian dan penyelidikan ilmiah)
2. Contributions through developing, maintaining, and implementing professional practice standards (kontribusi melalui pengembangan, pemeliharaan, dan penerapan standar praktik profesional)
3. Contributions through nursing and health policy development (Kontribusi melalui pengembangan kebijakan keperawatan dan kesehatan)

Ketentuan 8: Perawat berkolaborasi dengan profesional kesehatan lain dan masyarakat untuk melindungi hak asasi manusia, mempromosikan diplomasi kesehatan, dan mengurangi kesenjangan kesehatan.

1. Health is a universal right (kesehatan adalah hak asasi manusia)
2. Collaboration for health, human rights, and health diplomacy (kolaborasi untuk kesehatan, hak asasi manusia, dan diplomasi kesehatan)
3. Obligation to advance health and human rights in complex, extreme, or extraordinary practice setting (kewajiban untuk memajukan kesehatan dan hak asasi manusia dalam praktik yang kompleks, ekstrim, atau luar biasa)

Ketentuan 9: Profesi keperawatan, secara kolektif melalui organisasi profesionalnya, harus mengartikulasikan nilai-nilai keperawatan, menjaga integritas profesi, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan sosial ke dalam kebijakan keperawatan dan kesehatan.

1. Articulation and assertion of value (artikulasi dan penegasan nilai)
2. Integrity of the profession (integritas profesi)
3. Integrating social justice (mengintegrasikan keadilan sosial)
4. Social justice in nursing and health policy (keadilan sosial dalam kebijakan keperawatan dan kesehatan)

(American Nurses Association, 2015)

I. Latihan

Pilihan Ganda

1. Kode etik keperawatan Indonesia disusun oleh...
 - A. Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia
 - B. Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia
 - C. Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia
 - D. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia
 - E. Dewan Pertimbangan Persatuan Perawat Nasional Indonesia
2. Tujuan etika profesi keperawatan adalah...
 - A. Menginspirasi kelompok berperilaku etik dan menyadari pertimbangan-pertimbangan etik dalam berperilaku
 - B. Memberikan penekanan terhadap aspek-aspek pertimbangan etik yang memberikan integritas sebagai profesi
 - C. Menetapkan standar untuk bertindak secara etik dalam melakukan praktik pelayanan keperawatan kepada masyarakat
 - D. Mengindikasikan harapan masyarakat umum dari anggota kelompok profesi dan menentukan kebijakan kesehatan masyarakat
 - E. Menciptakan dan mempertahankan kepercayaan klien kepada perawat, kepercayaan di antara sesama perawat, dan kepercayaan masyarakat kepada profesi perawat
3. Kode Etik Keperawatan Indonesia berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional mengatur tentang hubungan perawat dengan...
 - A. Klien dan keluarga klien
 - B. Rekan kerja dan atasan
 - C. Klien, praktik, masyarakat, teman sejawat, dan profesi

- D. Pasien, dokter, dan rumah sakit
 - E. Institusi pendidikan dan tenaga medis lainnya
4. Perawat membuat keputusan didasarkan kepada informasi yang adekuat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang apabila melakukan konsultasi, menerima delegasi atau pelimpahan kewenangan, dan memberikan delegasi kepada orang lain. Hal ini merupakan salah satu kode etika yang mengatur hubungan antara...
- A. Perawat dan klien
 - B. Perawat dan profesi
 - C. Perawat dan praktik
 - D. Perawat dan masyarakat
 - E. Perawat dan teman sejawat
5. Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berkewajiban memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan...
- A. Kode etik, standar profesi, standar pelayanan keperawatan dan standar operasional prosedur
 - B. Standar profesi, standar operasional prosedur dan ketentuan Peraturan perundang-undangan
 - C. Standar operasional prosedur, kode etik dan berprinsip pada kebutuhan pelayanan kesehatan oleh masyarakat
 - D. Ketentuan peraturan perundang-undangan, SOP, kode etik, standar profesi dan standar pelayanan keperawatan
 - E. Standar pelayanan asuhan keperawatan, prosedur tetap yang diberlakukan di institusi pelayanan kesehatan tersebut

J. Kunci Jawaban

Kunci jawaban dari soal pilihan ganda tersebut adalah:

- 1. D
- 2. E
- 3. C
- 4. C
- 5. D

K. Soal Essay

Petunjuk: *Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan lengkap!*

- 1. Jelaskan pengertian kode etik keperawatan menurut pandangan profesional!

2. Sebutkan dan jelaskan lima pokok hubungan yang diatur dalam Kode Etik Keperawatan Indonesia!
3. Mengapa perawat wajib menjaga kerahasiaan informasi klien? Berikan contoh situasi yang menggambarkan penerapan prinsip ini!
4. Bagaimana peran perawat dalam menjalin hubungan profesional dengan masyarakat? Jelaskan dengan memberikan dua contoh konkret!
5. Jelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perawat untuk meningkatkan kompetensi dan menjaga standar mutu pelayanan keperawatan!

L. Rangkuman Materi

Kode Etik Keperawatan Indonesia adalah pedoman moral dan profesional yang disusun oleh Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) untuk mengarahkan perilaku etis perawat dalam melaksanakan tugasnya. Perawat perlu memahami dan menerapkan kode etik keperawatan agar dapat membuat keputusan yang etis, menghindari pelanggaran etika dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kode etik keperawatan Indonesia terdiri dari 5 pokok etik yaitu: 1) perawat dan klien; 2) perawat dan praktek; 3) perawat dan masyarakat; 4) perawat dan teman sejawat; 5) perawat dan profesi. Kode etik bertujuan untuk: 1) menjunjung tinggi martabat profesi perawat, 2) menjadi acuan dalam menghadapi dilema etika, 3) meningkatkan profesionalisme dalam layanan keperawatan, dan 4) memberikan perlindungan hukum kepada perawat yang bertindak sesuai standar. Sejarah perkembangan kode etik mencerminkan transformasi profesi keperawatan di Indonesia, dari era kolonial hingga penyempurnaan pada masa modern dengan pengakuan hukum dan standar internasional. Penerapan prinsip etika dalam praktik keperawatan merupakan kunci untuk mencapai pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menjunjung tinggi martabat serta integritas profesi.

M. Glosarium

A

ANA (American Nurses Association): organisasi profesi keperawatan nasional di Amerika Serikat.

Asuhan Keperawatan: Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat kepada individu, keluarga, atau masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan memulihkan kondisi kesehatan.

B

Budaya Keselamatan: Upaya berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keamanan pasien dan profesional kesehatan.

C

Caring: Prinsip mendasar dalam keperawatan yang mencakup perhatian, empati, dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan pasien dengan sepenuh hati.

D

Delegasi: Penyerahan tugas atau tanggung jawab dari satu perawat kepada perawat lain yang memiliki kompetensi untuk melaksanakannya.

E

Edukasi Kesehatan: Proses pemberian informasi kepada pasien atau masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam menjaga kesehatan.

Etika: Prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam lingkungan profesional.

H

Hak Pasien: Hak yang dimiliki pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan menghormati nilai-nilai, keyakinan, dan keunikan pribadi mereka.

I

ICN (International Council of Nurses): Organisasi profesi keperawatan internasional yang menyusun kode etik global untuk perawat di seluruh dunia.

Integritas: Sikap jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam setiap tindakan profesional.

K

Kerahasiaan: Prinsip menjaga informasi pasien tetap aman dan hanya digunakan untuk tujuan medis sesuai persetujuan pasien.

Kode Etik: Seperangkat pedoman etika dan moral yang disusun oleh suatu organisasi profesi untuk mengatur perilaku dan keputusan anggotanya dalam menjalankan profesi.

Kode Etik ANA (American Nurses Association): Pedoman etika profesi yang dirancang oleh American Nurses Association untuk perawat di Amerika Serikat, yang juga diadaptasi dalam beberapa prinsip global.

Kode Etik Keperawatan: Seperangkat pedoman etika dan moral yang dirancang untuk membantu perawat mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai profesi keperawatan.

Kompetensi: Kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memberikan pelayanan keperawatan yang aman dan bermutu.

O

Otonomi Pasien: Hak pasien untuk mengambil keputusan sendiri terkait perawatan kesehatan yang diterima berdasarkan informasi yang lengkap dan jelas.

P

Pelayanan Paripurna: Pendekatan holistik dalam keperawatan yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual pasien.

Perilaku Profesional: Tindakan yang mencerminkan sikap bertanggung jawab, etis, dan menghormati semua pihak terkait dalam praktik keperawatan.

PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia): Organisasi profesi yang menaungi perawat di Indonesia, yang bertanggung jawab menyusun dan mengawasi pelaksanaan kode etik keperawatan.

Privacy Pasien: Hak pasien untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi, termasuk data kesehatan, dari pihak yang tidak berkepentingan.

Profesionalisme: Sikap, perilaku, dan komitmen seorang profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar etika, kompetensi, dan tanggung jawab.

S

Standar Profesi: Batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dimiliki oleh perawat dalam menjalankan tugasnya.

Standar Operasional Prosedur (SOP): Pedoman yang mengatur langkah-langkah kerja untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan.

T

Tanggung Jawab Profesional: Kewajiban perawat untuk bertindak sesuai dengan standar dan kode etik profesi dalam semua aspek pekerjaannya.

N. Daftar Pustaka

- American Nurses Association. (2015). *Code of Ethics for Nurses With Interpretive Statements: View the Code of Ethics for Nurses*. [ursingworld.org/practice-policy/nursing-excellence/ethics/code-of-ethics-for-nurses/](https://nursingworld.org/practice-policy/nursing-excellence/ethics/code-of-ethics-for-nurses/)
- Ardiani, N. D. (2018). Modul Ajar Etika Keperawatan. *STIKes Kusuma Husada Surakarta, 1*, 1–63. http://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/676/1/MODUL_AJAR_ETIKA_KEPERAWATAN.pdf
- Collings-Hughes, D., Townsend, R., & Williams, B. (2022). Professional codes of conduct: A scoping review. *Nursing Ethics, 29*(1), 19–34. <https://doi.org/10.1177/09697330211008634>
- Epstein, B., & Turner, M. (2015). The Nursing Code of Ethics: Its Value, Its History. *The Online Journal of Issues in Nursing, 20*(2).
- Febrian, P. S. (2023). *Mengenal Kode Etik Keperawatan*. <https://www.bersamaperawat.id/2023/03/mengenal-kode-etik-keperawatan.html>
- Gede Juanamasta, I., Iblasi, A. S., Aunguroch, Y., & Yunibhand, J. (2021). Nursing Development in Indonesia: Colonialism, After Independence and Nursing act. *SAGE Open Nursing, 7*(662). <https://doi.org/10.1177/23779608211051467>
- International Council of Nurses. (2021). The ICN Code of Ethics for Nurses: Revised 2021. In *International Council of Nurses*. https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/2012_ICN_Codeofethicsfornurses_eng.pdf
- Kemendes RI. (2020). Standar Profesi Perawat. In *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia* (Vol. 3, Issue 1). http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=bth&AN=92948285&site=eds-live&scope=site%0Ahttp://bimimpactassessment.net/sites/all/themes/bcorp_impact/pdfs/em_stakeholder_engagement.pdf%0Ahttps://www.glo-bus.com/help/helpFiles/CDJ-Pa
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor

HK.01.07/Menkes/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat.
*File:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJA_P
RINT.Docx*. www.bpkp.go.id

- Momennasab, M., Koshkaki, A. R., Torabizadeh, C., & Tabei, S. Z. (2016). Nurses' adherence to ethical codes: The viewpoints of patients, nurses, and managers. *Nursing Ethics*, 23(7), 794–803. <https://doi.org/10.1177/0969733015583927>
- Numminen, O., Kallio, H., Leino-Kilpi, H., Stokes, L., Turner, M., & Kangasniemi, M. (2024). Use and impact of the ANA Code: a scoping review - seems ok - no revisions. *Nursing Ethics*, 31(8), 1389–1412. <https://doi.org/10.1177/09697330241230522>
- PPNI. (2020). *Kode Etik Keperawatan Indonesia*. 21(1), 1–9.
- Presiden RI. (2014a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*.
- Presiden RI. (2014b). *Undang-Undang RI No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan*.
- Pusdiklatnakes Kemenkes RI. (2013). *Modul 1. Etika dan Kode Etik Keperawatan*. Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI.
- Rosyida, D. A. C. (2021). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan pada Petugas Pelayanan Kesehatan* (1st ed.). PT Refika Aditama.
- Sadi Is, M. (2019). *Etika dan Hukum Kesehatan di Indonesia* (3rd ed.). PrenadaMedia Group.
- Suharnanik. (2023). *Buku Ajar Sosiologi Kesehatan* (1st ed.). UWKS Press.
- Suprayitno, E., Indarna, A. A., Mirwanti, R., Mailita, W., Sari, S. M., Anggreny, Y., Dinaryanti, R. S., Agustina, H. S., Susilowati, Y. A., Yuningsih, A., Sukri, Hadi, I., Haeriyah, Y. S., Apriani, N., Sukrang, Drajat, A. M., & Sihombing, F. (2021). Buku Ajar Falsafah & Teori Keperawatan: Berdasarkan Kurikulum Pendidikan Ners Indonesia Tahun 2021. In *Keperawatan*. Eureka Media Aksara.
- Yetti, K., Ely L, A., Sumijatun, Asmara, G., Sudarsana, I. D. A. K., Sudibyo, Y. W., Bakaruddin, M., Fadhilah, H., Mustikasari, Aprisunadi, & Azzam, R. (2017). Pedoman Perilaku Sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan. In *Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI)*. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI).

BAB 6

HUKUM KESEHATAN DAN KEPERAWATAN

Tujuan Instruksional:

- Menjelaskan tentang definisi hukum Kesehatan
- Menjelaskan definisi Hukum Keperawatan
- Menjelaskan fungsi hukum dalam kesehatan dan keperawatan
- Menjelaskan tentang malpraktik dalam keperawatan

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu memahami hukum kesehatan dan hukum keperawatan di Indonesia

Uraian Materi

Hukum kesehatan dan hukum keperawatan adalah dua bidang hukum yang berkaitan erat dengan praktik medis dan pelayanan kesehatan. Keduanya berfungsi sebagai landasan hukum untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat, menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik secara etika maupun hukum.

Hukum kesehatan secara umum mencakup berbagai peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, hak dan kewajiban pasien serta tenaga medis, perizinan fasilitas kesehatan, hingga tanggung jawab hukum dalam kasus malpraktik medis. Sementara itu, hukum keperawatan lebih spesifik mengatur aspek hukum dalam profesi keperawatan, termasuk standar praktik keperawatan, hak dan kewajiban perawat, serta konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran dalam pelayanan keperawatan.

Pentingnya hukum kesehatan dan hukum keperawatan terletak pada perlindungan terhadap pasien dan tenaga kesehatan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan profesional, aman, dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

A. Definisi Hukum Kesehatan

Hukum Kesehatan adalah pengetahuan yang mengkaji bagaimana sebuah penegakan aturan hukum terhadap akibat pelaksanaan suatu tindakan medik/kesehatan yang dilakukan oleh pihak yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan yang dapat dijadikan dasar bagi kepastian tindakan hukum dalam dunia kesehatan. (siplawfirm, 2023)

"Hukum kesehatan adalah seperangkat ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penegakannya, serta hak dan kewajiban perseorangan dan pada semua lapisan masyarakat sebagai pelayanan kesehatan. penerima dan penyedia layanan kesehatan dalam semua aspek organisasi; sarana pedoman kesehatan nasional atau internasional, hukum di bidang kedokteran, hukum kasus dan ilmu di bidang kedokteran. Hukum kesehatan adalah bagian dari hukum kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. (Zahran, 2024)

Hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan langsung pada pemberian kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hukum kesehatan terdiri dari banyak disiplin, diantaranya: hukum

kedokteran, hukum keperawatan, hukum farmasi, hukum apotik, hukum kesehatan masyarakat, hukum perobatan, dan lain-lain.(Ardiani, 2020)

B. Tujuan Hukum Kesehatan

Pasal 3 UU Kesehatan No 17 tahun 2023 disebutkan bahwa penyelenggaraan kesehatan bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pasien, Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan masyarakat. Tujuan dari Hukum Kesehatan antara lain :

1. Mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman tentang hukum kesehatan dan pelayanan rumah sakit bagi staf medis, lembaga pemeriksaan dan pengobatan medis, dan rumah sakit.
2. Meningkatkan kesadaran hukum penyedia dan pengguna layanan kesehatan agar memahami dengan jelas hak dan kewajibannya.
3. Mendorong pelaksanaan praktik kedokteran/kesehatan yang selalu dan sepenuhnya berpedoman pada ketentuan undang-undang kesehatan.
4. Memberikan keahlian dalam mengantisipasi potensi permasalahan hukum di pelayanan kesehatan.

C. Perlindungan Hukum Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Hak memperoleh perlindungan hukum sejatinya sudah diatur pada UU lama, dengan hadirnya UU 17 tahun 2023 tentang Kesehatan perlindungan hukum bagi SDM Kesehatan ditambahkan dan dilengkapi.

Perlindungan hukum bagi SDM merupakan hak yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sepanjang tenaga medis dan tenaga kesehatan melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi, standar operasional prosedur.

Undang-undang no 17 tahun 2023 juga mengatur tentang:

1. Perlindungan Yang diberikan oleh rumah sakit

Rumah sakit melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas. Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.

2. Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Disiplin

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Pasien.

3. Pelindungan Untuk Peserta Didik.

Peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan berhak memperoleh bantuan hukum dalam hal terjadinya sengketa medik selama mengikuti proses pendidikan

D. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan

Menurut (R. Indonesia, 2023) tentang kesehatan , dijelaskan beberapa hal terkait perlindungan hokum bagi tenaga kesehatan sebagai berikut : Anti Bullying

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai sosial budaya, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan. • Peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan mendapat perlindungan dari kekerasan fisik, mental, dan perundungan.

1. Pelindungan Dalam Keadaan Darurat

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melaksanakan upaya Penanggulangan KLB dan Wabah berhak atas pelindungan hukum dan keamanan serta jaminan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. • termasuk pelindungan yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan investigasi dan memasuki wilayah atau mendapatkan akses kepada masyarakat tertentu yang diduga sakit akibat penyakit atau masalah Kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB, atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan Wabah

2. Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Bencana

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada bencana secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka Tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana *dikecualikan dari tuntutan ganti rugi*

- #### 3. Pelindungan Ketentaun Hukum Pasal Atas 60 UU Tindakan Kesehatan Aborsi
- Aborsi dilarang dilakukan bagi setiap aorang kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan dan hanya dapat dilakukan apabila:
- Oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
 - Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Dengan Persetujuan perempuan yang bersangkutan

- d. Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan tidak dipidana.
4. Pelindungan Hukum Di Luar Kewenangannya Bencana

Dalam keadaan tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya.
5. Pelindungan Hukum Dalam Pelaporan Tindak Pidana

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengetahui atau patut menduga adanya tindak pidana pada Pasien yang diberi Pelayanan Kesehatan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berhak melaporkannya kepada aparat penegak hukum, dan wajib mendapatkan pelindungan hukum

E. Hukum Keperawatan

Praktik keperawatan yang aman dan kompeten membutuhkan penalaran klinis dan pemahaman kerangka hukum pelayanan kesehatan, dan ruang lingkup serta standar asuhan keperawatan. Praktik perawat sering kali berada di bawah beberapa sumber dan yurisdiksi hukum pelayanan kesehatan secara bersamaan. Pemahaman implikasi hukum praktik keperawatan menuntut perawat untuk memiliki keterampilan penilaian klinis untuk melindungi hak pasien dan perawat dari liabilitas. Masyarakat mengharapkan adanya pelayanan kesehatan yang aman, terutama dari perawat yang biasanya dipersepsikan sebagai bagian dari profesi yang paling etis dan terpercaya, Seiring dengan perkembangan inovasi praktik asuhan dan teknologi pelayanan kesehatan, prinsip liabilitas, kelalaian dan malapraktik sering kali terjadi dalam situasi baru yang menantang. Oleh karena itu, seorang perawat perlu mempersiapkan praktik keperawatan dengan keterampilan yang merupakan hasil dari pemikiran kritis yang terinformasi.(Novieastari, Ibrahim, Deswani, & Ramdaniati, 2020). Untuk dapat menjalankan praktik keperawatan dengan aman, maka seorang perawat wajib memahami tentang hukum yang memayungi praktik keperawatan.

Hukum keperawatan adalah peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan atau dilarang bagi profesi perawat dalam menjalankan profesinya. Profesi perawat merupakan salah satu profesi yang termasuk dalam tenaga kesehatan yang tercantum dalam Undang-undang no 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Pada Undang-Undang Kesehatan no 17 tahun 2023 disebutkan bahwa "Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien"

F. Fungsi Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Keperawatan

Fungsi hukum dalam keperawatan, yaitu:

1. Memberi kerangka kerja untuk menetapkan kegiatan praktek perawatan apa yang legal dalam merawat pasien.
2. Membedakan tanggung jawab perawat dari profesi kesehatan lain
3. Membantu menetapkan batasan yang independen tentang kegiatan keperawatan
4. Membantu mempertahankan standar praktek keperawatan dengan membuat perawat akuntabilitas dibawah hukum yang berlaku.

Dalam melaksanakan intervensi keperawatan, selain berpegang teguh pada kode etik keperawatan, perawat harus memperhatikan hal-hal penting yang dapat melindungi perawat secara hukum. Menurut Grane (1983, dalam Kozier, Erb,1990), dalam melaksanakan tugas perawat harus :

1. Mengetahui pembagian tugas
2. Sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan di tempat kerja
3. Selalu identifikasi pasien
4. Selslu waspada
5. Melaksanakan dokumentasi secara akurat.
6. Mempertahankan hubungan saling percaya dengan klien
7. Pastikan orang yang diberi delegasi memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan

Dokumentasi Perawatan Dan Pertanggungjawaban Hukum

1. Dokumentasi keperawatan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan.
2. Dokumentasi keperawatan merupakan bukti tertulis terhadap apa yang telah dilakukan oleh perawat, yang dapat dijadikan bukti di pengadilan

Poin-poin yang harus terdapat dalam dokumentasi keperawatan yang secara hukum dapat diterima dengan prinsip-prinsip dokumentasi :

1. Dokumentasi harus akurat, singkat dan lengkap, namun tidak bertele-tele
2. Harus dapat dibaca dan jangan sampai membuat salah interpretasi bagi pembaca
3. Merupakan penulisan yang objektif dari klien, berupa yang kita lihat, dengar,bau dan dirasakan dan bukan merupakan kesimpulan dari perawat
4. Harus memuat waktu kejadian, memuat kejadian secara kronologis dan mencantumkan tanda tangan yang membuat.
5. Singkatan seharusnya tidak boleh digunakan kecuali yang lazim
6. Jika istilah medis yang digunakan, perawat harus mengerti arti sebenarnya.

7. Ditulis dengan cara yang dibenarkan secara hukum yaitu menggunakan tinta hitam, bukan pensil. Jika ada kesalahan tidak boleh dihapus tetapi dicoret dan diparaf

G. Dasar Hukum keperawatan di Indonesia.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

2. UU Kesehatan No 17 tahun 2023

Sebelum terbitnya UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan, ada undang-undang khusus yang mengatur tentang keperawatan yaitu UU No 38 tahun 2014 tentang Keperawatan. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa pengaturan Keperawatan bertujuan:

- a. Meningkatkan mutu Perawat
- b. Meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan
- c. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Perawat dan Klien
- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Pada UU No 38 tahun 2014 tentang keperawatan juga dibahas terkait bagaimana proses registrasi praktik keperawatan. Namun dengan terbitnya Undang undang no 17 tahun 2023 tentang kesehatan, maka undang-undang No 38 tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi aturan terkait dengan praktik keperawatan mengacu pada undang-undang No 17 tahun 2023 tentang kesehatan termasuk registrasi dan ijin praktik keperawatan.

Berhubungan dengan pasal 1 ayat 7 UU no 17/2023 tentang kesehatan berbunyi: "Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan."

BAB VII, pasal 197 UU No 17 tahun 2023, menyebutkan bahwa Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas: Tenaga Medis; Tenaga Kesehatan; dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf b dikelompokkan ke dalam:

- a. tenaga psikologi klinis;

- b. tenaga keperawatan;
- c. tenaga kebidanan;
- d. tenaga kefarmasian;
- e. tenaga kesehatan masyarakat;
- f. tenaga kesehatan lingkungan;
- g. tenaga gizi;
- h. tenaga keterampilan fisik;
- i. tenaga keteknisian medis;
- j. tenaga teknik biomedika;
- k. tenaga kesehatan tradisional; dan
- l. Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan terdiri atas perawat vokasi, ners, dan ners spesialis.

Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR dan berlaku seumur hidup. STR diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki ijazah pendidikan di bidang Kesehatan dan/ atau sertifikat profesi;
- b. memiliki sertifikat kompetensi.

Dalam rangka mempercepat transformasi kesehatan khususnya Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, maka atas dasar amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dibentuk Konsil Kesehatan Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Konsil Kesehatan Indonesia didukung oleh Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi (MDP).

H. Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia Dan Majelis Disiplin Profesi (MDP)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa untuk meningkatkan mutu dan kompetensi keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, dibentuk Konsil beserta alat kelengkapannya. Terdapat beberapa perubahan terhadap Konsil baik nomenklatur, struktur lembaga, maupun tugas dan fungsinya. Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang merupakan 2 (dua) lembaga terpisah, bergabung menjadi entitas baru yaitu Konsil Kesehatan Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya memiliki 2 (dua) alat kelengkapan yaitu Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi (MDP).

Konsil Kesehatan Indonesia berperan untuk merumuskan kebijakan internal dan standarisasi pelaksanaan tugas konsil, melakukan registrasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta melakukan pembinaan teknis keprofesian Tenaga Medis

dan Tenaga Kesehatan. Dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat penerima pelayanan kesehatan, maka Konsil Kesehatan Indonesia memiliki kewenangan untuk menerbitkan, menonaktifkan dan mencabut STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Untuk mengembangkan cabang disiplin ilmu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, maka tugas KKI didukung oleh Kolegium Kesehatan Indonesia yang terdiri atas 78 (tujuh puluh delapan) kolegium tiap disiplin ilmu, serta berperan dalam penyusunan standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan dan berwenang dalam penerbitan sertifikat kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Manfaat kolegium bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan adalah untuk pengembangan kompetensi yang lebih terarah dan untuk memastikan kompetensi yang dimiliki dapat senantiasa diupdate sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan sehingga bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri melainkan juga untuk masyarakat luas. Sedangkan bagi masyarakat, diharapkan mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terstandar dari tenaga medis dan tenaga kesehatan yang profesional serta merata di seluruh daerah.

Dalam melaksanakan penegakan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan maka KKI didukung oleh MDP. Beberapa fungsi dari MDP yaitu penerimaan dan verifikasi pengaduan, pemeriksaan pengaduan, penentuan ada/tidaknya pelanggaran, pengambilan putusan dan pemberian rekomendasi. Jika terdapat pengaduan pelanggaran disiplin profesi, maka MDP akan melakukan pemeriksaan. Jika terbukti memang terdapat pelanggaran disiplin, maka MDP bisa menjatuhkan sanksi. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tidak kompeten, bisa dihentikan untuk penyelenggaraan praktiknya. Selain itu MDP akan memberikan perlindungan untuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang sudah bekerja sesuai dengan standar akan mendapat perlindungan hukum. Apabila Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaporkan atas dugaan tindak pidana, MDP akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesesuaian praktik dengan standar berdasarkan permintaan dari penyidik. Jika ternyata Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan telah bekerja sesuai standar, maka MDP mengeluarkan rekomendasi untuk menghentikan penyidikan. Apabila Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan digugat perdata, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat meminta MDP untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian praktik dengan standar. Berdasarkan permintaan tersebut, MDP mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan. (K. K. Indonesia, 2024)

I. Tugas dan Wewenang Konsil Kesehatan Indonesia

Konsil Kesehatan Indonesia merupakan lembaga nonstruktural yang dalam menjalankan perannya bersifat independent, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. KKI bertugas melaksanakan dukungan peningkatan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Peran

1. Merumuskan kebijakan internal dan standardisasi pelaksanaan tugas Konsil
2. Melakukan registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan,
3. Melakukan pembinaan teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan

Wewenang

Untuk menerbitkan, menonaktifkan, dan mencabut STR Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Fungsi:

1. Pelaksanaan Registrasi dan pengelolaan data STR
2. Penetapan kompetensi yang beririsan
3. Penetapan percabangan disiplin ilmu
4. Pelaksanaan keputusan pemberian sanksi disiplin
5. Perumusan dan penetapan kebijakan internal
6. Penetapan standar kurikulum pelatihan yang disusun oleh Kolegium
7. Pelaksanaan evaluasi kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Lulusan Luar Negeri bersama Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan Kolegium
8. Pelaksanaan validasi dan pengusulan standar kompetensi yang disusun oleh Kolegium untuk ditetapkan oleh Menteri
9. Pengusulan standar profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bersama dengan Kolegium yang ditetapkan oleh Menteri
10. Pengusulan jenis dan kelompok Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan baru

J. Latihan Soal

1. Fungsi hukum dalam keperawatan :
 - A. Membatasi kewenangan perawat
 - B. Melindungi perawat dari ketika mealnggar hukum
 - C. Melindungi pasien dari tindakan yang tidak sesuai prosedur
 - D. Membedakan tanggung jawab diantara sesama perawat
 - E. Untuk menyusun standar praktik keperawatan

2. Sesuai dengan UU no 17 tahun 2023, yang menerbitkan STR adalah :
 - A. Konsil atas nama menteri kesehatan
 - B. Dinas Kesehatan
 - C. MTKI
 - D. MTKP
 - E. PPNI
3. Dalam melaksanakan intervensi keperawatan, perawat perlu memperhatikan hal-hal penting yang dapat melindungi perawat secara hukum. Pernyataan yang tidak tepat terkait hal tersebut?
 - A. Mengetahui pembagian tugas
 - B. Sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang diajarkan di institusi pendidikan
 - C. Selalu identifikasi pasien
 - D. Melaksanakan dokumentasi secara akurat.
 - E. Pastikan orang yang diberi delegasi memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan
4. Seorang perawat sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah di suatu institusi Pendidikan. Untuk menyelesaikan Pendidikannya agar mendapatkan ijazah dan nantinya bisa mengurus STR, maka tahap selanjutnya yang paling tepat dilakukan adalah:
 - A. Mengurus STR
 - B. Menjadi anggota PPNI
 - C. Mengurus Kartu anggota PPNI
 - D. Mendapatkan rekomendasi dari PPNI
 - E. Mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan serkom
5. Jika seorang perawat dilaporkan oleh keluarga pasien telah melakukan tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada pasien, maka yang bertugas untuk melakukan penyelidikan apakah perawat tersebut telah bekerja sesuai dengan standar profesi atau tidak adalah:
 - A. Pihak kepolisian
 - B. KKI
 - C. MTKI
 - D. MDP
 - E. Kolegium keperawatan

K. Kunci Jawaban

1. C
2. A
3. B

4. E
5. D

L. Rangkuman Materi

Hukum merupakan hal penting yang harus diketahui dalam pelayanan kesehatan. Hukum menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan, baik termasuk perawat, bekerja sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Hukum kesehatan secara umum mengatur segala hal terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk hak dan kewajiban pasien serta tenaga medis, perizinan fasilitas, hingga tanggung jawab hukum atas tindakan malpraktik. Sementara itu, hukum keperawatan lebih spesifik pada profesi perawat, termasuk standar praktik, etika, hak dan kewajiban perawat, serta sanksi jika terjadi pelanggaran. Hukum keperawatan sendiri mencakup segala aturan hukum yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perawat dalam praktiknya. Perawat harus memahami implikasi hukum dari tindakan mereka, termasuk liabilitas, kelalaian, dan potensi malpraktik. Pemahaman ini penting agar perawat dapat melindungi hak pasien maupun dirinya sendiri. Dasar hukum keperawatan di Indonesia mencakup UUD 1945, UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (yang kini telah dicabut), dan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang terbaru ini menjadi payung hukum utama dalam praktik keperawatan, termasuk aturan tentang STR (Surat Tanda Registrasi) dan ijin praktik yang berlaku seumur hidup. Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas registrasi, pembinaan profesi, dan penegakan disiplin tenaga medis dan kesehatan. Didukung oleh Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi (MDP), KKI memiliki wewenang menerbitkan atau mencabut STR serta memberikan perlindungan hukum. MDP juga menangani pengaduan, pemeriksaan, dan rekomendasi hukum jika terjadi pelanggaran profesi. Dengan kerangka hukum yang kuat ini, diharapkan praktik pelayanan kesehatan di Indonesia dapat berjalan lebih aman, profesional, dan terlindungi secara hukum, baik bagi tenaga kesehatan maupun pasien.

M. Glosarium

KKI: Konsil Kesehatan Indonesia

MDP: Majelis Disiplin Profesi .

STR: Surat Tanda Registrasi

N. Daftar Pustaka

Ardiani, N. D. (2020). Modul Ajar Etika Keperawatan. *Stikes Kusuma Husada Surakarta*, 1, 1–63. Retrieved from

- [http://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/676/1/Modul Ajar Etika Keperawatan.pdf](http://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/676/1/Modul_Ajar_Etika_Keperawatan.pdf)
- Indonesia, K. K. (2024). *Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia Dan Majelis Disiplin Profesi (MDP)*. Retrieved from <https://kki.go.id/page/read/profil-konsil-kesehatan-indonesia-kolegium-kesehatan-indonesia-dan-majelis-disiplin-profesi>
- Indonesia, R. Tumpah Darah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan § (2023).
- Novieastari, E., Ibrahim, K., Deswani, & Ramdaniati, S. (2020). *Dasar-dasar Keperawatan* (Indonesia). Jakarta: elsvier.
- siplawfirm. (2023). Definisi dan Pengertian Hukum Kesehatan. Retrieved from <https://siplawfirm.id/definisi-dan-pengertian-hukum-kesehatan/?lang=id>
- Zahran, Z. F. (2024). Pengertian Hukum Kesehatan: Asas, Tujuan, hingga Hak dan Kewajibannya. Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-kesehatan/>

BAB 7

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

Tujuan Instruksional:

Memahami tentang hak dan kewajiban pasien selama menjalani pelayanan keperawatan di fasilitas kesehatan.

Capaian Pembelajaran:

- Mampu memahami pengertian hak dan kewajiban pasien.
- Mampu memahami peranan hak.
- Mampu menguasai jenis-jenis hak.
- Mampu memahami syarat yang mempengaruhi hak seseorang.
- Mampu menjelaskan hak pasien.
- Mampu menjelaskan Kewajiban pasien.

Pendahuluan:

Pasien memiliki hak fundamental yang diakui secara luas dalam berbagai dokumen hak asasi manusia dan standar medis internasional. Hak-hak ini mencakup hak untuk mendapatkan perawatan medis yang layak, informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya, hak untuk memberikan persetujuan sebelum menerima tindakan medis (informed consent), serta hak atas privasi dan kerahasiaan informasi medis mereka (Naurah et al., 2024). Hak-hak ini bertujuan untuk melindungi martabat dan otonomi pasien, memastikan mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka sendiri. Namun, pasien juga memiliki kewajiban yang tidak kalah penting. Kewajiban ini mencakup memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang riwayat kesehatan dan kondisi saat ini kepada tenaga medis, mematuhi instruksi medis dan rencana perawatan yang disepakati, serta menghormati hak-hak tenaga medis dan pasien lain. Kewajiban-kewajiban ini penting untuk memastikan bahwa tenaga medis dapat memberikan perawatan yang efektif dan bahwa sumber daya kesehatan dapat digunakan secara efisien.

Hak dan kewajiban berbagai pihak dalam pelayanan kesehatan sangat penting untuk dipahami dan dihormati. Pasien, sebagai penerima utama layanan, memiliki hak untuk mendapatkan perawatan yang layak dan informasi yang jelas tentang kondisi

mereka (Faradila, 2021). Mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kesehatan yang akurat dan mengikuti instruksi medis. Keluarga pasien berhak untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan medis yang tepat bagi anggota keluarga mereka, serta untuk memberikan dukungan emosional dan logistik. Namun, mereka juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dan prosedur yang ada di fasilitas kesehatan.

Tujuan dari penulisan buku ini adalah agar mahasiswa mampu memahami dan menguasai tentang hak dan kewajiban pasien selama menjalani pelayanan keperawatan di fasilitas kesehatan. Sasaran penulisan buku ini adalah mahasiswa D III keperawatan, harapannya buku ini menjadi rujukan untuk menerapkan hak dan kewajiban pasien. Bahasan dalam buku ini meliputi : pengertian hak dan kewajiban pasien, peranan hak, jenis-jenis hak, syarat yang mempengaruhi hak seseorang, hak pasien dan kewajiban pasien. Metode pembelajaran dalam buku ini berbentuk paparan yang disusun secara sistematis sehingga memudahkan untuk pembaca dalam mempelajarinya. Pendekatan pembelajaran buku ini secara aktif dan kolaborasi sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Penggunaan buku ini sebaiknya dipelajari secara sistematis berdasarkan materi yang sudah dipaparkan.

Uraian Materi

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Pasien.

1. Pengertian Hak

Hak adalah tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan personal dengan prinsip keadilan, moralitas dan legalitas. Setiap individu memiliki hak asasi berbuat, menyatakan pendapat, memberikan sesuatu kepada seseorang, dan menerima sesuatu dari orang lain atau dari Lembaga tertentu. Dalam menuntut hak, tanggung jawab moral sangat dibutuhkan agar dapat terjalin suatu ikatan yang merupakan kontak social, baik tersurat maupun tersirat, sehingga segala sesuatunya dapat memberikan dampak yang baik (Dalami, 2010).

Semakin baik kehidupan seseorang, atau masyarakat, semakin perlu pula pemahaman tentang hak-hak tersebut agar berbentuk sikap saling menghargai hak-hak seseorang dan tercipta suasana yang damai dan tentram. Hak merupakan tuntutan terhadap sesuatu, dimana seseorang mempunyai hak terhadapnya, seperti kekuasaan dan hak-hak istimewa dan berupa tuntutan yang berdasarkan keadilan, moralitas, atau legalitas. Hak dapat dipandang dari sudut hukum dan pribadi (Fagin, 1975).

Hak mempunyai atau memberikan kekuasaan tertentu untuk mengendalikan situasi, contohnya hak untuk memperoleh apa yang diinginkan, tetapi diwajibkan untuk berperilaku sopan dalam memdapatkannya (Fromer, 1981).

Hak berdasarkan sudut pandang pribadi, telah sesuai dengan perkembangan etis, diantaranya mengatur kehidupan seseorang berdasarkan konsep benar atau salah, baik atau buruk yang ada dilingkungan tempat mereka hidup dan tinggal dalam jangka waktu tertentu.

2. Pengertian Kewajiban.

Kewajiban adalah seperangkat tanggungjawab individu untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan, supaya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan haknya.

B. Peranan Hak.

1. Hak dapat dipergunakan untuk mengekspresikan kekuasaan dalam menghadapi konflik seseorang dengan kelompok.

Contoh: seorang tenaga medis menyampaikan pada perawat bahwa ia memiliki hak untuk menginstruksikan pengobatan yang ia kehendaki pada pasiennya. Terlihat di sini bahwa tenaga medis mengekspresikan kekuasaannya

untuk memberi instruksi pengobatan pada pasien. Hal ini merupakan haknya selaku penanggung jawab medis.

2. Hak dipergunakan sebagai pembenaran dalam suatu tindakan.

Contoh : Perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatannya, mendapat masukan dikarenakan terlalu menghabiskan waktu bersama pasien. Perawat tersebut menyampaikan bahwa ia memiliki hak untuk memberikan asuhan keperawatan terbaik untuk pasien sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Hal ini perawat menunjukkan, bahwa ia memiliki hak untuk melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien/klien.

3. Hak dipergunakan dalam penyelesaian suatu perselisihan.

Seseorang seringkali bisa menyelesaikan perselisihannya dengan menuntut hak sehingga dapat diakui oleh orang lain.

Contoh: Perawat menyarankan kepada pasien untuk tidak keluar ruangan selama dalam proses perawatan. Pada situasi seperti ini, pasien menjadi marah karena tidak sesuai dengan harapannya apa yang disampaikan perawat dan pasien mengatakan bahwa ia punya hak untuk keluar ruangan sesuai dengan kemauannya.

Hal ini menunjukkan bahwa perawat dapat menerima keinginan pasien sepanjang tidak merugikan kesehatan pasien. Bila mana tidak dipenuhi kesepakatan dikarenakan membatasi pasien, berarti ia sudah mengingkari kebebasan pasien.

C. Jenis-Jenis Hak.

1. Hak Kebebasan

Hak kebebasan yang ditunjukkan sebagai hak individu untuk hidup sesuai yang dipilihnya dalam Batasan yang sudah ditentukan (Forme, 1981). Misalnya perawat wanita yang bekerja di rumah sakit, dapat menggunakan pakaian dia kehendaki (haknya) dengan syarat berwarna putih bersih dan sopan sesuai dengan batasannya. Contoh tersebut memiliki dua hal penting, antar lain :

- a. Batasan kesopanan merupakan kebijakan rumah sakit.
- b. Warna putih dan sopan adalah norma yang diterapkan untuk perawat.

2. Hak Kesejahteraan

Hak yang diberikan secara hukum sebagai standar keselamatan khusus dalam suatu bangunan atau wilayah tertentu. Misalnya, hak pasien untuk mendapatkan pelayanan keperawatan yang komprehensif, hak masyarakat untuk mendapat air bersih dan lain-lain.

3. Hak Legislatif

Hak legislatif diterapkan secara hukum berdasarkan konsep keadilan. Misalnya, seorang wanita mempunyai legal untuk tidak diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Badman dan Badman (1986), menyatakan hak legislatif memiliki empat peranan di dalam masyarakat, yakni membuat peraturan, mengubah peraturan, memberikan keputusan pengadilan atau menyelesaikan perselisihan.

D. Syarat Yang Mempengaruhi Hak Seseorang.

Badman dan Badman (1985) menjelaskan lima syarat yang dapat mempengaruhi penentuan hak individu, diantaranya sebagai berikut :

1. Kebebasan orang lain untuk menggunakan hak pilihnya, ia tidak dapat disalahkan atau dihukum ketika menggunakan haknya.
2. Contoh: Pasien memiliki hak pengobatan yang ditentukan oleh dokter, tetapi ia juga menerima atau menolak pengobatan yang akan diberikan.
3. Seseorang diberikan kemudahan dalam menggunakan haknya.
4. Contoh: Perawat memiliki tugas meyakinkan dan melindungi hak-hak pasien untuk memperoleh pengobatan.
5. Hak relevan dengan prinsip keadilan, yakni persamaan, tidak berpihak dan jujur.
6. Contoh: seluruh pasien memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pengobatan dan perawatan.
7. Hak untuk bisa dilaksanakan
8. Contoh: Di berbagai rumah sakit, penentu kebijakan memiliki tugas memastikan pemberian hak asasi manusia diberikan kepada semua pasien atau klien.
9. Jikalau hak individu bersifat membahayakan, maka hak tersebut dapat diabaikan atau tidak diterima dan yang bersangkutan diberikan kompensasi atau pengganti.
10. Contoh: Apabila pasien tertunda dari jadwal operasi dengan tidak sengaja, pasien diberikan kompensasi untuk ditempatkan dibagian awal dari jadwal operasi berikutnya(bila terjadi kekeliruan).

E. Hak dan Kewajiban Pasien

1. Hak Pasien

Dalam Pasal 276 UU Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasien mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya.
- b. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya.

- c. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu.
- d. Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah.
- e. Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis.
- f. Meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain.
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Menurut Dalami (2010), hak-hak pasien yang mendapat pengobatan dan perawatan di rumah sakit, adalah sebagai berikut :

- a. Pasien memiliki hak mempertimbangkan dan menghargai asuhan keperawatan yang akan ia terima.
- b. Pasien mempunyai hak mendapatkan informasi yang lengkap dari dokter yang menanganinya berkaitan dengan diagnosa, pengobatan dan prognosis, sehingga pasien mengerti masalah yang dideritanya.
- c. Pasien mempunyai hak mendapatkan informasi penting dan menyetujui akan dimulainya prosedur pengobatan, beserta resiko penting kemungkinan yang akan terjadi.
- d. Pasien memiliki hak memberikan penolakan terhadap pengobatan sejauh diijinkan oleh hokum dan diberikan informasi konsekuensi tindakan yang akan diterima.
- e. Pasien mempunyai hak mengetahui berbagai pertimbangan dari privasinya menyangkut program asuhan medis, konsultasi dan pengobatan yang dilakukan dengan tepat serta dirahasiakan.
- f. Pasien memiliki hak dirahasiakan semua bentuk komunikasi dan dokumentasi tentang asuhan kesehatan yang diberikan kepadanya.
- g. Pasien mempunyai hak memahami bila diperlukan rujukan ke rumah sakit lain yang lebih lengkap dan mendapatkan informasi yang lengkap alas an rujukan tersebut, serta rumah sakit yang menjadi tempat rujukan harus menerimannya.
- h. Pasien mempunyai hak mengetahui informasi tentang hubungan rumah sakit dengan instansi lain.
- i. Pasien mempunyai hak mendapatkan informasi tentang pendelegasian dari dokternya kepada dokter lain, jika diperlukan dalam rangka perawatannya.
- j. Pasien mempunyai hak mengetahui yang jelas tentang biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan dan perawatan dirinya.
- k. Pasien mempunyai hak untuk mengetahui peraturan atau ketentuan rumah sakit yang harus dipatuhi sebagai seorang pasien selama perawatan.

Hak pasien juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap layanan kesehatan dan yang penting besarnya partisipasi mereka dalam pembuatan perencanaan asuhan.
 - b. Meningkatnya angka kejadian malpraktik yang terjadi di masyarakat.
 - c. Adanya perundang-undangan yang dibuat untuk melindungi hak-hak asasi pasien.
 - d. Masyarakat menyadari adanya peningkatan jumlah Pendidikan dalam bidang kesehatan dan menggunakan pasien sebagai objek atau tujuan Pendidikan, dan apabila pasien tidak ikut berpartisipasi apakah akan mempengaruhi mutu asuhan atau tidak.
2. Sedangkan dalam Pasal 277 UU Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kewajiban pasien antara lain:
- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
 - b. Mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
 - c. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan
 - d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Menurut Dalami (2010), kewajiban pasien selama pengobatan dan perawatan di rumah sakit, adalah sebagai berikut :

- a. Pasien atau keluarga memiliki kewajiban mentaati semua peraturan dan tata tertib yang ada di fasilitas kesehatan tersebut.
- b. Pasien berkewajiban mematuhi segala kebijakan yang ada, baik dari dokter maupun perawat yang memberikan perawatan.
- c. Pasien atau keluarga mempunyai kewajiban memberikan informasi secara lengkap dan sejujur jujurnya mengenai penyakit yang sedang dideritanya kepada dokter atau perawat.
- d. Pasien atau keluarga yang bertanggungjawab terhadapnya, mempunyai kewajiban menyelesaikan pembiayaan pengobatan, perawatan dan pemeriksaan yang dibutuhkan selama dirawat.
- e. Pasien dan Keluarga memiliki kewajiban memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya

F. Latihan

Pilihan Ganda

1. Tuntutan seseorang terhadap sesuatu yang merupakan kebutuhan personal dengan prinsip keadilan, moralitas dan legalitas, disebut ?
 - A. Hak
 - B. Kewajiban

- C. Etika
 - D. Norma
 - E. Etiket
2. Seperangkat tanggungjawab individu untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan, supaya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan haknya.
 - A. Hak
 - B. Kewajiban
 - C. Etika
 - D. Norma
 - E. Etiket
 3. Peran hak dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat adalah sebagai berikut, kecuali :
 - A. Hak dapat dipergunakan untuk mengekspresikan kekuasaan dalam menghadapi konflik seseorang dengan kelompok.
 - B. Hak dipergunakan sebagai pembenaran dalam suatu tindakan.
 - C. Hak dipergunakan dalam penyelesaian suatu perselisihan.
 - D. Hak digunakan untuk mencegah terjadinya konflik.
 - E. Hak digunakan untuk mengintimidasi orang lain.
 4. Hak yang diberikan secara hukum sebagai standar keselamatan khusus dalam suatu bangunan atau wilayah tertentu. Misalnya, hak pasien untuk mendapatkan pelayanan keperawatan yang komprehensif, hak masyarakat untuk mendapat air bersih dan lain-lain :
 - A. Hak kebebasan
 - B. Hak Kesejahteraan
 - C. Hak Legislatif
 - D. Hak kekuasaan
 - E. Hak memilih
 5. Hak Pasien dalam Pasal 276 UU Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasien mempunyai hak adalah sebagai berikut:
 - A. Mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya.
 - B. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
 - C. Mematuhi nasihat dan petunjuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
 - D. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan
 - E. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Essay

1. Sebutkan peran hak individu dan berikan contohnya?
2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis hak?
3. Jelaskan syarat yang dapat mempengaruhi hak seseorang dalam kehidupan sehari-hari?
4. Sebut faktor-faktor yang akan mempengaruhi hak dalam sebuah proses kehidupan manusia?
5. Jelaskan kewajiban pasien dan keluarga selama dalam proses pengobatan dan perawatan di rumah sakit?

G. Kunci Jawaban

Pilihan Ganda

1. A
2. B
3. E
4. B
5. A

H. Rangkuman Materi

Pasien memiliki hak fundamental yang diakui secara luas dalam berbagai dokumen hak asasi manusia dan standar medis internasional. Hak-hak ini mencakup hak untuk mendapatkan perawatan medis yang layak, informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya, hak untuk memberikan persetujuan sebelum menerima tindakan medis (informed consent), serta hak atas privasi dan kerahasiaan informasi medis mereka.

Dalam menuntut hak, tanggung jawab moral sangat dibutuhkan agar dapat terjalin suatu ikatan yang merupakan kontak social, baik tersurat maupun tersirat, sehingga segala sesuatunya dapat memberikan dampak yang baik.

Namun, pasien juga memiliki kewajiban yang tidak kalah penting. Kewajiban ini mencakup memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang riwayat kesehatan dan kondisi saat ini kepada tenaga medis, mematuhi instruksi medis dan rencana perawatan yang disepakati, serta menghormati hak-hak tenaga medis dan pasien lain. Kewajiban-kewajiban ini penting untuk memastikan bahwa tenaga medis dapat memberikan perawatan yang efektif dan bahwa sumber daya kesehatan dapat digunakan secara efisien.

I. Glosarium

Moralitas: serangkaian nilai dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam interaksi sosial. Moralitas merupakan dasar keyakinan individu atau komunitas dalam menentukan apa yang baik dan salah.

Legalitas: pengakuan hukum terhadap suatu usaha. Legalitas usaha merupakan syarat untuk menjalankan usaha secara aman dan nyaman.

Komprehensif: menggambarkan sesuatu yang menjelaskan informasi secara lengkap, luas, dan rinci. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti karya ilmiah, teks berita, dan percakapan.

KLB: (Kejadian Luar Biasa) status yang diberikan pada penyakit yang merebak dan berpotensi menjadi wabah

Wabah: kondisi ketika jumlah kasus penyakit menular meningkat secara tiba-tiba melebihi kondisi normal. Wabah dapat terjadi pada sekelompok orang atau bahkan di seluruh benua.

J. Daftar Pustaka

Amelia, N. (2013). Prinsip Etika Keperawatan. D Medika : Yogyakarta.

Dalami, E. (2010). Etika Keperawatan. CV. Trans Info Media : Jakarta Timur

Faradila, D. (2021). Tinjauan Yuridis Hak Pasien Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Yang Bersistem Rujukan Berjenjang. repository.unhas.ac.id. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5575/>

Massa, K. (2018). Etika Keperawatan Peraturan, Kebijakan Dan Undang-Undang Praktik Keperawatan. Trans Info Media : Jakarta.

Mendri, N K. (2020). Etika Profesi dan Hukum Keperawatan. Pustaka Baru Press : Yogyakarta.

Naurah, G., Simarmata, M., & Sidi Jambak, R. (2024). Hak dan Privasi Pasien Rumah Sakit di Era Digitalisasi. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(12), 4798–4805. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i12.1295>

PROFIL PENULIS



Toto Harto, M.K.M. Lahir di Tuguharum, 27 Februari 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Keperawatan, Akademi Keperawatan Al-Ma'arif Baturaja lulus tahun 2011. Pendidikan S1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Ma'arif Baturaja dan lulus tahun pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 pada Universitas Sriwijaya dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 sampai saat ini yaitu bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Ma'arif Baturaja mengampu mata kuliah Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan reviewer jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: totoharto27@gmail.com. Motto: "Bersungguh- sungguhlah, maka kebaikan akan datang"



Wartini Setiawati S.Kep., Ners., M.Kep., lahir di Cimahi tanggal 28 mei 1979. Memulai Pendidikan pada Sekolah Akademi keperawatan Pajajaran DepKes RI di Bandung (2000) ,kemudian melanjutkan Pendidikan di S1 Keperawatan dan Profesi di STiKes Budi Luhur Cimahi (2015). Dilanjutkan S2 Magister Manajemen Keperawatan di FitKes Unjani (2020). Pengalaman organisasi berawal sebagai ketua DPK PPNI RS Mitra Anugerah Lestari Cimahi (2006 - 2016), Pengurus DPD PPNI Kota Cimahi Sekretaris II (2017 s/d 2022), Pengurus DPD PPNI Kota Cimahi Bendahara I (2022 s/d 2027) , anggota Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK) DPW PPNI Jawa Barat (2022 s/d 2027), Pengurus HPMI (Himpunan Perawat Manager Indonesia) Propinsi Jawa Barat. Dan saat ini sebagai anggota Kredensial Organisasi Profesi Perawat di Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Riwayat Pekerjaan di RS Mitra Kasih (2000-2003) , RS Mitra Anugrah Lestari (2004 - saat ini). Pernah memegang jabatan sebagai kepala unit rawat inap dan unit khusus IGD (2005 – 2010) sebagai Kepala Bidang Keperawatan (2010 – 2015) lalu Ketua Komite Keperawatan (2015 - 2017) sebagai Kepala Bidang keperawatan kembali (2017 – Sekarang) saat ini selain sebagai kepala bidang Keperawatan sebagai Asesor Klinik dan preceptor Klinik yang bersertifikasi serta sebagai Pengajar di Sekolah Tinggi Kesehatan Kota Cimahi dengan mata kuliah yang diampu adalah Manajemen Keperawatan.

PROFIL PENULIS



Erni Chaerani, S.Pd., S.Kep., MKM., Lahir di Jakarta, 15 Juni 1968. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan Akper Depkes RI Jakarta tahun 1990, jenjang S1 Jurusan Ilmu Pendidikan IKIPN Singaraja Bali tahun 2002, S1 pada Program Studi Keperawatan, Institut Citra Internasional Bangka Belitung tahun 2024. Pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus tahun 2014. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 sebagai guru di SPK Harapan Kita Jakarta. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Keperawatan Maternitas, Keperawatan Keluarga. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ernichaerani15@gmail.com



Santi Wahyuni, SKp., M.Kep., Sp.Mat., Lahir di Bandung, 05 Januari 1977. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Magister Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia dan lulus tahun 2007 serta Program Spesialis-1 Keperawatan Maternitas, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2008. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 sebagai staf pengajar di Akademi Perawat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan melaksanakan program magang di RSUD Kabupaten Sumedang selama 1 tahun. Penulis sejak Mei 2002 hingga saat ini bekerja sebagai pengajar di Program Studi Keperawatan Cirebon, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Penulis mengampu mata Keperawatan Maternitas, Konsep Dasar Keperawatan, Keperawatan Dasar, Metodologi Keperawatan, Metodologi Penelitian, Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, reviewer soal uji kompetensi nasional, publikasi artikel ilmiah dalam jurnal nasional maupun internasional, aktif mengikuti kegiatan ilmiah seperti pelatihan, workshop dan seminar. Penulis sebagai pendiri dan pembina Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIKMA) SPIRIT, Asesor LAM-PT Kes, Auditor Audit Mutu Internal (AMI) Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Pengurus DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Cirebon, Pengurus Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI) Jawa Barat, Pengurus Yayasan Ahnaf Maulana Nafi, serta tergabung dalam tim vaksinator dan tim Health and Disaster (HADE) Center dari Center of Excellence (CoE) Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: santiwahyuni@dosen.poltekkestasikmalaya.ac.id
Motto: "Kesuksesan sejati diraih dengan sabar, diwarnai dengan keikhlasan, dan diukir dengan ikhtiar."

PROFIL PENULIS



Ns. Ni Luh Kompyang Sulisnadewi, M.Kep., Sp.Kep.An., Lahir di Badung, 22 Juni 1974. Karir sebagai perawat dimulai setelah penulis menyelesaikan pendidikan DIII keperawatan tahun 1996 di Pendidikan Ahli Madya Keperawatan Denpasar. Penulis pernah bekerja di RSU Surya Husada, RSUP Sanglah dan sampai saat ini sebagai Dosen di Poltekkes Kemenkes Denpasar Jurusan Keperawatan. Penulis tertarik pada bidang anak dan memilih bergabung di tim dosen pengampu mata kuliah keperawatan anak. Penulis melanjutkan Pendidikan Sarjana Keperawatan dan profesi Ners di PSIK FK Universitas Brawijaya, dan menyelesaikan Pendidikan pada tahun 2003. Tahun 2009, penulis melanjutkan Pendidikan ke program megister keperawatan di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan ke program spesialis keperawatan anak di tempat yang sama, dan menyelesaikan Pendidikan tahun 2012. Penulis memiliki kepakaran di bidang keperawatan anak. Namun penulis juga terlibat dalam pengajaran mata kuliah etika keperawatan. Penulis sudah menerbitkan beberapa modul terkait keperawatan anak. Sebagai bagian dari tri darma perguruan tinggi, penulis telah melakukan beberapa penelitian, pengabmas dan publikasi fokus pada bidang anak. Penulis juga aktif dalam organisasi yang bergerak di bidang keperawatan anak. Saat ini penulis menjabat sebagai ketua Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI) Propinsi Bali. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sulisnadewi337@gmail.com



Ns. Nevi Kuspiana Lesmana, M.Kep., Lahir di Cimahi, 06 Juni 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 di Universitas Pajajaran dan Profesi Ners di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1998 - 2000 sebagai perawat di UGD RS Dustira Cimahi. Saat ini penulis bekerja di Akademi Keperawatan Buntet Pesantren Cirebon mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan, Etika dan Hukum Keperawatan, Pendidikan Anti Korupsi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nevilesmana@gmail.com
Motto: "Allah Yang Maha Segalanya"



Ns. H. M. Yamin, SKM., S.Kep., M.Kes., lahir di Palembang tanggal 27 Januari 1974 , bertempat di J.Tanah Merah No.33A Palembang , Penulis menempuh pendidikan kesehatan dimulai dari SPK Kesdam II/Sriwijaya tahun 1992 dilanjutkan D3 Keperawatan, Sarjana kesehatan masyarakat, sarjana keperawatan, profesi Ners dan magister kesehatan masyarakat , penulis saat ini merupakan tenaga dosen tetap di STIKES HESTI WIRA SRIWIJAYA Penulis sudah menulis beberapa buku Keperawatan , motto penulis Hidup ini singkat mari kita berbuat untuk membuat hidup kita bermakna bagi sesama....

Buku ajar "Etika Keperawatan" disusun untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip etik, moral, dan legal yang mendasari praktik keperawatan di Indonesia. Buku ini secara sistematis membahas berbagai topik penting seperti konsep nilai, norma, etik, dan moral yang menjadi dasar perilaku profesional seorang perawat. Selain itu, pembaca akan memperoleh wawasan tentang aspek legal yang mengatur praktik keperawatan serta sistem kredensial yang berlaku di Indonesia. Buku ini juga menjelaskan secara rinci mengenai tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah etik, dilengkapi contoh kasus nyata yang memudahkan pemahaman terhadap berbagai dilema yang mungkin dihadapi dalam praktik sehari-hari.

Lebih lanjut, buku ini menguraikan hak dan tanggung jawab perawat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang serta pentingnya memahami dan menerapkan Kode Etik Keperawatan Indonesia. Materi hukum kesehatan dan keperawatan serta penjelasan tentang hak dan kewajiban pasien juga dibahas secara komprehensif, bertujuan untuk membantu perawat memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan berkeadilan.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan disajikan secara jelas, buku ini diharapkan menjadi referensi utama bagi mahasiswa keperawatan, dosen, dan praktisi yang ingin memperkuat kompetensi etika dan legal mereka dalam menjalankan tugas profesional.

Buku ajar "Etika Keperawatan" disusun untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip etik, moral, dan legal yang mendasari praktik keperawatan di Indonesia. Buku ini secara sistematis membahas berbagai topik penting seperti konsep nilai, norma, etik, dan moral yang menjadi dasar perilaku profesional seorang perawat.

Selain itu, pembaca akan memperoleh wawasan tentang aspek legal yang mengatur praktik keperawatan serta sistem kredensial yang berlaku di Indonesia. Buku ini juga menjelaskan secara rinci mengenai tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah etik, dilengkapi contoh kasus nyata yang memudahkan pemahaman terhadap berbagai dilema yang mungkin dihadapi dalam praktik sehari-hari.

Lebih lanjut, buku ini menguraikan hak dan tanggung jawab perawat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang serta pentingnya memahami dan menerapkan Kode Etik Keperawatan Indonesia. Materi hukum kesehatan dan keperawatan serta penjelasan tentang hak dan kewajiban pasien juga dibahas secara komprehensif, bertujuan untuk membantu perawat memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan berkeadilan.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan disajikan secara jelas, buku ini diharapkan menjadi referensi utama bagi mahasiswa keperawatan, dosen, dan praktisi yang ingin memperkuat kompetensi etika dan legal mereka dalam menjalankan tugas profesional.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta